PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI
Macroproceso: xxxxxxx
Proceso: Atención Interdisciplinaria
Norma: Norma para Atención Interdisciplinaria Código: PCD-ID-N-06

Acción	Rol	Nombre completo	Firma electrónica
Preparado por:	Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo	Ana Zelmira Arias Montero	
	Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Wendy Camacho Salas	
		Rebeca Porras Jiménez	
Revisado por:	Jefe Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Natalia Campos Bello	
Revisado por:	Jefe Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo	Xiomara Molina Retana	
Revisado por:	Directora Técnica		
Alineamiento institucional:	Unidad de Planificación Estratégica e Institucional	Kattia Quesada Giütta	
Aprobado por:	Directora Nacional de CEN-CINAI	María Marta Carballo Arce	
Versión N°: 1	Fecha de emisión:	DD/MM/AAAA	DNCC-OF-XXXX-202X

En revisión

Participantes en la realimentación y validación interna del procedimiento:

Nombre	Unidad Organizativa/Región	Disciplina
Alina Gamboa Segura	UIVCD	Nutrición
Rocío Tafalla Bermúdez	UIVCD	Trabajo Social
Stephannie Vargas Villalobos	UIVCD	Nutrición
Ana Cecilia Castillo Vásquez	UNAT	Nutrición
Karla Salazar Mora	UNAT	Nutrición
Bernardita Sanabria Jiménez	UNAT	Terapia Física

En revisión

Tabla de Contenidos

I. ASPECTOS GENERALES. 5
1.1 Introducción 5
1.2 Alcance 6
1.3. Responsables 6
1.4. Definiciones 8
1.5 Abreviaturas 15
1.6 Referencias (Pendiente de revisión al final) 15
II. CADENA DE RESULTADOS. 17
2.1 Resultados antecesores 17
2.2 Frecuencia 17
2.3 Factores de Éxito 17
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS. 18
3.1 Actividades previas a la atención interdisciplinaria 19
3.2 Actividades relacionadas con la solicitud de apoyo especializado 22
3.2.1. Actividades relacionadas con la atención interdisciplinaria por parte del Equipo de OL. 23
3.2.2. Actividades relacionadas con la Atención Inmediata por emergencia. 30
3.2.3. Actividades relacionadas con la Atención Inmediata por Urgencia 33
IV. AUTOEVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO 38
4.1 Formulario para la autoevaluación y supervisión 39
4.2 Producto 40
4.3 Resultados 40
4.4. Actualización del procedimiento. 40
V. DISPOSICIONES. 41
Disposición 1. Atención interdisciplinaria en CEN-CINAI desde un enfoque de Salud Pública 41
Disposición 2: ¿Qué informar a los padres de familia de la Atención Interdisciplinaria en CEN-CINAI? 44
Disposición 3: Acciones referentes al contenido, conformación y traslado del expediente de A.I. 46
Disposición 4: Tipos de atención relacionadas con la solicitud de apoyo especializado. 49
Disposición 5: Acciones ante la detección de niñas y niños con malnutrición 55
Disposición 6: Acciones y consideraciones previo a la realización de la referencia al A.I 57
Disposición 7: Sesión interdisciplinaria 59
Disposición 8: Criterios para la priorización en A.I. 61
Disposición 9: Consideraciones para realizar referencias insterinstitucionales y/o denuncias 66
Disposición 10: Acciones generales y específicas que realizan profesionales de E.I. en la A.I. 70
Disposición 11. Estrategias para la atención interdisciplinaria 77
VI. ANEXOS 85
Anexo 1. Flujograma de las acciones en el proceso de atención interdisciplinaria. 85
Anexo 2a. Boleta de referencia de atención interdisciplinaria. 86
Anexo 2b. Instructivo Boleta de referencia al A.I. 89
Anexo 3b. Instructivo Boleta de referencia interinstitucional 91
Anexo 4a. Boleta de Contra- Referencia interinstitucional 93
Anexo 4b. Instructivo Boleta de Contra- Referencia interinstitucional 94
Anexo 5a. Boleta de denuncia 96
Anexo 5b. Instructivo boleta de denuncia 98
Anexo 6. Carátula expediente de A.I. 101
Anexo 7 a. Boleta valoración situacional 102
Anexo 7b. Instructivo Boleta valoración situacional 103
Anexo 8. Formato de Minuta de la sesión interdisciplinaria 104
Anexo 9. Reporte de atención interdisciplinaria 105
Anexo 10. Guía de revisión de la herramienta 105
Anexo 11a. Registro de eventos y situaciones 105
Anexo 11b. Instructivo Registro de eventos y situaciones 106
Anexo 12a. Boleta de notificación obligatoria VE-01 107
Anexo 12b. Instructivo Boleta de notificación obligatoria VE-01 108

En revisión

En revisión

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1 Introducción

Con fundamento en la Normativa para la Atención Interdisciplinaria en la Dirección Nacional de CEN-CINAI (código PCD-ID-N-06, DNCC, 2021), toda niña o niño, adolescente madre, mujer embarazada o en periodo de lactancia, inscritos en los servicios de CEN-CINAI, debe recibir atención oportuna y seguimiento por parte de las personas profesionales destacadas en los equipos interdisciplinarios de las Oficinas Locales y Áreas Técnicas Regionales. Esta atención se brinda cuando se identifican necesidades de apoyo profesional en el crecimiento, desarrollo, salud o en el entorno social de las niñas, niños y beneficiarias, con el propósito de fortalecer su salud de manera integral y segura, promover el ejercicio pleno de sus derechos y la participación activa, así como su calidad de vida.

La interdisciplinariedad es la aplicación articulada de conocimientos, metodologías y perspectivas provenientes de distintas disciplinas y campos del saber, para el abordaje integral de un tema, problema, experiencia o situación, lo que permite una comprensión más amplia e integrada. Este accionar requiere trabajo en equipo, cooperación y diálogo entre las personas profesionales, con el fin de atender y brindar respuestas oportunas y efectivas.

De acuerdo con la normativa vigente, la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI comprende las intervenciones que realizan profesionales de diversas áreas, tanto a nivel individual como grupal, orientadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención del crecimiento, desarrollo y salud de niñas, niños y beneficiarias de los servicios. Entre los aspectos que se abordan en la intervención interdisciplinaria se encuentran las relacionadas con malnutrición, rezago o riesgo de retraso en el desarrollo, signos de alerta en las áreas auditivo, visual o de salud oral detectados en los tamizajes. También, se contemplan otras situaciones de riesgo o vulnerabilidad biopsicosocial identificadas en niñas, niños, mujeres adolescentes y adultas embarazadas o en periodo de lactancia.

La atención interdisciplinaria incluye la formulación de recomendaciones dirigidas al grupo familiar desde un abordaje integral, además abarca, la articulación, coordinación, referencia y contrarreferencia oportuna de casos entre instituciones, que, según sus competencias, realizan un abordaje y seguimiento específico.

Lo anterior es consecuente con lo indicado en la Ley 8809, Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, y el Reglamento Orgánico (Decreto Ejecutivo N° 37270-S), en los que se establecen como objetivos institucionales, la prestación de servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil desde un Enfoque de Salud Pública, desde el cual se enfatiza la importancia de abordar los determinantes sociales de la salud, empoderar a las comunidades y promover el bienestar a lo largo del curso de la vida.

Este enfoque se encuentra alineado con los compromisos internacionales en materia de promoción de la salud tales como la Declaración Alma Ata (1978), la Carta de Ottawa (1986), la Declaración de Shanghái (2016), la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, referidos en la Estrategia y Plan de Acción sobre la Promoción de la Salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030. Asimismo, la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI se orienta por enfoques que guían el accionar institucional, tales como lo son el Enfoque de Derechos Humanos, Enfoque Centrado en la Familia (ECF), Enfoque Étnico Racial, Enfoque de interseccionalidad y la corresponsabilidad compartida en el hogar. Estas iniciativas fomentan el empoderamiento de la población para la toma de decisiones informadas y la equidad en salud.
Partiendo de lo descrito anteriormente, en el análisis y la intervención interdisciplinaria, las personas no se consideran de forma aislada, sino inmersas en el marco de relaciones e interacciones que mantienen con su familia, amistades, vecinos, comunidad y demás redes de apoyo en los sistemas en los que se desenvuelven (barrio, la escuela, el trabajo la comunidad y la sociedad en general).

El presente procedimiento tiene como propósito orientar a las personas funcionarias en la atención interdisciplinaria oportuna e integral que se brinda en la institución. Además, integra lo establecido en el Procedimiento para la atención interdisciplinaria del niño o niña con malnutrición (código PRO-AI-AIM-P-01, versión 02 del 2020), conformando así un único documento denominado *"Procedimiento para la Atención Interdisciplinaria en la Dirección Nacional de CEN-CINAI".*

1.2 Alcance

Este procedimiento responde al servicio de Promoción, Crecimiento y Desarrollo de CEN-CINAI, por lo que su ámbito de aplicación involucra a equipos interdisciplinarios de profesionales a nivel local y regional con apoyo de todas las personas funcionarias, mediante la implementación de estrategias de atención interdisciplinaria desde un Enfoque de Salud Pública que permitan la detección, atención y seguimiento oportuno de clientes, beneficiarias y su grupo familiar, en las estrategias intra y extramuros, cuando se identifiquen necesidades en su crecimiento, desarrollo y salud que requieran de apoyo profesional.

En revisión

Como parte del compromiso institucional con la protección de los derechos de las personas que reciben servicios en CEN-CINAI, y en concordancia con el ejercicio profesional ético establecido por cada colegio profesional, la actuación de las personas profesionales deberá regirse por dichos principios, garantizando una atención respetuosa, responsable y centrada en el bienestar integral de la población beneficiaria.

Asimismo, todas las personas que laboran en la institución deberán demostrar, en el ejercicio de sus funciones:

- **Ética, respeto y calidad**: actuando con apego a los principios éticos y demostrando respeto, sensibilidad y calidad en la implementación de este procedimiento.

- **Confidencialidad y resguardo de la información:** asumiendo la responsabilidad y el compromiso de mantener la confidencialidad sobre la información sensible o privada de las personas atendidas. La información obtenida deberá ser utilizada única y exclusivamente para los fines relacionados con la atención interdisciplinaria brindada. En consecuencia, queda prohibido revelar, comentar, divulgar a terceros cualquier información adquirida en el ejercicio de las funciones institucionales.

- **Responsabilidad legal:** conocer y aceptar la responsabilidad legal que implica el ejercicio de su cargo, en especial ante cualquier uso indebido, divulgación no autorizada o manipulación inadecuada de la información obtenida durante la atención.

- **Cumplimiento a la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, N° 8968,** la cual tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.

1.3. Responsables

Nivel Nacional:

La **Dirección Técnica**, a través de la Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo y de la Unidad de Normalización y Asistencia Técnica, es la responsable de elaborar y conducir la adecuada ejecución de los lineamientos técnicos, criterios, instrumentos u otros, para la implementación del Procedimiento de Atención Interdisciplinaria, conforme lo estipulado en la Ley 8809 Ley Creación de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, el Reglamento Orgánico y el marco jurídico vigente. Asimismo, ambas unidades brindan asistencia técnica y supervisión capacitante, monitoreo, seguimiento para la aplicación con calidad y oportunidad de este procedimiento.

Nivel Regional:

Persona Directora Regional:

- Dirige y garantiza el adecuado cumplimiento del presente procedimiento según la programación de las tareas específicas para la A.I. por parte de los equipos de profesionales de las Oficinas Locales y ATE (cuando así se requiera), alineado con los valores institucionales, la transparencia, oportunidad y calidad de las acciones que forman parte de este procedimiento.
- Supervisa el cumplimiento del procedimiento a través del Área Técnica Regional.

Jefatura de Área Técnica de la Región:

- Conduce con calidad y calidez al equipo interdisciplinario de Área Técnica, en su labor de asesoría técnica y supervisión capacitante al equipo interdisciplinario del nivel local para el cumplimiento de este procedimiento.
- Analiza y evalúa la información generada por el equipo interdisciplinario a su cargo, toma decisiones en procura de la calidad de la atención interdisciplinaria que se brinda y mantiene una comunicación constante con sus superiores según corresponda.
- Dirige y participa en el monitoreo y seguimiento para la toma decisiones en procura de la calidad y cobertura de la población referida para la atención interdisciplinaria.
- Analiza y elabora informes para enviar a nivel regional y nacional en cumplimiento de las acciones de la atención interdisciplinaria.

Profesional del equipo interdisciplinario de cada Área Técnica Regional:

- Brindar asesoría técnica y supervisión capacitante a las personas funcionarias de los equipos interdisciplinarios en las oficinas locales, en los temas requeridos para fortalecer las competencias y garantizar una atención técnica, integral e interdisciplinaria de calidad. A su vez participa e interviene en la atención de casos cuando se requiera.
- Participa en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento del presente procedimiento.
- Analiza y evalúa la información brindada por las Oficinas Locales en la implementación de estrategias para la atención interdisciplinaria con Enfoque de Salud Pública según corresponda.
- Realiza acciones para fortalecer las coordinaciones interinstitucionales para la oportuna referencia, atención y denuncias ante las instituciones correspondientes cuando se requiere.

En revisión

Nivel Local:

Jefatura de Oficina Local:

- Dirige al equipo interdisciplinario de profesionales de la Oficina Local, a las personas funcionarias ASSC3, profesionales AII de establecimiento, ASSC2 y otras en cargos homólogos por contratación, en la implementación del procedimiento.
- Planifica la implementación eficiente, efectiva y con calidad de este procedimiento, según la programación, monitoreo y seguimiento de las tareas específicas a realizar por parte del equipo interdisciplinario del nivel local.

Profesional del equipo interdisciplinario de cada Oficina Local:

- Ejecuta las tareas que incluye el presente procedimiento para la atención interdisciplinaria de situaciones o casos de clientes, beneficiarias y su grupo familiar en riesgo biopsicosocial, desde un Enfoque de Salud Pública.
- Realiza la detección de situaciones o casos de clientes, beneficiarias y su grupo familiar con factores de riesgo biopsicosocial.
- Realiza la atención mediante estrategias interdisciplinarias, seguimiento, referencia interinstitucional y contra-referencia, así como las denuncias ante las instituciones correspondientes, según se requiera en situaciones de clientes y beneficiarias en riesgo biopsicosocial.
- Da acompañamiento técnico, apoyo y orientación a las personas funcionarias en establecimiento para la implementación de estrategias intra y extramuros que son parte de la atención interdisciplinaria.

Persona funcionaria de establecimiento y cargos homólogos por contratación:

- Realiza la detección de situaciones o casos de clientes, beneficiarias y su grupo familiar con factores de riesgo biopsicosocial.
- Realiza las referencias para la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI, a sea a nivel interinstitucional en casos que requieren de atención de otras instituciones, así como las denuncias ante las instituciones correspondientes, según se requiera.
- Apoya en la implementación de estrategias para la promoción del crecimiento, desarrollo y salud acordes con las necesidades de clientes, beneficiarias y su grupo familiar, asignadas por el E.I. de Oficina Local o Regional como parte de la atención interdisciplinaria.

Toda persona funcionaria de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, incluyendo los cargos homólogos por contratación e integrantes del Comité CEN-CINAI, puede realizar la identificación y/o detección de casos con riesgo biopsicosocial y referirlo al equipo interdisciplinario de la Oficina Local, así como realizar las denuncias necesarias ante las instituciones correspondientes según la normativa vigente.

1.4. Definiciones

- **Adolescente madre:** Desde el enfoque de salud y como lo indica la Organización Mundial de la Salud, se considera como adolescentes madres aquellas mujeres embarazadas o ya madres con edades entre los 10 años y los 19 años, 11 meses y 29 días.

- **Atención Interdisciplinaria**: Intervención de equipos interdisciplinarios, profesionales y técnicos, a nivel individual o grupal, [familiar, comunitaria] para la promoción del crecimiento y desarrollo de las y los clientes, beneficiarias y beneficiarios de los servicios, con necesidades de apoyo especial (Decreto Ejecutivo Nº 37270– S, 2012). La atención interdisciplinaria es la acción coordinada de las personas profesionales de los equipos interdisciplinarios orientada a brindar apoyo específico para la promoción de prácticas saludables, desarrollo y fortalecimiento de factores protectores de la salud física y psicosocial, así como una atención oportuna de clientes y beneficiarias cuando se identifican factores de riesgo en el crecimiento, desarrollo y salud considerando los determinantes y condicionantes sociales así como la realidad de cada familia. Este accionar se realiza con la activa participación de una o más personas integrantes del grupo familiar cuando se requiera, reconociéndolos como agente clave en la atención brindada. Lo anterior, se desarrolla desde un Enfoque Integral en Salud Pública, Enfoque Centrado en la Familia y Enfoque de corresponsabilidad compartida en el hogar.

- **Beneficiarias:** Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, que se benefician con acciones brindadas por la Dirección Nacional de CEN-CINAI (Decreto Ejecutivo Nº 37270– S, 2012).

- **Beneficiarios**: Familias de clientes y comunidad en general que se benefician con acciones brindadas por la Dirección Nacional de CEN-CINAI (Decreto Ejecutivo Nº 37270– S, 2012).

- **Calidad de la atención:** Consiste en las gestiones, implementación de principios, normativas, buenas prácticas, mejoras continuas, entre otros, orientadas a buscar el bienestar y la satisfacción de las personas usuarias. Para ello, se procura que la atención sea consecuente con las necesidades y expectativas en el marco de las funciones en la Dirección Nacional de CEN-CINAI, según lo establecido en la Ley 8809, dedicando tiempo y esfuerzo a la ejecución de las tareas en forma estandarizada en el marco de los procedimientos (DNCC, 2022).

- **Calidez:** Actitud de escucha, respeto, solidaridad y tolerancia que promueve un trato digno a las personas atendidas en los servicios de salud (CCSS, 2015).

En revisión

- **Confidencialidad:** Implica que toda persona funcionaria que obtenga información acerca de la salud o la vida privada de las niñas, los niños y sus familias de manera directa o indirecta, explícita o implícita, tienen el deber de disponer de todos los medios para que dicha información no sea divulgada y la prohibición de usarla en provecho propio. Implica también que se respete el carácter confidencial, salvo cuando deba informarse a las autoridades respectivas por su competencia, cuando la información acarrea daño a las personas usuarias o a terceros (Adaptado de CCSS, 2018).

- **Contra-referencia:** Es la respuesta a la institución que envió de manera inicial la referencia. Indica lo relacionado con la atención, acciones solicitadas, intervenciones realizadas, indicaciones, recomendaciones u observaciones, a fin de asegurar el seguimiento de la atención integral.

- **Corresponsabilidad compartida en el hogar:** Principio que establece que las tareas de cuidado —incluyendo la crianza infantil, la atención a personas mayores o con dependencia, y el trabajo doméstico no remunerado— constituyen una responsabilidad colectiva de todas las personas integrantes del núcleo familiar, independientemente de su género. Este enfoque busca redistribuir de manera equilibrada la carga de cuidado y garantizar el bienestar integral familiar. En consonancia con lo establecido por ONU Mujeres, la participación en las labores domésticas y de cuidado no constituye una "ayuda" sino el ejercicio de la corresponsabilidad. En consecuencia, se requiere desarrollar procesos de formación, sesiones educativas, acciones y estrategias de atención interdisciplinaria orientadas a promover la corresponsabilidad compartida en clientes, beneficiarias que reciben los servicios de CEN-CINAI. (ONU, 2021)

- **Datos sensibles:** Información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros (Ley 8968)**.**

- **Detección**: Se refiere a la identificación o sospecha de situaciones, circunstancias, elementos o conductas de riesgo asociadas con la probabilidad de la presencia de algún padecimiento, enfermedad, trastorno, síndrome, o afectación en el crecimiento, desarrollo y salud incluyendo situaciones de índole psicosocial, sociofamiliar, socioeconómico. Es fundamental que la detección se realice de manera temprana y oportuna a partir de la observación, entrevistas, aplicación de instrumentos, análisis de los determinantes sociales de la salud, así como de los resultados de los tamizajes y evaluaciones del crecimiento, desarrollo y salud, aplicados en la institución o situaciones reportadas por la familia que requieren de atención interdisciplinaria.

- **Determinantes sociales de la Salud:** La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud (DSS) como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana". Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas, políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud (OMS, 2012).

- **Discapacidad**: Es un concepto que evoluciona, y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. (Decreto Ejecutivo 41088-MP, 2018, párr. 21). La discapacidad “hace referencia a esta interacción entre los déficits sensoriales, motores, cognitivos, o de cualquier otro tipo, de una persona respecto al desarrollo considerado «normotípico», al interactuar con las condiciones y factores de la sociedad” (López, 2018, p.20-21).

- **Eficacia:** El logro de la meta y los objetivos propuestos con calidad en la prestación de los diferentes servicios y modalidades (Ministerio de Salud, DNCC, 2021).

- **Eficiencia:** Capacidad para realizar y cumplir oportunamente una función (DNCC, 2022). Refiere a la relación entre los recursos utilizados y los logros conseguidos a fin de usar lo mejor posible los recursos disponibles para obtener los objetivos propuestos y el mejor resultado posible.

- **Enfermedades no transmisibles:** se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) que dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. (OEA-REDESCA-CIDH, 2023).

- **Enfoque centrado en la familia:** “…tiene el objetivo de promover al máximo la toma de decisiones, capacidades y competencias de las familias. Empodera a las familias de modo que puedan elegir los servicios y apoyos necesarios para la mejora del funcionamiento familiar según sus necesidades y deseos. Las intervenciones profesionales se basan en las fortalezas familiares y contribuyen a que las familias identifiquen y organicen una red de apoyos necesarios para fortalecer y movilizar nuevas competencias y aprendizajes que

satisfagan las necesidades detectadas por la propia familia" (Villaescusa, Martínez y Yurrebaso, 2022, p 20). Desde la atención interdisciplinaria, este enfoque implica que los equipos profesionales articulen sus saberes técnicos para acompañar, orientar y fortalecer las capacidades de las familias, de manera que puedan tomar decisiones informadas y ejercer su rol protagónico en la crianza, la salud y la educación partiendo de que todas las familias cuentan con fortalezas y capacidades y que, por lo tanto, debemos detectarlas y promover su uso como soporte para el funcionamiento familiar.

- **Enfoque de Derechos humanos:** Son garantías esenciales e inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, discapacidad, religión, preferencia sexual, lengua o cualquier otra condición; que permiten el pleno desarrollo personal y vivir en igualdad, libertad y dignidad. Los derechos humanos son universales, irreversibles, indivisibles, inalienables, progresivos, inviolables, irrenunciables, históricos, interrelacionados, no jerarquizados y obligatorios (Decreto Ejecutivo 41088-MP, 2018, párr. 20). El enfoque de derechos humanos aplicado en la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI implica reconocer a cada persona como sujeto de derechos. Esto exige garantizar un abordaje integral que respete los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en las modalidades de atención conforme a lo establecido a la Ley 7600 y la Convención de los Derechos de la persona con discapacidad. Este enfoque inspira acciones coordinadas entre disciplinas con el objetivo de garantizar el derecho a una atención inclusiva, empática y responsable con las particularidades de cada persona.

- **Enfoque de Salud Pública**: Reconoce los determinantes sociales de la salud, donde la salud es un estado continuo de adaptación al medio natural y socioeconómico-cultural donde se nace, vive, trabaja y envejece. Además, se reconoce al ser humano como un ser integral con dimensiones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales que funciona en relación con el mundo que le rodea. Por lo que la atención a la niña o niño en riesgo biopsicosocial debe ser planificada y abordada en respuesta a los múltiples factores que pueden estar presentes o asociados a la condición de crecimiento, desarrollo infantil y salud, aunado con acciones de detección temprana de riesgos, promoción y prevención (Dávalos, 2006). Para aquellos casos que requieren atención clínica especializada deben ser referidos a la Caja Costarricense de Seguro Social.

- **Enfoque de Interseccionalidad:** La interseccionalidad se fundamenta en la idea de que las personas se ubican simultáneamente en diversas categorías de diferenciación social que determinan su posición y rol dentro de la sociedad. Entre estas categorías se encuentran, por ejemplo, la etnia, el género, la clase social, la orientación sexual, la ubicación geográfica y la edad. Estas dimensiones no actúan de manera aislada ni excluyente, sino que se entrelazan e interactúan entre sí, configurando identidades complejas y generando experiencias diferenciadas que pueden traducirse tanto en desigualdades como en ventajas. En este sentido, la identidad de cada persona es multidimensional, y la forma en que estas dimensiones se intersectan influye directamente en sus oportunidades, relaciones y condiciones de vida. (Awid 2004, citado por Redlad, 2021)

- **Enfoque Étnico Racial**: Reconoce la diversidad cultural, histórica y simbólica de los grupos étnico-raciales, identificando y atendiendo brechas e inequidades estructurales, y promoviendo prácticas inclusivas y sensibles al contexto diferencial. Este enfoque se fundamenta en el reconocimiento de las identidades múltiples como recursos de riqueza colectiva (Lucumí, 2020) y en la obligación oficial de visibilizar las desigualdades mediante información estadística pertinente y participativa (INEC, 2022). Este enfoque reconoce que la condición de etnicidad se traduce en desigualdades socioeconómicas y, por tanto, en la violación de derechos fundamentales para ciertas poblaciones. Su fin es evidenciar estas brechas y contribuir a su análisis para que se desarrollen acciones orientadas a su reducción (INEC, 2022), por lo que, desde la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI se valora la diversidad cultural, histórica y simbólica de las poblaciones atendidas, asegurando que las intervenciones se desarrollen desde una perspectiva inclusiva y sensible a los contextos diferenciales, no se limita al reconocimiento de la diversidad, sino que se convierte en un principio rector que orienta la labor técnica, pedagógica y comunitaria de los equipos interdisciplinarios hacia la construcción de entornos más justos, inclusivos y respetuosos de la identidad cultural.

- **Equidad**: Es un imperativo ético de justicia social que permite dar prioridad a la población más vulnerable (DNCC, 2021)**.**

- **Equipo interdisciplinario**: Alude a la integración del trabajo disciplinario de forma colaborativa, interactiva e integrada, utilizando conceptos, métodos o instrumentos de dos o más disciplinas, para resolver un problema o pregunta que requiere ser analizado mediante la interacción parcial de varios campos disciplinarios. Los miembros del equipo coordinan el diseño de la estrategia, interactúan desde sus propios marcos conceptuales para producir un resultado parcial o totalmente integrado, producto de la intersección entre disciplinas. Esto puede variar desde el compartir de ideas, hasta la integración total de conceptos, metodología, procedimientos, teorías, terminología, datos y organización. El equipo interdisciplinario logra la habilidad de analizar, sintetizar y armonizar los lazos entre disciplinas en un todo coordinado y coherente (Bocco et al 2014, Henao et al 2017 y González 2014).

- **Estrategia de atención interdisciplinaria:** Se refiere a todas aquellas técnicas o acciones definidas de forma consensuada y colaborativa por parte del equipo interdisciplinario, implementadas con el objetivo de coadyuvar y lograr de manera oportuna el progreso, mejora, adaptación o recuperación de situaciones referidas para la atención interdisciplinaria. Las estrategias de abordaje

En revisión

son parte de la atención y seguimiento establecido por el equipo de profesionales. Algunos ejemplos de estrategias son: atención individual, consejería, visita domiciliar, atención en el contexto, atención grupal, actividades educativas, actividades comunitarias, referencias a otras instituciones y/o denuncias cuando se requiera, las cuales son implementadas por las personas profesionales de OL o ATE (de una o más disciplinas según se requiera) en la cantidad de sesiones definidas para cada caso, y, cuando corresponda, con el apoyo y la colaboración de ASSC2, ASSC3, profesional de establecimiento o personas contratadas para la atención integral de niñas y niños en las estrategias intra y extra muros.

- **Factores de riesgo:** Condición social, económica, biológica ambiental, que está asociada con un incremento en la posibilidad o susceptibilidad de una enfermedad o daño en la salud (OPS). Los factores de riesgo están localizados en individuos, familias, comunidades y ambiente, pero cuando se interrelacionan aumentan sus efectos aislados (Senado, 1999). Se refiere a la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta la salud de una persona o un grupo (Donas, 1998) o a la probabilidad de que la presencia de una o más características o factores incremente la aparición de consecuencias adversas para la salud, el proyecto de vida, la supervivencia personal y de otros (Ministerio Salud, 2014).

- **Factores protectores**: Los factores protectores son condiciones, características, recursos o prácticas presentes en el entorno familiar, comunitario e institucional que promueven el desarrollo integral infantil y reducen la probabilidad de que niñas y niños enfrenten riesgos que afecten su salud, nutrición, crecimiento o bienestar. Los factores protectores facilitan el desarrollo de conductas saludables y se derivan en una buena salud (Ministerio de Salud, 2021).

- **Niña o niño**: Toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos (Ley N° 7739, 1998, párr. 3). Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente. (Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739 publicada en 1998).

- **Malnutrición**: Se entiende como las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. Abarca dos grupos amplios de afecciones: desnutrición que comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y minerales importantes). El otro grupo es el del sobrepeso y la obesidad, [así como la obesidad abdominal según relación circunferencia] (DNCC, 2020, p. 11).

- **Modelo Biopsicosocial:** Modelo de la salud que considera factores biológicos, psicológicos y sociales. Su definición se desprende de los elementos compositivos bio (vida), psico (alma, mente) y social, relativo a la sociedad, el contexto y medio ambiente en el que se interactúa.

- **Observación y escucha activa**: Implica cuán atento se está durante el diálogo que permita captar lo que otra persona expresa o demuestra. Conlleva manifestar interés en lo que se transmite, ve y escucha, con empatía y respeto a las ideas, necesidades, inquietudes, pensamientos y sentimientos que se está transmitiendo en la conversación, como base para comprender y analizar la información. Además, incluye reconocer e interpretar el lenguaje no verbal (tono y ritmo de la voz, gestos con las manos, expresiones de rostro y postura del cuerpo) que acompañan lo que está expresando (Elaborado a partir de Hernández, K., Lesmes-Silva, A. 2017).

- **Oportunidad:** Momento o circunstancia conveniente para ejecutar acciones o estrategias a fin de favorecer la atención a las necesidades de clientes, beneficiarias y beneficiarios referidos para la atención interdisciplinaria.

- **Prevención:** La OMS, desde 1998 definió la prevención como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Contempla aquellas medidas orientadas a prevenir y detener el avance de una enfermedad, así como a aliviar o atenuar sus efectos una vez iniciada.

- **Prevención Universal:** Es la intervención dirigida a la totalidad de la población, sin distinción de niveles de riesgo individuales. Su objetivo es promover condiciones saludables y reducir la exposición a factores nocivos para todas las personas, independientemente de si presentan o no factores de riesgo identificables. Scoppetta y Avendaño (2021) reafirman que "la prevención universal se dirige a toda la población" y que sus acciones buscan fortalecer factores protectores en el conjunto de la comunidad.

- **Prevención Selectiva:** Es la intervención dirigida a subgrupos específicos de la población cuyo riesgo de desarrollar un problema de salud es significativamente mayor que el promedio, aunque los miembros de ese subgrupo no hayan desarrollado aún el problema. La pertenencia al subgrupo puede estar determinada por factores biológicos, psicológicos, sociales o ambientales. El Instituto de Medicina-IOM de Estados Unidos (1994) señala que las intervenciones selectivas se justifican cuando el riesgo del subgrupo es

En revisión

suficientemente elevado como para ameritar una intervención más específica que la universal, pero sin que se haya detectado un problema individualizado (Vázquez, Muñoz y Juárez, 2018).

- **Prevención Indicada:** Es la intervención dirigida a personas individuales identificadas que ya presentan signos, síntomas tempranos o factores de alto riesgo que señalan predisposición a un problema de salud, aunque no cumplan aún criterios diagnósticos formales completos. Se trata de la intervención más individualizada e intensiva de los tres niveles preventivos. Scoppetta y Avendaño (2021) reafirman que este nivel requiere el análisis de factores de riesgo entre quienes ya muestran características asociadas al problema.

- **Promoción del Crecimiento y Desarrollo:** Implementación de estrategias, servicios y proyectos que aseguren la atención óptima del niño y la niña menor de 13 años, para el desarrollo de su potencial como sujeto integral de derechos. Se refiere a las valoraciones del crecimiento y desarrollo infantil, atención interdisciplinaria y educación al grupo familiar en salud, nutrición, crianza y socialización de sus hijas e hijos, así como la atención integral a niñas y niños en estrategias extramuros. (DNCC, 2020a).

- **Promoción de la salud:** La Promoción de la Salud "trabaja tomando en cuenta el origen de los determinantes, analizando la forma en que las personas se exponen a los riesgos, poniendo énfasis en averiguar cómo pueden éstas ya sea protegerse o volverse más resilientes, y utilizar los determinantes favorables para impulsar su bienestar" (De la Guardia y Ruvalcaba, 2020, p.86). Desde la OMS se refiere al proceso que permite a las personas aumentar el control que tienen sobre su salud y mejorarla. No se enfoca solo en los comportamientos individuales sino en una gama más amplia de intervenciones socioambientales, integrales y multifacética. Se vincula tanto con estrategias de prevención a nivel de un grupo, una comunidad o una población en particular, como con enfoques de carácter individual, como el tratamiento y la atención continua.

- **Referencia:** Es la acción de remitir casos o situaciones detectadas ya sea a una instancia interna (equipo interdisciplinario) o externa que forma parte de la red básica de servicios (Ministerio Público, CCSS, PANI, RISA, IMAS,MEP, INAMU, OAPVD, INA, Municipalidad, entre otras) de acuerdo con las competencias que le son propias y los servicios específicos que preste, de manera que se amplíe la valoración, atención o complementación del caso o situación para reforzar las intervenciones, todo como parte de una atención integral.

- **Rezago y/o riesgo de retaso en el desarrollo infantil:** Se habla de rezago y/o riesgo de retraso en el desarrollo infantil cuando las niñas y los niños no logran las conductas esperadas para su edad según los hitos del desarrollo o bien se identifican alteraciones en su proceso madurativo. Estas situaciones abarcan riesgos biológicos antes, durante o después del parto, o durante el desarrollo temprano, tales como nacimientos prematuros, bajo peso, anoxia o hipoxia al nacer. También se considera riesgo en el desarrollo infantil, cuando las personas menores de edad están expuestas a violencia, maltrato, desnutrición, negligencia, haber pasado por procesos de hospitalización, convalecencia o ser recurrentes a tratamientos médicos; situaciones que pueden afectar su madurez (MEP, 2018, p. 16).

- **Salud**: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1948)

- **Seguimiento:** Se refiere a las acciones que realiza la persona profesional integrante de los equipos interdisciplinarios en CEN-CINAI como parte de un proceso continuo y sistemático para verificar, revisar, analizar, medir y constatar el avance, estancamiento, retroceso o emergentes de la situación referida (incluyendo denuncias) posterior a la implementación de las estrategias de atención interdisciplinaria. Este proceso implica indagar, valorar y analizar tanto la efectividad de las estrategias implementadas como la respuesta de las personas o familias ante las acciones ejecutadas por parte del equipo interdisciplinario (sea por disciplina o de manera integrada), así como por otras instituciones. Con esa base, el seguimiento permite determinar la necesidad de mantener, cambiar o finalizar la Atención Interdisciplinaria o bien, realizar una nueva referencia interinstitucional y/o denuncia, según con las necesidades y condiciones específicas de clientes, beneficiarias y beneficiarios.

- **Sesión de apoyo**: En el marco de la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI descrita en este procedimiento, es un espacio formal en el que las personas profesionales de Oficina Local o Área Regional (de una o más disciplinas) conversan, analizan, toman acuerdos desde sus conocimientos y experiencias, en busca de coadyuvar y orientar a las personas ASSC2, AII, ASSC3 y profesionales de establecimiento u otros cargos por contratación, en las estrategias y recomendaciones a desarrollar ante las situaciones específicas referidas para la atención interdisciplinaria. Estas acciones se relacionan con la atención en el contexto para implementar ya sea de manera individual o grupal, familia, comunidad, en las estrategias intra y extramuros, con niñas y niños, beneficiarias o también para el abordaje específico con padres, madres o personas encargadas, según sea el caso, con el fin de brindar un abordaje integral. Requiere de coordinaciones entre el Equipo Interdisciplinario de la Oficina Local y el personal de los establecimientos de CEN-CINAI.

- **Sesión Interdisciplinaria:** Consisten en reuniones periódicas por parte de los profesionales de Oficina Local o Área Técnica Regional, para el análisis, discusión, priorización y toma de decisiones en forma conjunta y colaborativa que permita definir la atención o el

En revisión

abordaje integral de los casos y situaciones referidas para la atención interdisciplinaria; teniendo como insumo lo descrito en la boleta de referencia y sus anexos si los tuviera, así como factores de riesgo y factores protectores identificados. Es un espacio para que el Equipo Interdisciplinario defina las estrategias de atención interdisciplinaria con Enfoque de Salud Pública, según la prioridad de cada caso.

- **Signos de alerta**: Cualquier signo indicador de un desajuste en el desarrollo integral de una niña o niño. Estas alertas llevan a una mayor indagación para identificar las causas de este desajuste y a partir de ahí tomar medidas necesarias para asegurar el alcance del máximo potencial de desarrollo de la niñez (INAIPI, UNICEF, MINERD, 2017).

- **Trastorno**: Son aquellas alteraciones en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o bien, en el equilibrio mental de una persona." (CONAPDIS e INEC, 2019, p. 32).

- **Vía de atención:** En el marco de este procedimiento es entendida como la ruta de atención que sigue la referencia, la cual puede ser canalizada de la siguiente manera:

  Atención Inmediata: Son las acciones que se realizan en situaciones que requieren atención rápida, pronta, oportuna, adecuada y eficaz, debido a uno o múltiples factores biomédicos, psicológicos, familiares, sociales o contextuales. A partir de la gravedad, riesgo asociado y necesidad de atención, se distinguen en:

  - Emergencia: Es una situación repentina, imprevista, crítica y/o grave, que pone en peligro la vida, la salud o la propiedad de las personas por lo que requiere una atención inmediata y coordinada. Tiene como objetivo evitar la muerte y/o disminuir las posibles secuelas o daños. Pueden ser causados por accidentes, desastres naturales, enfermedades repentinas o situaciones de violencia.
  - Urgencia: Las situaciones urgentes implican la necesidad de actuar de manera rápida, pero no necesariamente representan un peligro grave o una amenaza inminente e inmediata para la vida. Las situaciones urgentes pueden permitir cierto margen de tiempo para actuar, aunque se requiere una acción rápida para evitar consecuencias negativas.

  Atención no inmediata: Son las acciones por desarrollar cuando se identifican situaciones en las modalidades de atención que requieren de una atención integral por parte de las personas profesionales de OL y/o ATE en una o más disciplinas, que permitan lograr de manera oportuna mejorar la salud, bienestar, desarrollo y calidad de vida de las niñas, niños y beneficiarias.

- **Valoración situacional:** Corresponde al proceso de análisis integral de la situación referida a la A.I. Contempla la identificación de factores de riesgo, signos de alerta, factores protectores, redes de apoyo y capacidades de respuesta individual, familiar, comunitaria e institucional, para comprender los determinantes sociales, que inciden en el crecimiento, desarrollo y salud de clientes y beneficiarias que han sido referidos a A.I., con el fin de disponer de fundamento técnico y valoración integrada para la priorización y definición de estrategias de abordaje así como su frecuencia de implementación.

- **Vulnerabilidad**: Posibilidad que se produzca un riesgo o daño (Korin, 1997, citado por CCSS 2018). La expresión condición de vulnerabilidad se utiliza para designar aquellos grupos de personas que, por razones inherentes a su identidad, estado, situación o circunstancia concretas, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y, por ende, de la atención y satisfacción de sus necesidades. Son condiciones de vulnerabilidad: la edad, la discapacidad, la etnia, la pertenencia a territorios indígenas o a minorías, la victimización, la diversidad sexual, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza y la privación de libertad, entre otras (Decreto Ejecutivo 41088-MP, 2018, párr. 16).

1.5 Abreviaturas

A.I.	Atención Interdisciplinaria
ATE	Área Técnica Regional
ASSC 2	Asistente de Salud del Servicio Civil 2
ASSC 3	Asistente de Salud del Servicio Civil 3
CEN	Centro de Educación y Nutrición
CINAI	Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
DISSEN	Diagnóstico establecimiento CEN-CINAI: Variables socioeconómica, de salud, educación y nutrición.
DNCC	Dirección Nacional de CEN-CINAI
DR	Dirección Regional

En revisión

DT	Dirección Técnica
E.I.	Equipo Interdisciplinario de la Oficina Local y/o Área Técnica Regional
EBAIS	Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
INAMU	Instituto Nacional de la Mujer
MEP	Ministerio de Educación Pública
OL	Oficina Local
OAPVD	Oficina de Atención a las Personas Víctimas de Delitos
PANI	Patronato Nacional de la Infancia
RISA	Red Integrada e Intersectorial de Servicios de Atención al Desarrollo del Niño y la Niña en Costa Rica
SAIID	Sistema de Atención Integral e Intersectorial del Desarrollo de Niñas y Niños en Costa Rica

1.6 Referencias (En proceso de revisión)

American Psychological Association. (2018, 19 de abril). *Bullying*. En *APA Dictionary of Psychology*. https://dictionary.apa.org/bullying

Awid. (2004). Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Género y Derechos, 1-8. Citado por Redlad, 2021. https://redlad.org/wp-content/uploads/2021/10/Interseccionalidad-Una-apuesta-de-trabajo-en-red.pdf

Bocco, G., Espejel, I., Hualde, A., Lledo, P., Olivé, l., Reyes, C., Robles, E., Suárez, R. (2014). Evaluación de Proyectos multi/inter/transdisciplinarios. Foro consultivo Científico y Tecnológico, AC. México.

Caja Costarricense de Seguro Social (2015). Manual Técnico y de Procedimientos para la Atención Integral de las personas adolescentes con énfasis en Salud Sexual y Salud Reproductiva. Gerencia Médica. San José, Costa Rica.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) & Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2019). *Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) 2018: Principales resultados*. San José, Costa Rica.

Caja Costarricense de Seguro Social (2018). Política Institucional de Atención Integral a la Adolescencia. Aprobado Acuerdo de Junta Directiva Acta 7.203 Sesión 8972, Artículo 3, 25 de junio, 2018.

Dávalos, M. (2006). Determinantes de la Salud. Aula virtual de países del campus virtual. https://cursospaises.campusvirtualsp.org/mod/resourse/view.php?id=40681&redirect=1

Decreto ejecutivo 37270-S (2012). Reglamento Orgánico de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral. La Gaceta Alcance Digital # 132, San José. San José, Costa Rica. https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/70-decreto-ejecutivo

Decreto Ejecutivo N.° 3917-S. (2015). Norma Nacional de uso de las gráficas antropométricas para la valoración nutricional de 0 a 19 años. Diario Oficial La Gaceta. Costa Rica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=80716

Decreto Ejecutivo 40881-S. (2018). Normativa Nacional para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida). Diario Oficial La Gaceta, Alcance N.° 38. Costa Rica. https://www.binasss.sa.cr/saludmental/STSM_de_40881_s_normativa_nacional_artic_interi_abordaje_integral_comportamiento_suicida.pdf

Decreto Ejecutivo N.° 41088-MP. (2018). Reglamento a la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N.° 9303. Diario Oficial La Gaceta. San José, Costa Rica.

Decreto Ejecutivo N.° 42336-S. (2020). Reglamento de Vigilancia de la Salud, notificación de eventos de salud, Ley N.° 9845. Diario Oficial La Gaceta. Costa Rica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=91213

En revisión

Decreto Ejecutivo N.° 44780-S. (2025). Declaratoria de la obesidad como enfermedad crónica de importancia de salud pública y oficialización de la Norma Nacional para la atención integral del sobrepeso y la obesidad. Diario Oficial La Gaceta. Costa Rica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=103597

De La Guardia, M., Ruvalcaba, J. (2020). La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria. JONNPR5(1):81-90. DOI: 10.19230/jonnpr.3215

Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud. (2020a). Manual Operativo de Atención Integral Infantil en CEN-CINAI, ISBN 978-9977-62-191-3. San José, Costa Rica.

Dirección Nacional de CEN-CINAI y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2020). Manual para la construcción de ambientes de paz y atención a situaciones de violencia en CEN-CINAI. https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/proyectos-educativos

Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud (2021). Normas Técnicas Sustantivas, Dirección Técnica. San José Costa Rica.

Dirección Nacional de CEN-CINAI. (2022). Procedimiento para la implementación de la Modalidad de Atención y Protección Cotidiana, Código: API-EC-APC-PR02. Costa Rica.

Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud. (2020b). Procedimiento para la atención interdisciplinaria del niño o niña con malnutrición. San José, Costa Rica.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Junio 2019. Bullying en el ambiente escolar: qué es y cómo afrontarlo. https://www.unicef.org/chile/media/3171/file/bullying_en_el_ambiente_escolar.pdf

George, R., Gamez, Y. Matos, D. González, I. Labori, R y Guevera,S. (2021). Eficacia, efectividad, eficiencia y equidad en relación con la calidad en los servicios de salud. Ecimed. Información para directivos de la Salud. 2021 (May-Ago);35: e_974 http://scielo.sld.cu/pdf/infd/n35/1996-3521-infd-35-e974.pdf

González, A. (2014) Intervención Social Interdisciplinaria: aportes desde la propuesta epistemológica de adorno. TS Cuadernos de Trabajo Social. Nº 11 (57- 64), Universidad San Sebastián (Chile). ISSN 0719-6520

Henao, C., García, D., Aguirre, E., González, A., Bracho, R., Solórzano, J., Arboleda, A. (2017). Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la formación para la investigación en ingeniería. Revista Lasallista de Investigación. Vol. 14, pp. 179-197. DOI: 10.22507/rli. v14n1a16

Hernández, K., Lesmes-Silva, A. (2017). Revista Convicciones, 9 (1) (2018), 83-87. Enero/junio 2018, ISSN 2389-7589 (Online) La escucha activa como elemento necesario para el diálogo. Colombia. https://www.binasss.sa.cr/adolescencia/institucional.pdf

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). (2017). Identificación de Señales de Alerta en el Desarrollo Infantil. En colaboración con Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) & Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). República Dominicana.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2022). Guía para los lineamientos técnicos para incorporar el enfoque étnico-racial en la producción de estadísticas oficiales [recurso electrónico] 1ª edición. – San José, C.R. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2022-09/guia_para_lineamientos_enfoque_etnico-racial.pdf

Ley N.° 7600 (1996). Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Diario Oficial La Gaceta N°102. San José, Costa Rica. https://pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=23261

Ley N° 7739. (1998). Código de la niñez y la adolescencia. Diario oficial La Gaceta N° 26. San José, Costa Rica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43077&nValor3=0&strTipM=TC

Ley 8809 (2010). Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral. Diario Oficial La Gaceta N°105, San José, Costa Rica.

En revisión

https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=68020&nValor3=80847&strTipM=TC

Ley 8968 (2011). Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Diario oficial La Gaceta N° 170. San José, Costa Rica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC

López, A. (2018). La escuela Inclusiva: el derecho a la equidad y la excelencia educativa. España. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/26837/USPDF188427.pdf

Lucumí, M. (2020). Enfoque étnico. Revista Científica Sabia, 6(1), 65–84. https://doi.org/10.47366/sabia.v6n1a5

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2016). Protocolo de actuación en situaciones de bullying. https://drea.mep.go.cr/sites/default/files/publicaciones-anexos-2023/Documento-Protocolo-Bullying.pdf

Ministerio de Educación Pública. (2018). Servicio Educativo para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo, desde el nacimiento hasta los 6 años. Costa Rica. https://ddc.mep.go.cr/daeed/documentosyorientaciones/pdfs/04servicio_educativo_para_ninos_y_ninas_nac_a_6_anos.pdf

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2009). Guía para la elaboración de Diagramas de Flujo. Área de modernización del Estado. San José, Costa Rica. https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/t51sXM8wSUWhO0YQT4l9eA

Ministerio de Salud (2014). Norma Nacional para la atención integral de la salud de las personas adolescentes. San José, Costa Rica.

Ministerio de Salud (2021). Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA) 2021-2030.San José, Costa Rica.

Organización de Estados Americanos (OEA), Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2023). Informe Las Enfermedades No Transmisibles y los Derechos Humanos en las Américas. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/REDESCA_enfermedades_NoTransmisibles_DDHH_SPA.pdf

Organización de Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Organización de Naciones Unidas (2021). ONU Mujeres. América Latina y el Caribe. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023-01/Invertir%20en%20Cuidados%20y%20Corresponsabilidad%20-%20Los%20cuidados%20y%20su%20rol%20en%20la%20sociedad.pdf

Organización Mundial de la Salud. (1948). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/gb/bd/pdf/bd47/sp/constitucion-sp.pdf

Organización Mundial de la Salud (1978). Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/declaration-of-alma-ata

Organización Mundial de la Salud (2012). Determinantes sociales de la salud: resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_16-sp.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2016). Declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Shanghái. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259183/WHO-NMH-PND-17.5-eng.pdf?sequence=1

Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (1978). Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud. ALMA-ATA, URSS, Kazajistán. https://www.paho.org/es/documentos/declaracion-alma-ata#:~:text=La%20Conferencia%20internacional%20de%20atenci%C3%B3n,establece%20la%20siguiente%20Declaraci%C3%B3n...

En revisión

Organización Panamericana de Salud. (2017). Agenda de salud sostenible para las américas 2018-2030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región. Washington D.C., EUA. https://www.paho.org/es/agenda-salud-sostenible-para-americas-2018-2030

Organización Panamericana de la Salud (2022a). Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030.Washington, DC. EUA. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55950/OPSFPLIM220006_spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Scoppetta, O., & Avendaño Prieto, B. L. (2021). Evidencia para la prevención universal, selectiva e indicada del consumo de sustancias ilícitas en Colombia. Health and Addictions / Salud y Drogas, 21(2), 14-28. https://doi.org/10.21134/haaj.v21i2.517

Sistema de Atención Integral Intersectorial del desarrollo del niño y la niña (2025). Protocolo intersectorial de atención al desarrollo de niñas y niños preescolares y escolares. Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Dirección Nacional de CEN-CINAI, Secretaría Técnica de CEN-CINAI, CONARE. Código PI.CR.SAIID.RISA.290416, versión 2. San José-Costa Rica.

Vázquez, N., Muñoz, L., Juárez, O., & Ariza, C. (2018). ¿Qué funciona en la prevención selectiva del consumo de alcohol y cánnabis en jóvenes vulnerables? Revista Española de Salud Pública, 92, e201810070. https://www.scielosp.org/pdf/resp/2018.v92/e201810070/es

Villaescusa, M., Martínez, N., y Yurrebaso, G. (2022). Enfoque centrado en la familia en las entidades de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo: conceptualización y orientaciones para la puesta en práctica. España. Zerbitzuan: Revista de Servicios Sociales, (76), 47–58. https://doi.org/10.5569/1134-7147.76.03

Wells, J. C. K., Wibaek, R., & Poullas, M. S. (2018). La doble carga de la malnutrición aumenta el riesgo de parto por cesárea: evidencia de la India. Frontiers in Public Health, 6, 292. https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00292

II. CADENA DE RESULTADOS.

2.1 Resultados antecesores

- Marco jurídico y normativa institucional vigente que ampara la implementación del procedimiento.
- Norma para Atención Interdisciplinaria Código: PCD-ID-N-06 y marco normativo institucional vinculante.
- Oficinas Locales y Áreas Técnicas Regionales de CEN-CINAI con el recurso humano profesional, técnico y administrativo que integra cada unidad organizativa.
- Familias de clientes, beneficiarias y miembros de Comités de CEN CINAI con información clara, precisa y completa sobre la atención interdisciplinaria que se brinda en CEN-CINAI.
- Personas funcionarias con inducción en el procedimiento de atención interdisciplinaria establecido por la Dirección Nacional de CEN-CINAI.
- Procedimiento para la Vigilancia del Crecimiento, Desarrollo y Salud en niñas y niños de la Dirección Nacional de CEN-CINAI implementado oportunamente según la periodicidad establecida.
- Instrumentos y sus respectivos instructivos para la referencia a A.I., referencia interinstitucional y denuncia disponibles en los establecimientos.
- Personas funcionarias observantes que identifican de manera oportuna aspectos, situaciones de emergencia o urgencia, así como circunstancias de posibles alertas o factores de riesgo biopsicosocial en clientes y beneficiarias, que requieran atención interdisciplinaria.
- Expediente físico de clientes y beneficiarias con información completa y actualizada.

2.2 Frecuencia

Las acciones relacionadas con este procedimiento se realizarán de forma continua y se activa toda vez que se detecten situaciones de riesgo biopsicosocial que inciden en la salud, el óptimo crecimiento y desarrollo de clientes y beneficiarias que requieren atención y seguimiento especializado e interdisciplinario.

2.3 Factores de Éxito

- Personas funcionarias con conocimiento en la adecuada implementación del presente procedimiento.
- Actividades para la atención y seguimiento interdisciplinario de clientes, beneficiarias y su grupo familiar en situación de riesgo biopsicosocial, incluidas de forma prioritaria en la programación anual de las personas funcionarias integrantes del equipo interdisciplinario a nivel local y regional.

En revisión

- Personas profesionales de los equipos interdisciplinarios del nivel local y regional realizando con calidad, calidez y oportunidad la atención y seguimiento de clientes y beneficiarias de los servicios, que han sido referidos por situación de riesgo biopsicosocial.
- Profesionales de los equipos interdisciplinarios del nivel local y regional aplicando los diferentes enfoques que orientan este procedimiento, reconociéndolos como ejes estratégicos e indispensables para alcanzar la equidad en salud.
- Profesionales de los equipos interdisciplinarios de los diferentes niveles de gestión reconocen y promueven el trabajo intersectorial e interinstitucional, facilitando la activación de referencias, denuncias y/o notificaciones obligatorias, con el fin de garantizar una atención oportuna y de calidad.
- Jefaturas de Oficina Local y Área Técnica Regional con claridad en su rol gerencial como garante del cumplimiento, la programación, el monitoreo, asesoría y acompañamiento técnico del presente procedimiento, así como la toma de decisiones requeridas para la calidad, eficiencia y oportunidad de la atención interdisciplinaria.
- Jefaturas y personas funcionarias de Unidades de la Dirección Técnica, con claridad en su rol técnico-operativo (normativo) en la elaboración, actualización y asistencia técnica en lo relacionado con instrumentos, manuales, guías, disposiciones u otros documentos, necesarios para el cumplimiento con calidad, eficacia y eficiencia de este procedimiento.
- Personas de los tres niveles de gestión, promoviendo una cultura institucional basada en el trabajo interdisciplinario y colaborativo con el fin de fortalecer la atención integral dirigida a clientes, personas beneficiarias y sus familias.
- Personas de los tres niveles de gestión promoviendo el trabajo intersectorial e interinstitucional como eje estratégico indispensable para lograr la equidad en salud.

2.4. Descripción de tareas.

A continuación, se describe la secuencia y organización de las tareas correspondientes a la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI, organizada en varias secciones: actividades previas a la implementación del procedimiento y la secuencia de tareas según la vía de atención interdisciplinaria.

Es importante considerar que la detección se realiza de manera continua a partir de la observación y escucha activa, considerando los resultados de tamizajes del crecimiento, desarrollo y salud aplicados en la institución, así como la información recabada por diferentes medios tales como visita domiciliar, referencia interinstitucional o situaciones reportadas por la familia. Lo anterior permite identificar las necesidades de A.I. desde los enfoques que guían este accionar.

Para la visualización del proceso completo, se elaboró un Flujograma de Atención Interdisciplinaria en CEN-CINAI (Anexo 1).

A continuación, en el punto 2.4.1 se describen las actividades previas a la atención interdisciplinaria.

En revisión

2.4.1 Actividades previas a la atención interdisciplinaria

N°	Tarea	Método	Responsables
1	Designar a una persona profesional de OL como enlace de A.I.	• Seleccionando, en consenso con el E.I. y jefatura de OL, a la persona funcionaria enlace de la A.I. que apoyará en las gestiones vinculantes al Procedimiento de A.I., como, por ejemplo: la recepción de referencias al E.I. (especialmente cuando estas sean de manera digital) y otros que la jefatura designe para facilitar la articulación y adecuada implementación del presente procedimiento. En el caso de ausencia de esta persona enlace, la Jefatura de OL asumirá el rol.	Jefatura y E.I. de OL.
2	Planificar y realizar la inducción y asesoría técnica a equipos de OL para la implementación del procedimiento de Atención Interdisciplinaria.	• Definiendo la metodología para realizar de forma oportuna, eficiente y con calidad la inducción y asesoría técnica del procedimiento a E.I. de OL a fin de garantizar la comprensión del proceder para la atención interdisciplinaria. • Programando y convocando a las personas del E.I. de OL a la o las sesiones de inducción y asesoría técnica referente al procedimiento, así como disponiendo de los insumos requeridos para su ejecución y logística respectiva. • Efectuando las acciones planificadas para la inducción y asesoría técnica con integrantes del E.I. de las OL. • Informando y sensibilizando a integrantes de E.I. de OL acerca de la importancia de la Atención Interdisciplinaria con enfoque de Salud Pública (Disposición 1). • Documentando mediante el reporte respectivo, las acciones realizadas como parte de la inducción y/o asesoría técnica y el registro de asistencia correspondiente.	- Jefatura y E.I. de ATE
3	Planificar acciones para la inducción y acompañamiento técnico a personal de establecimiento en la implementación del procedimiento de Atención Interdisciplinaria.	• Definiendo la metodología para realizar de forma oportuna, eficiente y con calidad la inducción y acompañamiento técnico al personal de establecimiento en lo relacionado con el procedimiento de atención interdisciplinaria. • Elaborando un cronograma para la inducción y acompañamiento técnico a las personas funcionarias en los establecimientos CEN-CINAI en lo relacionado con el procedimiento, así como disponiendo de los insumos requeridos para su ejecución y logística respectiva. • Organizando de la mejor manera y con la menor afectación de los servicios brindados la inducción y acompañamiento técnico al personal del establecimiento CEN-CINAI, tomando en cuenta el tipo de establecimiento, horarios, cantidad de personas, desplazamiento, funciones, entre otros. • Implementando la inducción y acompañamiento técnico de las acciones que se desarrollan como parte de la atención interdisciplinaria desde los enfoques de Salud Pública y centrado en la familia. • Informando al personal del establecimiento sobre la importancia de que madres, padres, personas encargadas, así como a beneficiarias tengan conocimiento sobre las acciones que se desarrollan como parte de la atención interdisciplinaria en la institución (Disposición 2). • Dando a conocer la generalidad del Procedimiento de Atención interdisciplinaria a personas miembros del Comité de CEN-CINAI, con el propósito de informar sobre las principales acciones que se llevan a cabo en CEN-CINAI como parte de la atención integral. Debe quedar registro de dicha actividad en el Libro de Actas del Comité. • Verificando que la normativa, el procedimiento, los instrumentos y demás recursos requeridos para la implementación de este procedimiento, estén disponibles para el personal del establecimiento. • Documentando mediante el reporte respectivo, las acciones realizadas para el acompañamiento técnico y el registro de asistencia correspondiente.	- Jefatura y E.I. de OL

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
4	Programar las sesiones interdisciplinarias para el análisis, discusión, priorización y toma de decisiones por parte del E.I.	• Estableciendo de manera conjunta la calendarización anual de las fechas de la sesión interdisciplinaria a efectuarse **al menos dos veces al mes durante todo el año.** Es recomendable realizar esta programación entre noviembre y diciembre del año anterior, ajustándose su frecuencia y cantidad según la necesidad de la OL para dar respuesta a la cantidad de situaciones referidas al E.I. • Remitiendo por parte del E.I. de la OL copia a la jefatura inmediata de dicha calendarización para que sea considerada en la programación de otras actividades. • Socializando la calendarización de las sesiones interdisciplinarias con equipo de ATE y personal de establecimientos, además debe ser incluida en la programación anual de OL y de región.	- Jefatura de OL - E.I. de OL - E.I. de ATE cuando se requiera.
5	Disponer de la información requerida para las acciones de la Atención Interdisciplinaria.	• Manteniendo en cada establecimiento de manera accesible en todo momento (cerca del teléfono, sin llave), en un solo folder que proteja el documento, de manera actualizada la siguiente información: - Lista de contactos telefónicos y correo de equipo de la OL y Región con el nombre y cargos según corresponda. - Lista de contactos telefónicos de las instituciones para la atención de emergencias. - Lista de contactos telefónicos de las madres, padres o personas encargadas o contactos en caso de emergencia de las niñas, niños y beneficiarias organizadas por modalidad de atención intramuros. En caso de emergencia o eventualidad en comunidades extramuros, la persona funcionaria se comunica con el establecimiento para que consulte en el Expediente físico de la niña, el niño o beneficiaria y le proporcione la información correspondiente al contacto de emergencia de la niña, niño o beneficiaria. - Lista de correos electrónicos y persona enlace o contacto en las instituciones de la red de servicios de la comunidad u otros correspondientes a la localidad de cada establecimiento. • Manteniendo en cada establecimiento de manera accesible en todo momento, ejemplares de los documentos requeridos para realizar referencias y/o denuncias: boletas de referencia a A.I. (Anexo 2a y 2b), boleta de referencia interinstitucional (Anexo 3a y 3b), boleta de contra-referencia interinstitucional (Anexo 4a y 4b, boleta de denuncia (Anexo 5a y 5b).	- ASSC2, ASSC3 y personas en cargos homólogos por contratación. - Profesional de establecimiento CEN-CINAI - Jefatura de OL - E.I. de OL
6	Resguardar la información que forma parte de la Atención Interdisciplinaria.	• Disponiendo de un espacio en la Oficina Local debidamente identificado para resguardar las referencias y documentación recibida para el E.I. de OL y otras asociadas con la A.I., tales como: minutas, oficios u otros. • Disponiendo de un espacio apropiado, seguro y confidencial en la Oficina Local para proteger y archivar los expedientes de A.I. de las niñas, niños y beneficiarias, así como los expedientes de denuncias (Disposición 3). • Disponiendo de la Herramienta de atención interdisciplinaria actualizada, accesible y con los respaldos requeridos para las personas que conforman el E.I. y jefatura de OL.	- Jefatura de OL - E.I. de OL

2.4.2 Actividades relacionadas con la solicitud de Atención Interdisciplinaria

A partir de la situación identificada de la niña, niño, adolescente madre, mujer embarazada o en periodo de lactancia que reciben modalidades de atención tanto en la estrategia intra como extramuros de la DNCC y con base en lo descrito en el presente procedimiento, se debe proceder según la vía de atención interdisciplinaria, ya sea situaciones de atención inmediata por emergencia o urgencia o las que requieren atención interdisciplinaria (no inmediata) por parte del E.I. de OL (Disposición 4).

En revisión

El personal de establecimiento puede solicitar apoyo a la o las personas profesionales del E.I., para recibir orientación sobre las acciones por realizar en casos específicos, tanto previo a la elaboración de la referencia según la vía de atención, como durante el proceso de atención interdisciplinaria.

A continuación, se presentan las tareas específicas según vía de atención interdisciplinaria en el procedimiento, descritas en las siguientes tablas:

A. Actividades relacionadas con la referencia por emergencia.
B. Actividades relacionadas con la referencia por urgencia.
C. Actividades relacionadas con la atención interdisciplinaria por parte del Equipo de OL.

A. Actividades relacionadas con la Vía de Atención Inmediata por emergencia.

N°	Tarea	Método	Responsables
1	Identificar la situación de emergencia de la niña, niño o beneficiaria tanto de la estrategia intra como extramuros de la DNCC.	• Partiendo que una situación de emergencia se refiere a aquellos casos de gravedad que ponen en peligro la vida y la salud de las personas o la propiedad de CEN-CINAI, por lo que requiere una atención inmediata (Disposición 4). • Reconociendo la situación de emergencia que se presente en el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de las modalidades de atención, tanto en las estrategias intra como extramuros en CEN-CINAI. • Considerando que, cuando se identifique una situación de emergencia, se debe comunicar a la persona encargada del establecimiento y en su ausencia a la jefatura de OL y de forma paralela al 9-1-1, de manera tal que se coordinen los apoyos necesarios para la atención de la situación. En caso de que sea una persona particular o persona miembro del Comité CEN-CINAI, quien detecte la situación de emergencia, debe comunicarlo a la persona encargada o funcionaria del establecimiento.	- Toda persona que detecte la situación, especialmente aquellas que son funcionarias de CEN CINAI y personal con cargos homólogos por contratación.
2	Comunicar la situación de emergencia para su abordaje inmediato.	• Comunicando de inmediato la situación de alto riesgo mediante llamada telefónica al 9-1-1 o centro de salud más cercano en situaciones de emergencia, que requiere una atención inmediata, así como acatando las indicaciones que proporcione el personal de atención de emergencias del 9-1-1. Cuando por la situación de emergencia se requiera traslado de niña, niño adolescente madre, mujer embarazada o en periodo de lactancia o beneficiario del establecimiento a un centro médico por medio de ambulancia o rescate, seguir lo indicado en la Disposición 4. • De manera paralela, comunicando de inmediato vía telefónica al padre, madre, persona encargada o contacto de emergencia de niña o niño cuando corresponda. En caso de que la emergencia les suceda a personas beneficiarias durante el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de las modalidades de atención, informar a la persona contacto de emergencia, según la información contenida en el expediente físico del cliente o beneficiaria, lista de contactos telefónicos en caso de emergencia de las niñas, niños. • Comunicando a la jefatura de la OL para la solicitud de apoyo ante la situación presentada, según se requiera. • Considerando que la prioridad es salvaguardar la vida, seguridad de las personas o disminuir posibles secuelas o daños, por lo que, primeramente, se realiza la (s) llamada (s) telefónica (s) para la atención de la situación y posteriormente, se completa la documentación cuando se requiera.	- ASSC2, TAC, ASSC3 - Personas en cargos homólogos por contratación - Profesional de establecimiento CEN-CINAI - E.I. de OL - E.I. de ATE

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
		• Una vez canalizada la situación de emergencia, se debe anotar en el libro de funcionamiento del establecimiento la situación presentada, detallando fecha, hora y acciones realizadas. Si desde el 9-1-1 indican que no se dispone de ambulancia para el traslado de emergencia, debe proceder a solicitar nombre completo de la persona que atendió la llamada, así como el código respectivo, y anotarlo en el libro de funcionamiento.	
3	Recibir la llamada telefónica o comunicado por situación de emergencia.	• Atendiendo la llamada telefónica por situación de emergencia e informando de manera inmediata a la jefatura la situación que se está presentando, o en su ausencia a la persona directora regional. • Coordinando el proceder con el equipo de profesionales de OL para el apoyo en la atención inmediata de la situación de emergencia, según lo indicado por la jefatura de OL o persona directora regional.	- Oficinista - Jefatura de OL, en su ausencia persona directora regional. - E.I. de OL - Cualquier otra persona que labore en CEN-CINAI y que atienda la llamada.
4	Brindar atención y apoyo en la situación de emergencia reportada.	• Analizando y priorizando las acciones de abordaje de la situación de emergencia, en conjunto el E.I. con la Jefatura de OL. Cuando se requiera la jefatura de OL solicita el apoyo del equipo de profesionales de ATE. • Realizando la o las acciones de apoyo de manera inmediata y oportuna según los medios disponibles, conforme lo requiera en la atención de la situación de emergencia y en complemento a la atención médica solicitada, entre ellas: - Diálogo con persona que comunica la situación de emergencia, para determinar acciones a realizar. - Orientación al personal del establecimiento para el resguardo de la integridad física y emocional de la persona en riesgo, teniendo como prioridad salvaguardar la vida, seguridad de las personas o disminuir posibles secuelas o daños. - Desplazamiento al establecimiento a la brevedad posible, cuando se requiera. - Apoyo y/o contención emocional a niñas y niños, beneficiarias o la madre, padre o persona encargada de las personas menores de edad o al personal del establecimiento según sea necesario. - Apoyo en la gestión o trámites presenciales o por otros medios, que agilicen la atención de la situación de emergencia. - Proceder a realizar denuncia por situación de emergencia cuando corresponda (Disposición 8). - Otras acciones para realizar según priorización, pertinencia, criterio profesional y legislación vigente. **Una vez estabilizada la situación de emergencia:** • Anotando en el Expediente físico del cliente y beneficiaria la situación acontecida y las acciones de atención de la emergencia realizadas, con el propósito de documentar de manera puntual lo ocurrido, el abordaje realizado, acuerdos y recomendaciones. Para ello se completa la información en el formulario “Registro de eventos y situaciones” (Anexo 11a y 11b) en la que se anota puntualmente la	- E.I. de OL - Jefatura de OL - Equipo ATE cuando se requiera

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
		situación presentada o hecho de emergencia acontecido, el cual no es parte de lo cotidiano o la rutina en el establecimiento.	
5	Dar seguimiento a situaciones de emergencia presentadas y/o denuncias realizadas.	• Valorando y analizando el avance, retroceso o nueva situación asociada al caso reportado por emergencia y/o denuncia realizada. • Determinando si requiere o no: - **Referir a A.I.**: sea vinculada por la situación reportada como emergencia u otras que se detecten durante la situación de emergencia. En este caso, se procede a completar la referencia a A.I. (Ver anexo 2a y 2b) y se continúan las tareas establecidas para el proceso de atención interdisciplinaria por parte de E.I. de OL. (Disposición 6, Anexo 7a y 7b). - **Realizar referencia interinstitucional y/o denuncia**: cuando corresponda. Continúa el seguimiento. (Ver anexos 3a, 3b, 4a y 4b, 5a y 5b). - **No requiere ser referido a A.I.:** Se anota en la boleta de eventos y situaciones el detalle de las acciones realizadas ante la situación de emergencia y se archiva en el Expediente físico del cliente y beneficiaria en el establecimiento. • Atendiendo solicitudes de otras instituciones de la red de servicios, completando contra-referencia (Ver anexos 4a y 4b) o emitiendo informes requeridos por superiores según situaciones de emergencia y/o denuncias realizadas.	- E.I. de OL. - Equipo ATE cuando se requiera.

B. Actividades relacionadas con la Vía de Atención Inmediata por Urgencia

N°	Tarea	Método	Responsables
1	Identificar la situación de urgencia de la niña, niño o beneficiaria tanto de la estrategia intra como extramuros de la DNCC.	• Partiendo que una situación de urgencia se refiere a la necesidad de actuar de manera rápida, pero no necesariamente representan un peligro grave o una amenaza inminente para la vida; por lo que pueden permitir cierto margen de tiempo para actuar, aunque se requiere una acción rápida para evitar consecuencias negativas. (Disposición 4). • Reconociendo la situación de urgencia que se presente en el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de las modalidades de atención, tanto en las estrategias intra como extramuros en CEN-CINAI. • Considerando que, cuando se identifique una situación de urgencia, se debe comunicar a la persona encargada del establecimiento y en su ausencia a la jefatura de OL. En caso de que sea una persona particular o persona miembro del Comité de CEN-CINAI, quien detecte la situación de urgencia, procede a comunicar a la persona encargada o funcionaria del establecimiento.	- Toda persona que detecte la situación, especialmente aquellas que son funcionarias de CEN CINAI y personal con cargos homólogos por contratación.
2	Comunicar la situación de urgencia para su abordaje inmediato al E.I.	• Comunicando el caso referido como urgencia de manera inmediata al profesional del E.I. de OL según la disciplina, mediante llamada telefónica, considerando que la situación requiere atención pronta y oportuna. En ausencia de profesional de OL, comunicar a la jefatura de OL para que designe la persona profesional que va a apoyar. Cuando se requiera el apoyo del equipo de profesionales de ATE, la jefatura de OL lo solicita.	- ASSC2, ASSC3 - Personas en cargos homólogos por contratación. - Profesional de establecimiento CEN-CINAI

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
		• Acatando las indicaciones que proporcione la persona profesional del E.I. de O.L., mientras se realiza la atención del caso específico, de manera tal que, la situación de urgencia se atienda de manera pronta y oportuna y no quede en espera o pausada por no haber remitido el documento de referencia al E.I.	
3	Elaborar y remitir la referencia por urgencia al A.I.	De manera paralela a la comunicación de la situación de emergencia: • Completando de manera correcta la boleta de referencia a A.I., por situación de urgencia. • Anotando en la referencia a A.I. la información correspondiente a diagnósticos o referencias recibidas que hayan sido aportadas por las familias, de manera que los profesionales del E.I. tenga información substancial adicional. No se deben adjuntar copias. • Realizando la coordinación de envío de la o las referencias para A.I., con colaboración de la persona ASSC3 o persona profesional del establecimiento de manera inmediata al E.I. de OL, con el respectivo oficio de entrega de documentos a la Oficina Local, para la atención inmediata de la situación por parte del E.I. **Nota**: Esta tarea puede realizarse de manera paralela con las tareas 2 y 3, a fin de que las acciones de abordaje de la situación de urgencia se realicen de manera pronta y oportuna y no queden en espera o pausadas por no haber recibido el documento físico de la referencia al E.I.	- ASSC2, ASSC3 - Personas en cargos homólogos por contratación - Profesional de establecimiento CEN-CINAI - Equipo de profesionales de la OL - Equipo de profesionales de la ATE
4	Recibir la referencia para el A.I. por situación de urgencia detectada.	• Recibiendo la o las referencias y el oficio de entrega de documentos de los establecimientos por parte de las personas funcionarias de OL en situaciones de urgencia. • Disponiendo de las referencias en el espacio en la Oficina Local designado para resguardar las referencias y documentación recibida para el E.I. de OL. • Corroborando el correcto llenado de la o las referencias físicas y verificando que la información esté completa. Cuando hay duda o faltante de información de la referencia, se le consulta a la persona funcionaria que completó la boleta, vía telefónica o mediante otra vía que agilice el proceso y se completa la información faltante, evitando devolver el instrumento al establecimiento, de no ser que sea sumamente requerido para completar una nueva referencia.	- Persona oficinista, administrativa. - Equipo de profesionales de la OL-ATE. Jefatura de OL
5	Atender la situación de urgencia y realizar acciones de abordaje según corresponda la situación referida	• Atendiendo la llamada telefónica o comunicado de situación de la urgencia y/o recibiendo la referencia para el E.I. • Considerando que la atención por situación de urgencia no debe quedar condicionada a la entrega del documento de referencia al A.I., aunque sí es necesario el llenado de la boleta de referencia a A.I. Realizando atención pronta y oportuna de la situación presentada una vez recibido el comunicado. • Implementando estrategias de abordaje con enfoque de salud pública según la priorización del caso o situación de urgencia (Disposición 10). En complemento, se pueden realizar otras acciones para el abordaje de la situación de urgencia: - Diálogo con persona que comunica la situación de urgencia, para determinar acciones a realizar. - Orientación al personal del establecimiento sobre las posibles acciones a realizar. - Apoyo y/o contención emocional a niñas y niños, beneficiarias o la madre, padre o persona encargada de las personas menores de edad o al personal del establecimiento según sea necesario. - Apoyo en la gestión o trámites presenciales o por otros medios, que agilicen la atención de la situación de urgencia.	- Equipo de profesionales de la OL - Equipo de profesionales de la ATE - Jefatura de OL

Preliminar

N°	Tarea	Método	Responsables
		- Proceder a realizar denuncia por situación de urgencia cuando corresponda. - Otras acciones a realizar según priorización, pertinencia, criterio profesional y legislación vigente.	
6	Analizar la situación referida por urgencia en la sesión interdisciplinaria.	• Analizando las acciones de abordaje de la situación de urgencia, de manera integral e interdisciplinaria. Según sea el caso el abordaje lo realiza según las disciplinas que corresponda para la atención de la situación de urgencia. Cuando se requiera la jefatura de OL solicita el apoyo del equipo de profesionales de ATE. • Consultando cuando se requiera, la información general de la niña, niño o beneficiaria descrita en el Expediente físico del cliente y beneficiaria disponible en el establecimiento, para identificar datos claves relacionados con factores de riesgo, factores protectores y determinantes a nivel individual, familiar o del contexto que aportan a la comprensión de la situación referida y a la definición de las estrategias de abordaje a emplear. **NOTA**: Esta tarea puede realizarse de manera paralela con la tarea anterior en tanto la situación es de urgencia.	- Jefatura de OL - Equipo de profesionales de la OL-ATE. -
7	Elaborar y enviar la referencia interinstitucional y/o denuncia cuando corresponda.	• Completando de manera correcta la boleta de referencia interinstitucional y/o denuncia cuando se requiera, de acuerdo con las competencias que le son propias a la institución y los servicios específicos que preste, EBAIS-CCSS, MEP, INA, INAMU, IMAS, PANI u otras (Anexo 3a y 3b, 5a y 5b). En caso de requerir apoyo, se solicita al E.I. de OL, por la vía más oportuna. • Enviando la referencia interinstitucional y/o denuncia de manera pronta y oportuna a la institución correspondiente. • Asegurando que se cuente con el recibido por parte de la institución a la que se entregó la referencia interinstitucional y/o denuncia, • Recibiendo en la OL las referencias interinstitucionales tramitadas para la atención o seguimiento interdisciplinario respectivo. Estas referencias interinstitucionales, debe resguardarse y estar disponible para uso del E.I. en el espacio de la Oficina Local debidamente identificado para tal fin. **Nota**: se aclara que una misma situación detectada, puede requerir de referencia al E.I. y/o referencia interinstitucional a una o más instituciones y/o denuncia. Estas acciones no son excluyentes ya que depende de cada caso.	- ASSC2, ASSC3 - Personas en cargos homólogos por contratación - Profesional de establecimiento CEN-CINAI. - Persona oficinista, administrativa. - E.I. de OL - E.I. de ATE.
8	Registrar la información de la referencia al E.I. en la Herramienta de atención interdisciplinaria. *Sujeta a la elaboración de la herramienta.*	• Digitando en la herramienta de atención interdisciplinaria los datos de los casos referidos por urgencia al E.I. (Disposición 11). • Completando en la herramienta las actividades las acciones de abordaje realizadas según corresponda al caso o situación referida y las acciones de abordaje subsecuente cuando corresponda. • Estableciendo de forma conjunta y colaborativa la fecha de la próxima atención y la persona profesional designada cuando corresponda, para realizar las acciones de abordaje subsecuente.	- E.I. de OL
9	Dar seguimiento a la niña, niño o beneficiaria, tanto de la estrategia intra como extramuros de la DNCC, que fueron	• Valorando y analizando el avance, retroceso o nueva situación asociada a la referencia por urgencia y/o denuncia realizada, luego de haber implementado las estrategias para la A.I definidas por el E.I. • Determinando si requiere o no: - **Continuar con la A.I.**: E.I define en sesión interdisciplinaria si mantiene o requiere ampliar, ajustar o diversificar las estrategias de abordaje con enfoque de Salud Pública, como parte de los	- E.I. de OL

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
	referidos por situación de urgencia	resultados de la intervención y se valora integralmente la situación. Continúa la atención y el registro en la herramienta de atención interdisciplinaria. - **No requiere continuar con A.I.**: se cierra el caso, se elabora el Reporte de A.I. (Anexo 9a y 9b) y se archiva en el Expediente A.I. de la niña, niño o beneficiaria con copia para archivar en el Expediente físico del cliente y beneficiaria en el establecimiento. • Atendiendo solicitudes de otras instituciones de la red de servicios, completando contra-referencia, coordinando acciones o emitiendo informes requeridos por superiores según situaciones atendidas y/ o denuncias realizadas. • Actualizando la información respecto al seguimiento brindado, según lo requerido en la herramienta de atención interdisciplinaria.	

C. Actividades relacionadas con la atención interdisciplinaria por parte del Equipo de OL.

N°	Tarea	Método	Responsables
1	Realizar la referencia para la A.I.	A partir de las necesidades identificadas de Atención Interdisciplinaria, proceda: • Completando de manera correcta la boleta de referencia para A.I cuando la niña, niño o beneficiaria requiera del apoyo profesional (Anexo 2.a. y 2.b.). • Comunicando a la beneficiaria o a la madre, padre o persona encargada de la niña o niño que ha sido referido a la atención interdisciplinaria. (Disposición 2) • Enviando de manera pronta y oportuna (dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles) la referencia física con el respectivo oficio de entrega de documentos a la Oficina Local, para el análisis interdisciplinario y priorización de la situación por parte del E.I. en la sesión interdisciplinaria más próxima. Como parte de esta tarea, se realiza coordinación de envío de la o las referencias para A.I. y el oficio de entrega de documentos, con colaboración de la persona ASSC3 o persona profesional del establecimiento. De no ser posible la entrega de la referencia física en el tiempo establecido, se debe enviar copia digital (escaneada o imagen de documento) por correo electrónico a la persona designada como enlace de A.I., y en su ausencia a la jefatura de OL; esta acción mientras se remite el documento físico a la brevedad posible, el cual se requiere de manera obligatoria. **Nota**: se aclara que una misma situación detectada, puede requerir de referencia al E.I. y/o referencia interinstitucional a una o más instituciones y/o denuncia. Estas acciones no son excluyentes ya que depende de cada caso.	- ASSC2, ASSC3 - Personas en cargos homólogos por contratación - Profesional de establecimiento CEN-CINAI - E.I de OL-ATE
2	Recibir la referencia en la OL	• Recibiendo la o las referencias y el oficio de entrega de documentos de los establecimientos por parte de las personas funcionarias de OL. • Colocando las referencias en el espacio en la Oficina Local designado para resguardar las referencias y documentación recibida para el E.I. de OL. En caso de recibir la referencia en digital por parte de la persona enlace de E.I., se acusa recibido. Además, se debe descargar tanto el correo (formato EML) como el documento adjunto y custodiarse en el archivo digital del E.I. para su uso y seguimiento. A su	-Persona oficinista, -Persona técnica administrativa, -Profesionales de E.I. de OL. -Jefatura de OL.

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
		vez, se debe imprimir la referencia e incorporar la copia en el expediente físico de A.I., estando disponible para uso del E.I. en el espacio de la Oficina Local debidamente identificado para tal fin.	
3	Verificar la información de la referencia enviada a OL para A.I.	• Corroborando el correcto llenado de la o las referencias físicas o digitales y verificando que la información esté completa previo a la sesión interdisciplinaria más próxima. Cuando hay duda o faltante de información de la referencia, se le consulta a la persona funcionaria que completó la boleta, vía telefónica o mediante otra vía que agilice el proceso y se completa la información faltante, evitando devolver el instrumento al establecimiento, de no ser que sea sumamente requerido para completar una nueva referencia. • Colocando nuevamente en el espacio designado para que esté disponible para uso del E.I. en el momento de la sesión interdisciplinaria. **NOTA:** esta tarea puede realizarse de manera simultánea con la siguiente.	- E.I de OL
4	Realizar la sesión interdisciplinaria.	• Realizando la sesión interdisciplinaria al menos **dos veces al mes**, de manera conjunta y colaborativa por parte del E.I. De requerirse más sesiones se debe considerar en la programación de actividades con aval de la jefatura de OL (Disposición 6). • Revisando las referencias y documentación recibida para la A.I. En caso de requerirse, solicitar a la persona que elaboró la referencia al E.I. ampliación de la información. • Procediendo con: - Análisis situacional: identificar signos de alerta, factores de riesgo y factores protectores, teniendo como insumo lo descrito en la boleta de referencia y sus anexos si los tuviera. (Disposición 7) - Valoración técnica: determinar la relación de los factores identificados y posible afectación en el crecimiento, desarrollo y salud (intensidad, frecuencia y persistencia) esta acción se realiza de manera integral entre todos los miembros del E.I. - Priorización: determinar el nivel de prioridad (Disposición 7). - Abordaje: establecer la frecuencia, periodicidad y estrategias de atención a implementar con Enfoque de Salud Pública. - Registrar los acuerdos en la Boleta de Análisis Situacional. • Determinando si la niña, el niño o beneficiaria recibirá la atención interdisciplinaria por parte del E.I., completando la información para uso del E.I. en la Boleta de Referencia a A.I. • Devolviendo la copia de la boleta de referencia de A.I. con el recibido del E.I. al establecimiento para su debido archivo en el Expediente físico del cliente y beneficiaria, y dejando la original para la apertura del expediente A.I. de la niña, niño o beneficiaria. • Elaborando y enviando la referencia interinstitucional y/o denuncia cuando corresponda (Disposición 8). • Elaborando la minuta de cada sesión interdisciplinaria, según el formato establecido a nivel institucional para reuniones (Anexo 8a). • Manteniendo de manera ordenada y debidamente custodiada toda la información y documentación vinculante a las sesiones realizadas por el E.I.	- E.I. de OL

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
5	Registrar la información de la referencia al E.I. en la Herramienta de atención interdisciplinaria *Sujeta a la elaboración de la herramienta.*	• Digitando en la herramienta de atención interdisciplinaria los datos de las niñas y niños que van a ser atendidos por parte del E.I, por una o más disciplinas según lo definido (Disposición 11). • Completando en la herramienta las actividades que se van a realizar y observaciones de la atención interdisciplinaria brindada o incluso acciones o actividades relevantes que se hayan desarrollado en el establecimiento, para su consideración en próximas atenciones. • Estableciendo de forma conjunta y colaborativa la fecha de la próxima atención y la persona profesional designada. • Considerando la información de cada caso para el análisis, abordaje y seguimiento por parte del E.I. **NOTA**: esta tarea puede realizarse de manera simultánea con la tarea anterior o puede programarse en otro momento según la necesidad del E.I. y en acuerdo con jefatura de OL.	- E.I. de OL
6	Brindar atención interdisciplinaria a la niña, niño, adolescente madre, mujer embarazada o en periodo de lactancia, tanto de la estrategia intra como extramuros de la DNCC	• Informando a la beneficiaria o a la madre, padre o persona encargada de la niña o niño las acciones a realizar como parte de la A.I., de manera que se promueva su participación en el proceso. Cuando corresponda, programar la fecha, lugar y hora de la atención (Disposición 2). • Implementando las estrategias para el abordaje interdisciplinario, sean individuales o grupales, con enfoque de Salud Pública, conforme lo definido y priorizado, en la frecuencia definida por el E.I. • Considerando que el abordaje es interdisciplinario pero la ejecución de las estrategias de atención definidas puede realizarse por uno o más miembros según lo defina el E.I. y no necesariamente debe participar todo el equipo de profesionales. Esto dependerá de las necesidades identificadas, la priorización y la definición de las estrategias a implementar en cada caso o situación referida. • Utilizando de manera coordinada y colaborativa, los instrumentos, técnicas, materiales y equipo, propios de cada disciplina para abordar de manera integral cada caso. • Planificando y realizando con la colaboración de ASSC2, ASSC3, profesional de establecimiento o personas contratadas para la atención integral de niñas y niños, la aplicación de los tamizajes de crecimiento, desarrollo y salud cuando se requiera, o el abordaje de temáticas específicas en sesiones educativas según lo indique las estrategias de abordaje. • Estableciendo la fecha de la próxima atención según la o las estrategias y priorización establecida por el E.I. • Cuando se detecten situaciones que así lo ameriten proceder a la elaboración y envío de la referencia interinstitucional y/o denuncia cuando corresponda. **Nota**: cuando exista dificultad de desplazamiento para la atención e implementación de estrategias, ya sea por vehículo institucional u otra razón relacionada con dificultades de acceso, valorar la viabilidad de utilizar medios virtuales. En las situaciones donde por algún caso no se logre desarrollar la actividad desarrollada, se debe consignar en la minuta de la sesión interdisciplinaria siguiente, detallando los motivos o circunstancias que se presentaron, por ejemplo: “se suspende o se reprograma la atención del día XX por motivo de…”	- E.I. de OL
7	Registrar la atención que los profesionales de	• Registrando la atención en la Herramienta de Atención Interdisciplinaria y el detalle de las estrategias de atención implementadas. Esta acción pueden realizarla de manera inmediata o posteriormente en la OL. De acuerdo con la organización de cada E.I., valorar la posibilidad de completar y actualizar la	- E.I. de OL

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
	E.I. brindaron a la niña, niño o beneficiaria.	herramienta en las sesiones de A.I. contempladas en la tarea n° 5, siempre y cuando se priorice la valoración y análisis de las referencias. • En caso de reuniones o entrevistas con padres, madres o personas encargadas, en el marco de las estrategias de atención individualizada o consejería se completa la Boleta de Eventos y Situaciones donde se consignan los principales aspectos retomados, recomendaciones, orientaciones y acuerdos tomados, archivando este documento en el expediente de A.I. en OL. • Anotando el objetivo de la visita en el libro de funcionamiento del establecimiento, por ejemplo: "*Hoy (fecha) se realizó visita al establecimiento con el objetivo de realizar acciones como parte de la atención/seguimiento interdisciplinario. Nombre completo y cargo de la persona profesional de OL*". • Registrando la asistencia a las actividades educativas que se realicen como parte de las estrategias de atención del E.I. y archivándolas en el establecimiento en carpetas según grupos prioritarios, acorde con lo indicado por el procedimiento de acciones informativas y actividades educativas. • De igual manera, cuando el E.I. recomienda la realización de actividades educativas grupales por parte de ASSC2, ASSC3, profesional de establecimiento o personas contratadas para la atención integral de niñas y niños, como parte de la promoción del Crecimiento y Desarrollo y en complemento a la atención de niñas y niños referidos a la A.I., se registran en la lista de asistencia y se archivan en carpetas según grupos prioritarios acorde con lo indicado por el procedimiento de acciones informativas y actividades educativas. **Nota:** El detalle de la atención y las acciones realizadas se llevan en el expediente de A.I. y se registrarán en la Herramienta de Atención Interdisciplinaria, por lo que no se requiere llenar ningún otro documento físico para ser incluido en el expediente del cliente o beneficiaria.	
8	Dar seguimiento a la niña, niño o beneficiaria tanto de la estrategia intra como extramuros de la DNCC, que fueron referidos a la A.I.	• Realizar llamadas, entrevistas, averiguaciones, tamizajes; entre otros; que permitan analizar el avance, retroceso o nueva situación asociada de la niña, niño o beneficiaria, luego de haber implementado las estrategias para la A.I definidas por el E.I. De igual manera realizar estas acciones para aquellas situaciones o casos reportados por urgencia y/o denuncia. • Determinando si requiere o no: - **Continuar con** la A.I.: E.I define en sesión interdisciplinaria si mantiene o requiere ampliar, ajustar o diversificar las estrategias de abordaje con enfoque de Salud Pública, como parte de los resultados de la intervención y se valora integralmente la situación. Continúa la atención y el registro en la herramienta de atención interdisciplinaria. - **Requiere realizar referencia interinstitucional y/o denuncia**: a otra institución cuando corresponda. Continúa el seguimiento (Ver anexos 3a, 3b, 4a y 4b, 5a y 5b). - **No requiere continuar con** la A.I.: se cierra el caso. Se registra en la herramienta, se elabora el Reporte de A.I. (Anexo 9a y 9b) y se archiva en el Expediente físico del cliente y beneficiaria en el establecimiento, con copia para archivar en el Expediente A.I. de la niña, niño o beneficiaria. • Atendiendo solicitudes de otras instituciones de la red de servicios, completando contra-referencia, coordinando acciones o emitiendo informes requeridos por superiores según situaciones atendidas y/ o denuncias realizadas. • Actualizando la información respecto al seguimiento brindado, según lo requerido en la herramienta de atención interdisciplinaria. De acuerdo con la organización de cada E.I., valorar la posibilidad de	- E.I. de OL

En revisión

N°	Tarea	Método	Responsables
		actualizar la herramienta en las sesiones de A.I. contempladas en la tarea n° 5, siempre y cuando se priorice la valoración y análisis de las referencias. **Nota:** En el caso de traslados de niñas, niños y beneficiarias que reciben A.I. se debe proceder acorde a lo indicado en la Disposición 03.	
9	Verificar el cumplimiento de las tareas del procedimiento.	• Analizando periódicamente el cumplimiento del procedimiento mediante la revisión de minutas, registros y controles utilizados por el E.I., acorde con lo establecido en el presente procedimiento. • Realizando periódicamente la revisión de la calidad de los datos e información registrada en la herramienta de atención interdisciplinaria según la guía de revisión de la herramienta (Ver anexo 10a y 10b). • Generando en la herramienta de atención interdisciplinaria el reporte de A.I., para el análisis de información de manera conjunta con el E.I. de OL. • Ejecutando acciones de mejora que surgen de la implementación del presente procedimiento. • Enviando la herramienta de atención interdisciplinaria ya revisada a la jefatura de Área Técnica Regional de acuerdo con el cronograma establecido por la Dirección Técnica.	- Jefatura de Oficina Local
10	Supervisar el cumplimiento del procedimiento de A.I. de la niña, niño o beneficiaria tanto de la estrategia intra como extramuros de la DNCC.	• Analizando periódicamente (al menos en el periodo de monitoreo y seguimiento establecido por la institución) el cumplimiento del procedimiento mediante la revisión de minutas, registros y controles utilizados por el E.I., acorde con lo establecido en el presente procedimiento. • Realizando periódicamente la revisión de la calidad de los datos e información registrada en la herramienta de atención interdisciplinaria según la guía de revisión de la herramienta. • Realizando la asesoría técnica y la supervisión capacitante a los equipos de OL en la implementación del procedimiento y de acuerdo con las necesidades identificadas. • Solicitando cuando sea necesario a la Jefatura de Oficina Local, las acciones de mejora que surgen de la implementación del presente procedimiento. • Generando el consolidado regional de niñas y niños atendidos según sea solicitado por la DT (malnutrición, factores de riesgo bio-psico-social, entre otros). • Analizando de forma colaborativa con el equipo interdisciplinario de Área Técnica los resultados de la herramienta de atención interdisciplinaria e implementación del procedimiento en cada OL para la toma de decisiones, estableciendo acciones de mejora según corresponda.	- Jefatura de Área Técnica - E.I. de ATE
11	Enviar el consolidado de la herramienta de atención interdisciplinaria al nivel Nacional.	• Enviando el consolidado de la herramienta de atención interdisciplinaria completa, revisada y actualizada de las Oficinas Locales de la Región a la Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo (UIVCD), según los periodos establecidos por la DT en el Nivel Nacional para insumo en los estudios de país, con copia a la Dirección Regional.	- Jefatura de Área Técnica Regional
12	Socializar los resultados de la implementación del procedimiento, en reunión de Jefaturas de Oficina Local	• Informando a las jefaturas de Oficina Local los resultados de la implementación del procedimiento de atención interdisciplinaria, según los reportes que brinda la herramienta para la toma de decisiones e implementación de acciones de mejora en la calidad del proceso por parte de las Jefaturas de Oficina Local, Área Técnica y persona Directora Regional, según corresponda.	- Persona Directora Regional. -

En revisión

En revisión

2.5. Autoevaluación y supervisión del cumplimiento

FAES Formulario para la autoevaluación y supervisión del cumplimiento del Procedimiento para la Atención Interdisciplinaria			
Código:	PCD-AI-PAI-P02	Fecha:	
Versión:	01	Páginas	

Instrucciones de llenado:

- En el encabezado del instrumento, llene los espacios correspondientes a cada uno de los ítems solicitados.
- En las dos primeras preguntas que se encuentran antes del cuadro marque "sí o no" según corresponda. Si la respuesta es "no" debe indicar las razones en observaciones. Si la respuesta es "sí" el uso del espacio de observaciones es opcional.
- En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea "No", aquí termina la autoevaluación y se pasa a la toma de medidas necesarias para que el procedimiento sea ejecutado.
- En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea "Sí", continúe llenando el cuadro.

Utilice la columna que corresponda a autoevaluación si usted es parte del equipo responsable de ejecutar el procedimiento y la de acompañamiento técnico o supervisión, si usted es el profesional designado para tal fin. Para cada criterio de valoración marque con X la opción "cumplido" o "no cumplido" según corresponda. Use el espacio de observaciones cuando lo considere necesario.
Se llena sólo una copia de este formulario y se archiva en la carpeta correspondiente en la sede del funcionario que ejecuta el procedimiento. Al terminar el llenado del formulario, coloque el nombre completo, la firma, la fecha y estampe el sello de OL o Región.

El procedimiento se ejecutó	Si: ( ) No: ( )	Observaciones
Se realizó en la periodicidad indicada	Si: ( ) No: ( )	Observaciones

Criterio de Valoración	Autoevaluación		Acompañamiento técnico o supervisión		Observaciones
	Cumplido	No cumplido	Cumplido	No cumplido	
Personas funcionarias con conocimiento en la adecuada implementación del presente procedimiento.					
Actividades para la atención y seguimiento interdisciplinario de clientes, beneficiarias y su grupo familiar en situación de riesgo biopsicosocial, incluidas de forma prioritaria en la programación de las personas funcionarias integrantes del equipo interdisciplinario a nivel local y regional.					
Personas profesionales de los equipos interdisciplinarios del nivel local y regional realizando con calidad, calidez y oportunidad la atención y seguimiento de clientes y beneficiarias de los servicios, que han sido referidos por situación de riesgo biopsicosocial.					
Profesionales de los equipos interdisciplinarios del nivel local y regional aplicando los diferentes enfoques que orientan este procedimiento, reconociéndolos como ejes estratégicos e indispensables para alcanzar la equidad en salud.					
Profesionales de los equipos interdisciplinarios de los diferentes niveles de gestión reconocen y promueven el trabajo intersectorial e interinstitucional, facilitando la activación de referencias, denuncias y/o notificaciones obligatorias, con el fin de garantizar una atención oportuna y de calidad.					

En revisión

Criterio de Valoración	Autoevaluación		Acompañamiento técnico o supervisión		Observaciones
	Cumplido	No cumplido	Cumplido	No cumplido	
Jefaturas de Oficina Local y Área Técnica con claridad en su rol gerencial como garante del cumplimiento, la programación, el monitoreo, asesoría y acompañamiento técnico del presente procedimiento, así como la toma de decisiones requeridas para la calidad, eficiencia y oportunidad de la atención interdisciplinaria.					
Jefaturas y personas funcionarias de Unidades de la Dirección Técnica, con claridad en su rol técnico-operativo (normativo) en la elaboración, actualización y asistencia técnica en lo relacionado con instrumentos, manuales, guías, disposiciones y otros documentos, necesarios para el cumplimiento con calidad, eficacia y eficiencia de este procedimiento.					
Personas de los tres niveles de gestión, promoviendo una cultura institucional basada en el trabajo interdisciplinario y colaborativo con el fin de fortalecer la atención integral dirigida a clientes, personas beneficiarias y sus familias.					
Personas de los tres niveles de gestión promoviendo el trabajo intersectorial e interinstitucional como eje estratégico indispensable para lograr la equidad en salud.					
Nombre y firma funcionario que ejecuta: _____ Fecha: _____ Nombre y firma funcionario que supervisa: _____ Fecha: _____					

2.6 Resultados

- Sesiones para la atención interdisciplinaria por parte de profesionales ejecutadas conforme a la programación establecida y registradas en la minuta correspondiente.
- Personas integrantes de los equipos interdisciplinarios en CEN-CINAI con actividades para la atención interdisciplinaria implementadas de manera oportuna, con calidad y calidez.
- Niñas, niños, adolescentes madres, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o beneficiarias atendidos y con seguimiento por parte del E.I de OL, según sus necesidades, prioridad y situación de referencia.
- Oficinas Locales de CEN-CINAI gestionando referencias y/o denuncias de manera oportuna con las instituciones correspondientes.
- Herramienta de atención interdisciplinaria con información de referencias, atención y seguimiento completa, revisada, actualizada y con calidad, disponible en cada Oficina Local.
- Integrantes de los equipos interdisciplinarios a nivel local y regional analizando periódicamente y de forma colaborativa la información generada por la herramienta de atención interdisciplinaria para la toma de decisiones e implementación de acciones de mejora.

En revisión

III. DISPOSICIONES.

Disposición 1. Atención interdisciplinaria en CEN-CINAI desde un enfoque de Salud Pública

Desde un enfoque de Salud Pública la atención interdisciplinaria se encuentra centrada en las personas, la familia y la comunidad, con énfasis en promoción de la salud y prevención. Implica identificar y abordar los factores que determinan la salud, personales, sociales y ambientales, es decir, el conjunto de condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen y que afectan o determinan de alguna manera su salud integral, funcionamiento y calidad de vida. Desde este enfoque se consideran también las condiciones generadas por las estructuras más amplias de las que son parte clientes y beneficiarias, como los sistemas en materia política, social, ambiental, laboral, seguridad, alimentaria, religiosa, educativa, económica, cultural, legislativa, entre otras (Cotonieto y Rodríguez 2021). Por lo que, el enfoque de Salud Pública reconoce al ser humano como un ser integral con dimensiones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales que funciona en relación con el mundo que le rodea. Es un enfoque científico, poblacional, integral, interdisciplinario e intersectorial basado en el modelo ecológico donde la persona influye en su entorno y este a su vez en la persona.

En este sentido, CEN-CINAI es parte de la red de servicios de salud pública de Costa Rica. Desde este enfoque, profesionales de los E.I. en CEN-CINAI realizan atención interdisciplinaria mediante acciones como:

- **Promoción de la salud:** informando y educando a las personas usuarias de la importancia de la creación de ambientes y entornos saludables, brindando recomendaciones y herramientas para que clientes y beneficiarias incorporen estilos de vida y prácticas cotidianas saludables que incluyan e incrementen alimentación variada y nutritiva, promoción de la lactancia materna, prácticas de higiene, salud oral, entornos e interacciones que promuevan una crianza y socialización democrática de sus hijas e hijos, incorporación de la actividad física diaria, prácticas diarias que mantengan una salud mental, fomento de entornos seguros, entre otros, buscando que las personas tomen decisiones informadas y saludables en su vida cotidiana y las incorpore en su diario vivir.

- **Prevención:** implementando medidas orientadas a reducir factores de riesgo en poblaciones de vulnerables, para evitar la aparición o aumento de enfermedades o problemas de salud ya sea individual o por grupos específicos, como parte de un abordaje integral, tales como: En concordancia con este enfoque se adopta la clasificación de prevención hacer esa aclaración.

    - **Prevención universal:** Según refiere Scoppeta y Avendaño (2021), la prevención universal se dirige a la totalidad de la población, sin distinción de niveles de riesgo individuales, su objetivo es promover condiciones saludables y reducir la exposición a factores nocivos para todas las personas, independientemente de si presentan o no factores de riesgo identificables. Implica el control de factores causales, predisponentes o condicionantes a fin de limitar o disminuir la exposición de las personas sanas a un factor de nocivo con recomendaciones a la población atendida. Desde este accionar se trata de crear condiciones saludables para evitar, aminorar o reducir factores que afectan la salud o enfermedades. Por ejemplo: abordaje individual o grupal que incluya recomendaciones para una alimentación balanceada evitando alimentos nocivos para la salud (exceso de sal, exceso de azúcar, alimentos ultraprocesados), métodos para higiene y mantenimiento en buenas condiciones de los alimentos que se consumen, importancia de la vacunación, suplementación y control prenatal en periodo de embarazo, recomendaciones para una crianza libre de maltrato físico, disminución del consumo de sal, uso correcto de métodos anticonceptivos y de protección, entre otros. La prevención universal puede incluir acciones de promoción de la salud, como la educación sobre hábitos saludables, ya que estas también contribuyen a evitar enfermedades.

    - **Prevención selectiva:** Según Gordon (1983) este tipo de prevención se encuentra dirigida a grupos específicos de la población que presentan un riesgo mayor que el promedio de desarrollar un problema de salud, sin que dicho problema haya sido aún diagnosticado. Identificando o detectando de manera temprana (en poblaciones en riesgo de adquirir una enfermedad), factores de riesgo a enfermedades, afecciones psicosociales, alteraciones del crecimiento, del desarrollo y salud antes de que se vuelvan más graves o causen complicaciones para detener lo antes posible la evolución de la enfermedad. Para ello, con base en los tamizajes o pruebas que se aplican en la institución, se identifican factores de riesgo y se realiza un abordaje oportuno. Implica también la referencia a los servicios de salud para la valoración y tratamiento específico, así como dar recomendaciones técnicas que favorezcan el mejoramiento continuo en grupos específicos con madres, padres y personas encargadas de poblaciones en riesgo ya determinadas, entre ellas, niñas y niños con malnutrición, con riesgo de retraso en el desarrollo o dificultades en el desarrollo del lenguaje, para abordar aspectos específicos, con el fin de mejor condición identificada. En la prevención selectiva, “el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el

En revisión

tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad" (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011; Vázquez et al., 2018; Junta de Andalucía, 2023). Además, se mantienen acciones de promoción de la salud en los diferentes ámbitos o dimensiones.

- **Prevención indicada:** Según refiere Scoppeta y Avendaño (2021), este tipo de prevención está dirigida a personas específicas que ya presentan signos tempranos, factores de riesgo altos o una condición de salud identificada, aunque no necesariamente con un diagnóstico formal establecido, por lo que se requiere de una atención o acompañamiento más personalizado. En este contexto se apoya, mediante la atención y seguimiento de situaciones referidas a A.I., el cumplimiento de controles médicos, tratamientos, asistencia a citas especializadas u otras acciones en personas con una enfermedad, padecimiento o alteración del crecimiento y desarrollo ya identificada o diagnosticada por los servicios de salud, a fin de apoyar en retardar o disminuir la aparición de secuelas u otras complicaciones. Se centra en el cuidado y seguimiento de enfermedades crónicas mediante acciones y recomendaciones que apoyen la recuperación, inclusión y participación en las actividades cotidianas. También, se mantienen acciones de promoción de la salud en los diferentes ámbitos o dimensiones.

El enfoque de Salud Pública contempla una perspectiva poblacional más que individual, con acciones de máximo beneficio para la mayor cantidad de personas posibles. Se centra en la comunidad y en las poblaciones, **buscando prevenir enfermedades y promover la salud a gran escala** mediante políticas, ambientes saludables y educación.

Diferencias entre el abordaje desde el Enfoque de Salud Pública vs. Abordaje desde un Enfoque Clínico

ASPECTO	ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA	ENFOQUE CLÍNICO
Finalidad	Promoción de la salud Prevención primaria, secundaria y terciaria Vigilancia del crecimiento, desarrollo y salud Acompañamiento familiar y comunitario	Realiza diagnóstico clínico Atiende la enfermedad mediante terapia especializada, prescripción de medicamentos Tratamientos especializados, curación y rehabilitación Actúa ante la aparición de un problema de salud.
Herramientas	Tamizajes crecimiento, desarrollo y salud. Consejería, educación, planes de acompañamiento. Articulación interinstitucional e intersectorial	Evaluaciones clínicas, estandarizadas y diagnósticas Exámenes físicos y mentales especializados Pruebas de laboratorio, imagenología, radiología Terapias clínicas especializadas e intervenciones médicas
Escenario	Establecimientos CEN-CINAI Hogares Comunidades intra y extramuros	Consultorio clínico, EBAIS o clínicas del primer nivel de atención, más cercano a la población. Hospitales que brindan atención médica en servicios de salud especializados del segundo nivel de atención. Hospitales especializados donde se abordan patologías complejas o problemas de salud poco prevalentes del tercer nivel de atención.
Acciones	Promoción de la salud Prevención de la salud Participación en comisiones y articulación interinstitucional e intersectorial Fomento de la Participación Social y comunitaria. Fortalecimiento de redes de apoyo familiar y comunitario. Fortalecimiento de factores protectores. Detección de alertas o factores de riesgo. Referencia oportuna a otras instituciones.	Resolver clínicamente dentro del servicio que diagnostica y dar tratamiento

Disposición 2: ¿Qué informar a los padres de familia de la Atención Interdisciplinaria en CEN-CINAI?

1. ¿Qué es la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI?
Es el trabajo coordinado de profesionales de distintas disciplinas (nutrición, psicología, terapia de lenguaje, educación, terapia física, entre otras) que, junto con la familia, identifican, promueven, previenen y atienden aspectos relacionados con el crecimiento, desarrollo y salud integral de las niñas, niños y beneficiarias, de las estrategias intra y extramuros.

Entre las acciones que se realizan se encuentran: la atención directa mediante estrategias de atención individual, grupal, actividades educativas al grupo familiar, referencias a otras instituciones, acompañamiento al grupo familiar en la tarea de crianza y socialización de las niñas y niños mediante recomendaciones puntuales ante las situaciones identificadas, entre otras, en concordancia con los Enfoques Centrado en la Familia y Corresponsabilidad de los Cuidados.

2. ¿Por qué se ofrece esta atención?
Porque las investigaciones en crecimiento, desarrollo infantil y salud muestran que las acciones desde temprana edad y con participación de la familia mejoran la nutrición, el aprendizaje temprano, el bienestar emocional y reducen riesgos y enfermedades en el futuro, por lo que los equipos de profesionales de CEN-CINAI apoyan a las familias para crear ambientes seguros que protejan de los peligros y ofrezcan oportunidades para aprender y mejorar el desarrollo integral.

3. ¿Qué se les brinda a las familias en la atención interdisciplinaria?
- **Atención**: análisis del crecimiento, desarrollo y salud, alimentación, relación con otras niñas y niños, relación familiar; identificación de aspectos que afectan la salud y aspectos que protegen la salud, observaciones en los CEN-CINAI, visitas al hogar, entrevistas y atención directa del personal de los establecimientos, acompañamiento al grupo familiar, sesiones individuales o grupales para atender situaciones específicas, sesiones educativas, entre otras.
- **Referencias a otras instituciones**: coordinación con otras instituciones cuando se requieran atenciones especificas: CCSS/EBAIS, PANI, MEP, Ministerio Público, INAMU, IMAS, INA u otras.
- **Seguimiento**: llamadas o entrevistas para conocer el avance de las acciones realizadas, así como un acompañamiento cuando se requiera.

4. ¿Cuáles son los derechos de las familias?
- Trato digno, información clara, participación en decisiones, accesibilidad y ajustes razonables, no discriminación.
- Gratuidad de los servicios institucionales.
- Atención directa a las necesidades de las niñas y los niños en el marco del interés superior.
- Manejo confidencial de la información suministrada, mediante el secreto profesional.
- Protección de datos (Ley 8968)

5. ¿Cuáles son los compromisos de las familias?
- Asistir puntualmente cuando se le convoque.
- Brindar información clara, completa y real cuando se le entreviste.
- Cumplir con las recomendaciones brindadas por las personas funcionarias de CEN-CINAI e informar en caso de dudas relacionadas con la atención que se le está brindando.

6. ¿Qué aspectos no contempla la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI?
- No se realizan diagnósticos médicos, psicológicos, del lenguaje u otros.
- No se emiten informes clínicos o recetas médicas, tratamientos farmacológicos o psicológicos.
- No se brinda psicoterapia clínica ni terapias especializadas.

Nota: Esta información debe ser comunicada a las familias en todas las modalidades de atención, no únicamente al momento de referir a la niña, niño o persona beneficiaria a la A.I., sino también al ingreso a la modalidad correspondiente. Esto forma parte de la oferta que brinda la Dirección Nacional de CEN-CINAI, en el marco del servicio de Promoción del Crecimiento y Desarrollo.

En revisión

En revisión

Disposición 3: Acciones referentes al contenido, conformación y traslado del expediente de A.I.

En el marco de la atención brindada por el Equipo Interdisciplinario (E.I.), resulta indispensable garantizar la adecuada documentación y trazabilidad de las intervenciones realizadas con cada niña, niño o persona beneficiaria referida. Por lo anterior, en el marco del presente procedimiento se conforma un expediente administrativo de carácter físico para la A.I. (en adelante denominado expediente de A.I.) que registre de manera ordenada, cronológica y completa todas las acciones efectuadas durante el proceso de atención, en concordancia con lo normado por la Unidad de Gestión Documental. La presente disposición técnica tiene por objetivo establecer los lineamientos para la apertura del expediente físico de A.I., la conformación del expediente y los documentos que lo integran, así como el cierre o traslado del expediente según sea el caso particular.

A su vez, se hace la aclaración que, dado que el expediente de A.I. contiene datos personales sensibles de las niñas, niños y personas beneficiarias, su uso estará restringido exclusivamente para las personas profesionales del E.I. responsables de la atención. Se deberá garantizar en todo momento la confidencialidad, integridad y resguardo de la información, en cumplimiento con la normativa institucional vigente, la Ley N.° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y demás disposiciones legales aplicables. El acceso, consulta, modificación o traslado de este expediente deberá realizarse únicamente por profesionales del E.I. y jefatura de OL quien es el personal autorizado y relacionado directamente con la gestión de la atención interdisciplinaria.

A. Apertura del Expediente Físico Administrativo de A.I.

La apertura formal del expediente de A.I. se realizará una vez recibida la boleta de referencia de la niña, niño o persona beneficiaria, la cual constituye el acto administrativo que da origen al proceso de registro y resguardo de la información. El expediente deberá identificarse conforme a los lineamientos establecidos por la Unidad de Gestión Documental y emplear la portada de A.I. (ver anexo 6)

Todos los documentos recibidos y/o generados como resultado de las atenciones brindadas deberán incorporarse íntegramente en el expediente de A.I., en orden cronológico ascendente (del documento más antiguo al más reciente). Cada folio deberá ser numerado de forma consecutiva con el fin de minimizar el riesgo de extracción, pérdida o incorporación extemporánea de documentos. Esta práctica fortalece la seguridad jurídica del expediente y asegura la integridad, trazabilidad y confiabilidad de la información contenida.

Este expediente tendrá carácter interanual, manteniéndose activo mientras continúe el proceso de atención y hasta la conclusión formal de las intervenciones que dieron lugar a su apertura, momento en el cual deberá seguirse el procedimiento de cierre o traslado correspondiente, según sea el caso.

B. Conformación del Expediente físico Administrativo de A.I.

La conformación del expediente inicia con la incorporación de la Boleta de Referencia a A.I. (original), la cual constituye el documento base que da origen al registro. Seguidamente, se deberá incluir la Boleta de valoración situacional (Anexo 7a y 7b), en la que se documenta el análisis del E.I., las decisiones adoptadas y las recomendaciones emitidas para el abordaje integral de la situación referida, por lo que esta boleta integra las acciones realizadas por parte del E.I. para cada niña, niño o persona beneficiaria. Posteriormente, se agregarán de forma ordenada y cronológica los documentos que complementan el expediente.

Es decir, el expediente se conforma de los siguientes documentos:

- Boleta de Referencia a A.I. (original).
- Boleta de valoración situacional.
- Registro de visita domiciliar (Cuando corresponda)
- Copia de Referencias y/o contra-referencias interinstitucionales, según corresponda.
- Cualquier otro documento técnico o administrativo que resulte pertinente y esté directamente relacionado con la situación referida a la atención interdisciplinaria, ya sea generado por los profesionales del E.I., personas encargadas de atención integral o aportado por la familia.
- Si en el marco de la A.I., se realizan reuniones o entrevistas a madres, padres o personas encargadas, en las que se exploran situaciones familiares relacionadas con la situación referida a A.I., en las que se brindan recomendaciones u orientaciones a la familia, se utiliza la boleta de eventos y situaciones para consignar información primordial, en estos casos esta información se archiva en expediente administrativo de A.I.
- Si como parte de la A.I., se realizan acciones de acompañamiento técnico al personal del establecimiento, se utiliza la boleta de eventos y situaciones para consignar información primordial, en estos casos esta información se archiva en expediente administrativo de A.I.
- Reporte de situación atendida: este reporte consigna las acciones ejecutadas, las atenciones brindadas, las recomendaciones emitidas y los seguimientos efectuados durante el período de la atención interdisciplinaria. Este reporte se completa de manera anual o cuando la niña, niño o beneficia se traslade a otro establecimiento.

En revisión

En este expediente se debe consignar la atención interdisciplinaria brindada a la niña, niño o persona beneficiaria por las personas profesionales de todas las disciplinas que conforman el E.I., asegurando así la continuidad del registro y la responsabilidad de las intervenciones realizadas, de tal manera, que este expediente deberá resguardarse en un lugar accesible para uso de todo el E.I., con condiciones de acceso restringido tales como archivadores con llave, u oficinas.

Se exceptúa la incorporación de información específica y detallada que, por su naturaleza, constituye información confidencial. Asimismo, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y/o PANI, deberán ser archivadas en un expediente independiente, destinado exclusivamente para ese fin, a fin de resguardar la confidencialidad y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. El expediente de denuncias será custodiado por la persona profesional de Psicología, o quien la jefatura designe en caso de que la OL no disponga de esta disciplina profesional.

C. Cierre del Expediente de A.I.

Se considerará procedente el cierre de un expediente de A.I. una vez que la situación que motivó la referencia de la niña, niño o persona beneficiaria haya sido atendida de manera integral por las personas funcionarias del E.I., y que se evidencie el logro del propósito u objetivo de la Atención Interdisciplinaria con base en la condición o necesidad que dio origen al proceso de atención.

Cuando la acción realizada por el E.I. consista en la emisión de referencias interinstitucionales o en la presentación de denuncias ante las instancias competentes, el expediente se mantiene activo, dado que estas acciones requieren seguimiento posterior por parte del equipo, con el fin de verificar avances, resultados y efectos en la situación de la niña, niño o persona beneficiaria. El cierre se realizará cuando la situación haya recibido la atención por parte de la instancia a la que fue referida y el E.I. lo determine.

Al momento de proceder con el cierre del expediente, se deberá completar el Reporte de situación atendida, en el que se consignen, de manera ordenada y cronológica, las atenciones brindadas, las estrategias de intervención implementadas, los acuerdos adoptados y los resultados obtenidos. Este informe tendrá como propósito documentar de forma integral la contribución del E.I. al avance, mejora o resolución de la situación que dio origen a la apertura del expediente físico de A.I. Se hace la salvedad que este reporte contiene información general, por lo que no se brindan detalles específicos y confidenciales de la situación atendida.

El reporte deberá ser revisado y firmado por todas las personas funcionarias del E.I. que participaron en la atención, así como de la jefatura de OL, en señal de conformidad y validación del proceso descrito. Finalmente, dicho reporte se incorporará como último documento dentro del expediente de A.I., enviándose una copia al expediente de clientes y beneficiarias, asegurando la continuidad del registro, la integridad documental y el cumplimiento de los lineamientos de gestión documental establecidos por la institución.

D. Traslado del expediente.

Cuando una niña, niño o persona beneficiaria atendida por el E.I. requiera ser trasladada a otro establecimiento fuera de la competencia de la OL, ya sea hacia otra OL o a una Región diferente, y la situación referida requiera continuar con atención y seguimiento por parte de otro E.I., se deberán ejecutar las siguientes acciones:

1. Elaboración del reporte de situación atendida: que detalle las atenciones y seguimientos realizados por el E.I., incorporando, de ser pertinente, recomendaciones que faciliten la contextualización y el abordaje de la situación por parte del nuevo E.I. El reporte deberá incluir las observaciones más relevantes de la atención interdisciplinaria brindada, las acciones ejecutadas, avances alcanzados y consideraciones prioritarias que deban ser atendidas en la nueva etapa del proceso.

2. Verificación del expediente: Comprobar que el expediente de A.I. se encuentre completo, organizado y foliado conforme a los lineamientos de la Unidad de Gestión Documental, garantizando la integridad y continuidad del registro.

3. Formalización y envío del traslado: Realizar el traslado del expediente utilizando la Boleta de Traslado Definitivo de Expedientes de Clientes y Beneficiarias, consignando en el apartado de observaciones que se trata de un expediente confidencial y de uso exclusivo del E.I. El expediente de A.I., deberá enviarse en sobre sellado, a fin de resguardar la confidencialidad y seguridad de la información.
   Nota: El expediente de A.I., debe ser dirigido a la OL que corresponda el nuevo establecimiento, por lo que debe trasladarse en un sobre sellado y separado del Expediente del cliente y beneficiaria que se destina al nuevo establecimiento, en virtud de que va dirigido al E.I. de la nueva OL. Se puede utilizar una misma Boleta de Traslado Definitivo de Expedientes de Clientes y Beneficiarias.

En revisión

4. Registro del traslado: Llevar el Control de traslados de expedientes de clientes y beneficiarias, de todos los expedientes de A.I. trasladados, utilizando la plantilla (Control de traslados de expedientes de clientes y beneficiarias) proporcionada por la UGD, esto como medida de control administrativo y para garantizar la trazabilidad de la documentación. Además, registrar en la Herramienta de A.I. el expediente como pasivo debido al traslado.

El cumplimiento de lo aquí establecido es de acatamiento obligatorio para todo el personal de los Equipos Interdisciplinarios, a fin de garantizar un manejo uniforme, seguro y confidencial de los expedientes de A.I. Cualquier situación no contemplada en esta disposición deberá ser elevada a la Dirección Técnica para su análisis y resolución.

Disposición 4: Vías de atención relacionadas con la solicitud de atención interdisciplinaria.

Respecto a las situaciones identificadas con necesidades de atención interdisciplinaria, se requiere detallar las vías de atención, ya sea situaciones para la atención inmediata por emergencia o urgencia, o las situaciones para la atención no inmediata por parte del E.I., pero si oportuna por parte del equipo interdisciplinario de OL y/o ATE.
Partiendo de lo anterior, se aclaran algunos ejemplos, aspectos o acciones específicas que se deben realizar para una atención pronta, oportuna, adecuada y eficaz en cumplimiento con lo que indica en el presente procedimiento.

1. Vía de Atención inmediata:

Se refiere a esas situaciones que requieren de una atención rápida, inmediata y eficaz ya sea por emergencia o urgencia que ponen en riesgo la vida, salud, seguridad o bienestar de la niña, el niño o beneficiaria.
Se debe identificar si corresponde a una atención inmediata por emergencia o por urgencia, ya que de ello depende la activación de la atención correspondiente.

1.a.Emergencia.

Se refiere a aquellos casos de gravedad que ponen en peligro la vida y la salud de las personas o la propiedad de CEN-CINAI, por lo que requiere una atención inmediata. Para estas situaciones de emergencia, es indispensable el actuar de manera expedita y oportuna con el objetivo de salvaguardar la vida de las niñas, niños y/o personas beneficiarias, por lo que se debe activar la llamada al 9-1-1 para la atención de la situación de emergencia, así como, comunicar a madre, padre o persona encargada y a Jefatura de OL para el apoyo requerido, o realizar la denuncia cuando corresponda según sea la situación presentada, entre ellas podemos mencionar:

- Inconsciencia, infarto o paro cardiorrespiratorio.
- Dolor torácico.
- Asfixia.
- Intoxicaciones.
- Convulsiones.
- Dificultades para respirar.
- Cambios repentinos en el estado mental (tales como confusión dificultad para despertarse).
- Desmayo o pérdida del conocimiento
- Incapacidad para ponerse de pie o caminar.
- Caídas desde una altura considerable
    - Ruptura completa de huesos (separación completa de huesos).
    - Riesgo de pérdida de un miembro u órgano.
- Quebraduras con exposición de hueso.
- Electrocuciones.
- Pérdida abundante de sangre.
- Heridas profundas de arma blanca o fuego.
- Dolores repentinos y graves que imposibilite movilidad.
- Expectoración o vómito con sangre.
- Reacciones alérgicas.
- Lesión en la cabeza o en la columna.
- Vómitos severos y persistentes.
- Trabajo de parto en proceso.
- Amenaza de muerte.
- Accidentes de tránsito o laborales.
- Situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
- Lesiones evidentes por aparente violencia física o sexual: hematomas o excoriaciones en el cuerpo, marcas de posibles golpes, ropa interior rota, sucia o manchada de sangre, lesiones en zona genital y/o anal, sangrado alrededor de la boca, vagina y/o ano, infecciones/ picazón/ hinchazón en genitales, dolor al orinar, revelaciones, entre otros, que indiquen que la niña, niño o beneficiaria se encuentra en situaciones de abuso o violencia.
- Comportamientos suicidas
- Comportamientos homicidas: actos de violencia intencionada hacia otra persona.
- Entre otras que pongan en peligro la vida.

Nota: Las siguientes situaciones, si bien no se clasifican como un riesgo eminente para la vida, requieren atención oportuna e inmediata por parte de otras instituciones; debido a ello se debe informar de inmediato a la madre, padre o persona encargada y llamar al 9-1-1 para la atención requerida:

- Torcedura o esguinces de pies, manos o dedos

En revisión

- Quebradura sin exposición de huesos.
- Intoxicaciones.
- Situaciones de riesgo de niñas, niños y/o beneficiarias asociadas con ingesta de alcohol y/o drogas.
- Entre otras que requieran atención médica.

En situaciones relacionadas con comportamientos suicidas considerar lo siguiente:

- El comportamiento suicida se entiende como la diversidad de comportamientos que incluyen pensar en el suicidio (o ideación suicida), planificar el suicidio, intentar el suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho. Organización Mundial de la Salud (2014). El comportamiento suicida es un continuum de conductas.

- Para efectos de este procedimiento se adopta lo indicado en la Normativa Nacional para la Articulación Interinstitucional en el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida N° 40881 – S y se considera una emergencia de atención inmediata, cuando se identifica:

  - Ideación suicida: idea o pensamiento recurrente sobre quitarse la vida sin intentarlo. La ideación suicida es un constructo cognoscitivo directamente vinculado con el intento de suicidio.
  - Comunicación suicida: acto interpersonal en el que se transmiten pensamientos, deseos o intencionalidad de acabar con la propia vida, para los que existe evidencia implícita o explícita de que este acto de comunicación no supone por sí mismo una conducta suicida. La comunicación suicida es un punto intermedio entre la ideación suicida (cogniciones) y la conducta suicida. En esta categoría se incluyen aquellas comunicaciones verbales o no verbales, que pueden tener intencionalidad, pero no producen lesiones. Existen dos tipos de comunicación suicida:
    - Amenaza suicida: acto interpersonal, verbal o no verbal, que podría predecir una posible conducta suicida en el futuro cercano.
    - Plan suicida: es la propuesta de un método con el que llevar a cabo una conducta suicida potencial.
  - Intento de suicidio: conducta potencialmente lesiva auto infligida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede provocar o no lesiones, independientemente de la letalidad del método.
  - Conducta suicida no determinada: conducta con grado indeterminado de intencionalidad suicida que puede resultar sin lesiones, con lesiones o causar la muerte (muerte auto infligida con grado indeterminado de intencionalidad).
  - Suicidio Consumado: Es el momento en que se logra concretar la autoeliminación, se habla del fallecimiento de una persona por una acción directamente dirigida hacia sí misma, ejecutada precisamente con el fin de acabar con su vida.

- Ante las manifestaciones de conductas suicidas que pueden ser identificadas en el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de las modalidades de atención, tanto en las estrategias intra como extramuros en CEN-CINAI, se debe llamar al 9-1-1 y seguir las indicaciones recibidas para la atención de la situación de emergencia y además solicitar apoyo de la persona profesional en psicología de la Oficina Local o Regional.

- En las situaciones de suicidio u homicidio consumado, se debe llamar al 9-1-1 explicar la situación presentada y seguir las indicaciones, solicitando apoyo de la persona profesional en psicología de la Oficina Local o Regional. En estos casos es importante mantener intacta la escena donde ocurrieron los hechos. Procurar mantener la calma de las personas presentes en el lugar, suspender las actividades que se están desarrollando.

Ante la identificación de cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, se deberá informar de manera inmediata a la persona profesional en psicología del Equipo Interdisciplinario (E.I.) de OL, con el fin de atender la situación oportunamente, fortalecer los factores de protección disponibles y prevenir la posible consumación de hechos que pongan en riesgo la salud, la vida o la integridad de la persona. De manera simultánea, y en coordinación con dicho profesional, se gestionará la referencia del caso al centro de salud correspondiente para su atención especializada, así como al E.I. para el seguimiento respectivo.

Traslado de niña, niño adolescente madre, mujer embarazada o en periodo de lactancia o beneficiario del establecimiento a un centro médico por medio de ambulancia o rescate:

Ante situaciones de emergencia que se presenten en el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de las modalidades de atención, tanto en las estrategias intra como extramuros en CEN-CINAI, que requieran traslado a un centro médico, se pueden presentar tres escenarios:

En revisión

a. A través del 9-1-1 se coordina el traslado y la atención de la situación de manera inmediata. En primera instancia, es importante informar y coordinar con la persona encargada o contacto de emergencia de la niña, niño o persona beneficiaria para que acompañe en un posible traslado. Si en el momento de la emergencia no es posible la presencia de la persona encargada o familiar, se debe coordinar con la Jefatura de OL, para que una persona funcionaria acompañe a la niña, niño o beneficiaria en el traslado al centro médico, mientras llega la persona encargada o familiar al sitio.
b. Si coordinando con el 9-1-1, no se tiene disponibilidad en ese momento de ambulancia para realizar el traslado, se coordina para que la madre, padre o persona encargada realicen el traslado hacia el centro médico. En este caso, es importante solicitar el nombre completo y el código de la persona funcionaria que informa la falta de ambulancia, y registrar estos datos en el libro de funcionamiento, junto con el nombre de una persona que sirva como testigo de la información proporcionada durante la llamada.
c. Si coordinando con el 9-1-1, no se tiene disponibilidad en ese momento de ambulancia para realizar el traslado, y tampoco ha sido posible contactar a la persona encargada en caso de emergencia o esta persona no puede llegar en el tiempo requerido, como última instancia y debido a que por la situación de emergencia se requiere salvaguardar la vida, se procede a coordinar con la Jefatura de OL, para trasladar a la niña, niño o beneficiaria en un carro particular según los recursos disponibles en el lugar al centro médico en compañía de una persona funcionaria de la institución. Se deberá solicitar el nombre completo y el código de la persona funcionaria que comunique la falta de ambulancia, y dejar constancia de estos datos en el libro de funcionamiento, incluyendo además el nombre de una persona que sirva como testigo de lo informado y de la situación ocurrida.

En las situaciones de emergencia donde se requiere trasladar a la niña, niño, adolescente madre, mujer embarazada o en periodo de lactancia, no se debe realizar el llenado de la boleta de referencia interinstitucional, ya que en estos casos las instituciones que atienden poseen los protocolos de atención y documentación que se completa al momento de la emergencia. En su lugar, se procede a anotar lo sucedido en el Registro de Eventos y situaciones (Anexo 11a y 11b) y se archiva en el Expediente físico del cliente y beneficiaria en el establecimiento.

NOTA: Si posterior a la situación de emergencia presentada, se detecta que la niña, niño, adolescente madre, mujer embarazada o en período de lactancia o beneficiario, requiera ser atendido por los profesionales de Oficina Local en atención interdisciplinaria, en ese caso se procede a completar la Boleta de Referencia a A.I (Anexo 2a y 2b) y se continúan con las tareas establecidas para el proceso de atención interdisciplinaria por parte de E.I de OL.

1.b. Urgencia:

Es una situación que necesita atención pronta y oportuna, ya que presenta una afección en la vida cotidiana, pero no supone una amenaza inminente para la vida. En estos casos se debe comunicar de manera directa con la persona profesional de OL, vía telefónica o por el medio que se tenga establecido en la OL.

La persona profesional de OL según disciplina y de acuerdo con la necesidad reportada, apoya en lo que refiere a la ruta a seguir para el abordaje de la situación, recomendaciones, o ajustes de las actividades cotidianas para la atención en el establecimiento, entre otras, así como, referencia interinstitucional y/o denuncia cuando se requiera.

Como, por ejemplo, una alergia alimentaria, en la cual se requiere de una modificación de menú por parte de la persona profesional en nutrición de OL., con el fin de evitar reacciones adversas y reciba la modalidad de atención requerida. Esta situación debe ser atendida lo más pronto posible, y de manera paralela, se debe completar el documento de referencia al E.I. para que quede consignado y se le brinde la atención y seguimiento correspondiente.

A continuación, se detallan algunas situaciones que se catalogan como urgencia:

En revisión

- Ajuste en el menú cíclico regional para consumo en el establecimiento ante indicación de alergia o intolerancia.
- Detección o sospecha de alguna situación que constituya un delito, ya sea como víctimas o testigo.
- Sospecha de abuso, negligencia o violencia en cualquiera de sus manifestaciones con o sin revelación.
- Situaciones identificadas por inadecuada asistencia primaria (falta de acceso a servicios de salud, tratamiento, y la falta de seguimiento adecuado de pacientes).
- Embarazo en menores de edad (menores de 13 años) y sospecha de relaciones impropias (de 13 a menos de 15 y de 15 a menos de 18 años).
- Crisis emocional o situación de desorganización y/o desequilibrio emocional asociados a acontecimientos en el contexto familiar o de salud.
- Manifestaciones físicas, comportamentales o emocionales asociadas a eventos traumáticos inesperados en el establecimiento o contexto familiar.
- Otras que requieran apoyo profesional por parte del E.I. de manera inmediata.

Situaciones de Sospecha o Riesgo de suicidio

- Autolesión/gesto suicida: Conducta potencialmente lesiva auto infligida para la que existe evidencia, implícita o explícita, de que la persona no tiene la intención de matarse. La persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir con alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones, provocar lesiones o provocar la muerte (muerte auto infligida no intencionada).
- Sospecha de manifestación asociada al comportamiento suicida: Se refiere a cualquier duda o sospecha aparente que se encuentre asociada a los comportamientos suicidas.

Cuando se identifique alguna de las situaciones antes descritas, se debe comunicar de manera inmediata la situación a la persona profesional en psicología del Equipo interdisciplinario de OL para la atención de la situación, y brindarle los factores de protección necesarios para prevenir la consumación de hechos y favorecer la salud mental. De manera paralela y con ayuda de la persona profesional del E.I., se debe realizar la referencia según corresponda y al E.I. para el seguimiento respectivo.

Nota: En los casos donde se identifique que la situación y dinámica familiar es un factor de riesgo para la persona menor de edad, se debe realizar la denuncia al PANI.

Situaciones relacionadas con Bullying

Comportamiento físico persistente, amenazante y agresivo, o abuso verbal dirigido hacia otras personas, especialmente hacia aquellas más jóvenes, más pequeñas, más débiles o en alguna otra situación de desventaja relativa (APA, 2018), ya sea por sus características o su forma de vida: orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras (MEP,2016). Más que un incidente aislado, el acoso es un patrón de comportamiento (UNICEF, 2019). Esta forma de violencia puede ser de tipo verbal (insultos, burlas, sobrenombre), físico (empujones, golpes, pellizcos), psicológica (amenazas, intimidación, control), social (exclusión), de índole sexual, material o cibernética (UNICEF, 2019).

Una situación de bullying se caracteriza por lo siguiente:

- Las conductas se manifiestan de manera intencional, siendo que estas acciones son premeditadas con la intención de causar dolor y sufrimiento (físico, psicológico y social).
- Existe una desigualdad de poder, es decir, la persona que recibe la agresión es percibida como objetico fácil de intimidar, vulnerable, desprotegida y sin recursos para actuar y, quien ejerce la agresión abusa de su poder físico o psicológico para intimidar y maltratar. El objetivo de la intimidación es lograr el dominio y control.
- Los eventos se manifiestan de manera reiterada, continua y sostenida en un período de tiempo, no es un episodio aislado.
- Este tipo de violencia se manifiesta entre iguales, porque suele ocurrir entre niñas, niños y adolescentes de un mismo grupo o de edades similares.

En revisión

- Es silenciosa e invisible, porque quienes agreden se cuidan de que las personas adultas no se percaten de sus actos de matonismo y porque la víctima y los espectadores guardan silencio de las repetidas acciones de violencia que experimentan y perciben.
- Algunas veces es provocado por las mismas personas adultas usando frases o palabras que pueden sonar graciosas pero que estigmatizan como: “gordito”, “flaquita”, “negrita”, “retardado”, “tartamudo”, entre otros.

Cuando se identifique alguna sospecha o caso de bullying se debe comunicar de manera inmediata la situación a la persona profesional en psicología del E.I de OL o quien la jefatura de OL designe para la atención de la situación, y así brindarle los factores de protección necesarios con el fin de minimizar los riesgos y garantizar la protección de los derechos de las niñas y los niños.

2. Vía de Atención no inmediata:

Son las acciones por desarrollar cuando se identifican situaciones en las modalidades de atención que requieren de una atención integral por parte de las personas profesionales de OL y/o ATE en una o más disciplinas, que permitan lograr de manera oportuna mejorar la salud, bienestar, desarrollo y calidad de vida de las niñas, niños y beneficiarias.

Dentro de estos casos o situaciones contemplados con atención no inmediata están:

- Niñas y niños con malnutrición según los resultados de la evaluación del estado nutricional. se recuerda que, para los casos de desnutrición severa, desnutrición, baja talla severa, baja talla, sobrepeso y obesidad, deben referirse al EBAIS según el área de atracción.
- Cuando se obtiene rojo en el resultado global del EDIN II ya que indica riesgo de retraso del desarrollo o cuando se identifican resultados recurrentes en los que no hay progreso en las evaluaciones subsiguientes, lo cual puede indicar un rezago en el desarrollo.
- Cuando se obtiene 1 o 0 puntos en una o más áreas del desarrollo sin logro de la edad anterior en el EVADE, ya que representa un riesgo de retraso en el desarrollo.
- Signos de alerta relacionados con los tamizajes de salud: auditivo (dudoso o mal), visual (visión funcional limitada, visión subnormal, ceguera legal) o de salud oral (Riesgo moderado, Riesgo alto y Riesgo severo)
- Cuando se han empleado estrategias de mediación pedagógica como lo son ajuste en las rutinas diarias, actividades de estimulación, fortalecimiento de hábitos, entre otras, con el fin de favorecer el desarrollo de conductas y habilidades identificadas, pero no se evidencia una mejora o progreso en el aprendizaje con las estrategias aplicadas.
- Cuando se identifiquen factores de riesgo y signos de alerta a nivel individual, familiar o social que afecten la salud y desarrollo integral de clientes y beneficiarias tales como: afecciones o cambios de comportamiento asociadas enfermedades, situaciones familiares o pérdidas, aislamiento social, alteraciones de los hábitos diarios sueño, (alimentación, control de esfínteres), llanto frecuente u otras dificultades de índole emocional, entre otros, que requieren la intervención de profesionales de diferentes disciplinas para abordarlas de manera integral.
- Situaciones en las que la niña o el niño muestra comportamientos desafiantes, agresivos, disruptivos, ansiosos que afectan negativamente la interacción familiar y social.
- Niñas o niños clientes de la institución con alguna condición de salud que afecta temporal o de manera crónica su comportamiento, cognición o aprendizaje (pueden o no estar en situación de discapacidad)
- Sospecha de alteraciones del neurodesarrollo (TDAH, TEA, Trastornos Específicos del Aprendizaje) que afecta el comportamiento, cognición o aprendizaje.
- Cuando la madre, padre, persona encargada de niñas o niños clientes de CEN CINAI requieran A.I. en lo relacionado con la tarea de crianza de sus hijas e hijos.
- Otras situaciones que requieran atención interdisciplinaria por parte del E.I.

En revisión

Disposición 5: Consideraciones para la atención de niñas y niños con malnutrición

La presente disposición establece las consideraciones para la A.I. de niñas y niños con malnutrición y se encuentra alineada con la legislación nacional, específicamente:

- Norma Nacional de uso de las gráficas antropométricas para valoración nutricional de 0-19 años, Decreto No. 3917-S.
- Reglamento a la ley N°9845 según decreto ejecutivo N°42336-S. Reglamento de Vigilancia de la Salud, Notificación de los eventos de salud.
- Norma Nacional para la Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad oficializada por decreto ejecutivo N°44780-S.

Es importante indicar que para las intervenciones de niñas y niños con malnutrición se recomienda considerar que la doble carga de la malnutrición (DCM), que es la coexistencia de la desnutrición (ej. deficiencias de micronutrientes, bajo peso, desnutrición aguda y retraso del crecimiento en los niños) y el sobrepeso, obesidad y Enfermedades No Transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta (RD). Esta DCM perjudica la salud a lo largo del curso de la vida, pero la manifestación de la malnutrición temprana en la vida es particularmente dañina (Wells, Wibaek, Poullas, 2018). Desde este enfoque se debe tener claridad de que existen factores de riesgo y conexiones biológicas comunes para el desarrollo de la malnutrición tanto por deficiencia como por exceso.

En la actualidad, la DCM requiere de acciones de doble propósito, las cuales tienen como objetivo prevenir o reducir simultáneamente el riesgo de deficiencias nutricionales que conducen a deficiencias de bajo peso, emaciación, retraso del crecimiento o micronutrientes, y obesidad o ENT-RD, con la misma intervención.

En virtud de lo anterior, tras la revisión integral de la situación referida para la A.I. de la niña o niño con malnutrición, se recomienda que el E.I considere lo siguiente:

1. Verificar el estado de malnutrición, mediante el software ANTHRO (realizado por el profesional en nutrición), con el propósito de garantizar la precisión en la evaluación del estado nutricional infantil con los patrones de referencia de OMS.

2. Confirmar que las niñas y niños detectados con **obesidad, desnutrición, desnutrición severa y/o baja talla severa**, hayan sido notificados por parte del personal de establecimiento de forma oportuna y con la información completa ante la autoridad sanitaria, según el procedimiento establecido.

3. Confirmar que las niñas o niños detectados con malnutrición (**desnutrición, desnutrición severa, baja talla, baja talla severa, sobrepeso, obesidad)**, hayan sido referidos al EBAIS según área de adscripción.

4. Considerar en el análisis situacional todos los factores de riesgo y protectores a nivel individual, familiar y comunitario asociados a la situación referida, de manera que la niña o niño con malnutrición reciba la atención integral e interdisciplinaria.

5. Como parte del plan de atención, implementar estrategias de promoción de la salud y autocuidado, enfocadas en hábitos alimentarios saludables, la importancia de la actividad física, el bienestar emocional y la autoestima, especialmente para niñas y niños con sobrepeso y obesidad. Estas estrategias deben ser inclusivas, ofrecer un trato humanizado, libre de estigmas y discriminación y fomentar un enfoque positivo hacia la salud.
6. Considerando la Norma Nacional para la Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad oficializada por decreto ejecutivo N°44780-S, los casos detectados con sobrepeso y obesidad, se deben contemplar las siguientes acciones de manera interdisciplinaria:

Acción	Descripción.
Prevención del sobrepeso y la obesidad.	Promover y facilitar la continuidad de la lactancia materna temprana y exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continua hasta los dos años y más, así como facilitar un adecuado inicio y seguimiento de una alimentación complementaria óptima, en todos sus niveles de atención.
	Promover en la población usuaria la adopción de estilos de vida saludable, incluyendo los siguientes temas: alimentación saludable, consumo moderado de sodio, no consumo de alcohol y tabaco, no vapeo, higiene del sueño, equilibrio de la microbiota, la salud mental y realización de actividad física y otros que surjan de la evidencia científica.

En revisión

Abordaje del sobrepeso y la obesidad	Brindar recomendaciones o mensajes nutricionales a la persona menor de edad con sobrepeso u obesidad. Estos deben ser aplicables en su cotidianidad y comunicados de manera sencilla y concreta, acorde con la edad, incorporando el juego y actividades lúdicas dinámicas, retadoras, divertidas y reforzando los factores protectores de su contexto alimentario.
	Animar a las personas con sobrepeso u obesidad a aumentar su nivel de actividad física, reforzando sus beneficios para la salud.
Se recomienda considerar los temas establecidos en la Norma Nacional para la Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad al momento de planificar las acciones de intervención del equipo interdisciplinario con esta población. Asimismo, con el fin de maximizar la cobertura y el impacto de las intervenciones, se dispone que dichas intervenciones procuren un doble propósito, desarrollando contenidos y actividades tanto para niñas y niños con sobrepeso u obesidad como para aquellos que presentan desnutrición, siempre que las condiciones lo permitan. Estas estrategias deben ser inclusivas, ofrecer un trato humanizado, libre de estigmas y discriminación por el peso, y fomentar un enfoque positivo hacia la salud.	

7. Desarrollar e implementar acciones dirigidas no solo a las niñas y los niños en atención interdisciplinaria, sino también a sus familias y entorno cercano. Estas acciones deben incluir procesos de educación alimentaria y nutricional, promoción de estilos de vida saludables, fortalecimiento de prácticas de autocuidado, y sensibilización sobre factores de riesgo y protectores asociados a la malnutrición. Asimismo, deberán articularse con redes comunitarias e interinstitucionales, favoreciendo un abordaje integral, participativo y sostenible desde un enfoque poblacional.

8. Mantener un acompañamiento técnico a través de estrategias de sensibilización y educación continua, dirigidas al personal del establecimiento, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y competencias técnicas para ofrecer una atención de calidad a las niñas y niños con malnutrición y sus familias.

9. Garantizar la referencia interinstitucional cuando así se requiera, considerando factores de riesgo y protectores identificados u otras comorbilidades asociadas, de manera que la niña o niño con malnutrición reciba la atención integral y multidisciplinaria que necesite para su tratamiento desde otras instancias competentes.

10. Mantener un acompañamiento técnico a través de estrategias de sensibilización y educación continua, dirigidas al personal del establecimiento, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y competencias técnicas para ofrecer una atención de calidad a las niñas y niños con malnutrición y sus familias. En este proceso el personal de establecimiento debe prestar toda la colaboración necesaria cuando se requiera ampliar o verificar la información suministrada de las niñas y niños detectados con malnutrición, participando de manera activa en la implementación de estrategias y recomendaciones, cuando así sea solicitado por el E.I.

En revisión

Disposición 6: Sesión interdisciplinaria

Con el fin de garantizar la atención integral, oportuna y coordinada de las niñas, niños y familias referidas para la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI, se establece la realización de sesiones de atención interdisciplinaria con una frecuencia de al menos dos veces al mes, según la calendarización previamente establecida por el E.I. Estas sesiones constituyen un espacio formal para el análisis y discusión de las situaciones referidas para la priorización según su nivel de riesgo y urgencia, y la toma de decisiones conjuntas que orienten las acciones de abordaje desde el Enfoque de Salud Pública.

Para la realización de la sesión interdisciplinaria, considere las siguientes recomendaciones:

1. **Apertura de la sesión**: se inicia la sesión el día, hora y lugar establecido. La sesión de atención interdisciplinaria requiere la participación de la totalidad de los miembros del equipo, garantizando así el análisis integral de las situaciones referidas y la toma de decisiones conjuntas. Eventualmente, cuando por motivos de convocatorias institucionales, capacitaciones u otras indicaciones formales de la jefatura no sea posible contar con la presencia de todos los integrantes, la sesión deberá ser reprogramada en la fecha más próxima posible para asegurar la participación plena contando con la mayor cantidad posible de integrantes, dejando constancia en la minuta se la siguiente sesión, de la reprogramación realizada. En casos en los que una vez reprogramada la sesión no sea posible contar con la participación de todo el equipo, se realizará la sesión con una presencia mínima de dos miembros del equipo interdisciplinario, dejando constancia de las ausencias en la minuta y retomando los acuerdos en la siguiente sesión.

   De manera excepcional, en el caso de que únicamente un miembro del equipo pueda estar presente, no se considerará como sesión interdisciplinaria formal. Sin embargo, dicho profesional deberá realizar las acciones individuales que le competen dentro del proceso de atención interdisciplinaria, tales como: revisión completa de la documentación y boletas de referencia, elaboración de materiales de apoyo, emisión de oficios de respuesta a los establecimientos remitentes, coordinación de insumos necesarios para la próxima sesión u otros propios de la atención interdisciplinaria. Estas acciones deberán registrarse y quedar disponibles para su revisión en la siguiente sesión interdisciplinaria formal.

2. **Contextualización y propósito de la sesión**: se procede con la lectura de oficios remitidos por los establecimientos, referencias o consultas para organizar las tareas y agenda propia de esa sesión, así como la persona que tomará la minuta del día. Se realiza lectura y seguimiento de acuerdos consignados en la minuta de la sesión anterior.

3. **Análisis y valoración interdisciplinaria**: En este espacio se lleva a cabo la revisión integral de las situaciones referidas al equipo, mediante el estudio completo de la información contenida en las boletas de referencia y demás documentos de respaldo. Se realiza el desglose de los aspectos más relevantes de cada caso, la identificación de factores protectores y de riesgo.

   Con esta base se toman decisiones de manera conjunta y colaborativa de acuerdo con el criterio de las diferentes disciplinas, que permitan definir la priorización y las estrategias de atención, su periodicidad y frecuencia, así como las necesidades específicas que orientarán el plan de atención interdisciplinaria de la situación referida y seguimiento conjunto, completando la Boleta de valoración situacional en la que se consigan el criterio del E.I. sobre la situación referida y las acciones a realizar.
   La dinámica de trabajo en este espacio promueve la participación activa de las diferentes disciplinas, la construcción de acuerdos de acciones por el E.I. o interinstitucionales (referencias y/o denuncias) y la definición del plan de atención interdisciplinaria, que integren estrategias de promoción, prevención y seguimiento, asegurando la trazabilidad mediante el levantamiento de minutas de cada sesión.

4. **Registrar en la herramienta de atención interdisciplinaria** todos los datos de niñas, niños y beneficiarias atendidos, incluyendo información general, motivo de referencia, estrategias de abordaje definidas por el equipo interdisciplinario (E.I.), fechas de seguimiento y cualquier otro dato requerido por la herramienta institucional. Este registro debe realizarse de manera completa y oportuna, garantizando la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este procedimiento para la atención y seguimiento.

5. **Anotar en la minuta de reunión:** En cada sesión de atención interdisciplinaria se deberá consignar en la minuta los datos generales según el formato institucional, definiendo de forma explícita el asunto de la sesión, la agenda prevista y los objetivos específicos que la orientan.

   Asimismo, se deberán registrar de manera ordenada los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y los acuerdos alcanzados por el equipo. A la minuta se incorporarán, como anexos, los oficios remitidos por los establecimientos que contienen las referencias y consultas atendidas, de manera que quede evidencia documental completa como parte del control interno, la

En revisión

firma de las personas participantes y se procede al archivo respectivo. Se aclara que esta minuta debe plantearse como un instrumento sencillo, de fácil elaboración y diligenciamiento, que facilite el trabajo de los equipos y promueva el cumplimiento de los lineamientos institucionales sin generar sobrecarga administrativa.

En revisión

Disposición 7: Criterios para la priorización en A.I.

En la sesión interdisciplinaria, el equipo de profesionales analiza las referencias recibidas para a A.I., valorando los signos de alerta, factores de riesgo, factores protectores, elementos del contexto, y oportunidades de intervención de la situación referida. A partir de este análisis, se definen ***las estrategias de abordaje*** que se implementarán; por lo que las acciones específicas que el E.I. implemente, deben ser coherentes con las necesidades, riesgos y fortalezas identificadas. Para ello el E.I. procede de la siguiente manera:

1. Analiza de manera integral la situación referida para la A.I., considerando la existencia de factores protectores, signos de alerta y factores de riesgo, teniendo como insumo lo descrito en la boleta de referencia y sus anexos si los tuviera. Es importante indicar que esta acción se debe realizar de manera integrada e interactiva entre las personas integrantes del E.I.

2. Valora técnicamente la relación de los factores identificados y su posible afectación en cuanto a la intensidad, frecuencia y persistencia en el crecimiento, desarrollo y salud de niñas, niños y beneficiarias. En caso de ser necesario, se solicita la ampliación de la información consignada en la boleta de referencia, a fin de contar con mayores elementos para su adecuada valoración.

3. Analiza, de manera conjunta entre las disciplinas, las estrategias de atención interdisciplinaria a implementar (Disposición 10), valorando integralmente la situación actual, para compartir criterios y tomar decisiones mientras la situación referida requiera continuar con A.I.

4. Asigna la prioridad de atención, considerando estas **premisas**:

    - A menor edad → mayor nivel de vulnerabilidad. En consecuencia, la prioridad de atención aumenta, con el fin de aprovechar oportunamente las ventanas de desarrollo y potenciar los resultados de la intervención.

    - A mayor intensidad, frecuencia o persistencia de los factores de riesgo y ante una menor presencia de factores protectores que incidan en el bienestar integral de la niña, niño o persona beneficiaria → mayor será el nivel de prioridad asignado.

    - A mayor prioridad → se deberán implementar estrategias de atención más individualizadas, oportunas y con la frecuencia requerida, ajustadas a las necesidades específicas de la niña, niño o persona beneficiaria, garantizando una intervención efectiva.

5. Define y ajusta las estrategias de atención (Disposición 10) con Enfoque de Salud Pública según la prioridad de cada caso, para ser implementadas por parte de las personas profesionales de OL y/o ATE de una o más disciplinas, en la cantidad de sesiones según se requiera en cada caso.

6. Completa la Boleta de Valoración Situacional (Anexo 7a y 7b) y archiva en el Expediente A.I. de la niña, niño o beneficiaria.

Desde un enfoque de Salud Pública, la priorización debe considerar:

- **Todas** las niñas y los niños referidos a Atención Interdisciplinaria han sido identificados con riesgo biopsicosocial que afecta su desarrollo integral por lo que deben recibir recomendaciones u observaciones para la promoción de su crecimiento, desarrollo y salud, así como orientaciones dirigidas a su grupo familiar que fortalezcan las buenas prácticas de crianza, cuido y protección, definidas por el E.I.

- De las niñas y los niños que ingresan a Atención Interdisciplinaria (A.I.) **muchos** necesitan estrategias de abordaje grupales que apoyen la prevención y que sean implementadas por profesionales de los E.I. de manera conjunta y colaborativa con personas funcionarias de los establecimientos CEN-CINAI y grupo familiar, complementando, cuando se requiera, con acciones de referencia a otras instituciones.

- De las niñas y niños que ingresan a A.I., un **número reducido**, presentan mayor intensidad, frecuencia y persistencia de factores de riesgo biopsicosocial y pocos o nulos factores de protección, por lo que requieren de acciones más frecuentes, específicas, intensivas e incluso individualizadas, por parte de profesionales del E.I. para el abordaje de su

En revisión

situación del crecimiento, desarrollo y salud, así como del accionar de otras instituciones especializadas a las que se debe referir.

Para estas situaciones, el E.I. requiere aplicar alguna o una combinación de las estrategias, por uno o más integrantes del E.I. (no necesariamente debe ser ejecutada por todo el equipo de profesionales en pleno, ya que puede saturar al grupo familiar y generar incomodidad y/o rechazo a la atención). Asimismo, estas niñas y niños pueden requerir un abordaje definido por el E.I. con estrategias aplicadas de manera conjunta y colaborativa con personas funcionarias de los establecimientos CEN-CINAI e integrantes de los grupos familiares.

Con esta base, para llevar a cabo la priorización de las situaciones referidas se debe realizar un análisis de aquellos factores protectores, de riesgo y signos de alerta, tomando en consideración los siguientes aspectos:

En revisión

ÁMBITO	FACTORES PROTECTORES	FACTORES DE RIESGO	POSIBLES SIGNOS DE ALERTA
Individual	• Autoestima positiva y habilidades sociales. • Buen manejo emocional y autocontrol. • Habilidades sociales desarrolladas. • Asistencia a centros infantiles o de cuido diario. • Presencia de nivel educativo • Motivación y proyecto de vida. • Participación en actividades deportivas o culturales. • Prácticas saludables y autocuidado. • Adecuado estado nutricional. • Con control de salud regular y vacunación al día. • Áreas del desarrollo acorde a la edad (motoras, lenguaje, cognitivo, socioafectiva). • Controles prenatales y postnatales. • Acceso a información y apoyo sobre lactancia materna. • Ejercicio de derechos sexuales y reproductivos informados. • Apertura y receptibilidad para recibir ayuda. • Entre otros.	• Baja autoestima • Escasas habilidades sociales • Dificultades en el control de impulsos. • Bajo nivel educativo. • Trastornos emocionales, conducta o dificultades de aprendizaje • Rezago o riesgo de retraso en el desarrollo. • Sedentarismo. • Condición de malnutrición. • Exposición a violencia física, psicológica o sexual. • Ausencia de controles de salud y vacunación • Falta de conocimiento sobre lactancia y cuidado infantil. • Embarazo en la adolescencia. • Consumo de alcohol, tabaco o drogas. Depresión postparto o estrés elevado. • Embarazo no planificado o en condiciones de vulnerabilidad. • Ausentismo recurrente a los servicios de cuidado o educativos. • Uso excesivo de dispositivos electrónicos. • Entre otros.	• Miedo excesivo, aislamiento, tristeza frecuente, vergüenza, sentimientos de culpa frecuente, inseguridad • Poca motivación, autosabotaje • Pensamientos extremos, negativos y fatalistas • Resultado rojo o amarillo en el EDIN. • Resultado 1 o 0 en la edad actual o cuando no logra de la edad anterior en alguna de las áreas del desarrollo en el EVADE. • Conductas agresivas, patea, muerde, empuja, insulta. • Dificultad para expresar afectos o desbordamiento emocional: impulsividad, efusividad, irritabilidad, llanto frecuente, conductas temerarias • Comparación con otras personas • Dificultad para la comunicación, lenguaje, interactuar o integrarse • Dificultades en motricidad • Vocabulario limitado, nivel de comprensión y expresión de ideas bajo, dificultad en la lectoescritura • Cansancio frecuente, poca energía, dolores musculares, poco interés en actividades físicas, cambios en los patrones de sueño • Aumento o pérdida de peso, falta de apetito o exceso de apetito • Enfermedades No transmisibles: hipertensión, diabetes, cardiopatías • Enfermedades recurrentes • Malos hábitos alimenticios • Consumo de sustancias y Autolesiones • Entre otros
ÁMBITO	**FACTORES PROTECTORES**	**FACTORES DE RIESGO**	**POSIBLES SIGNOS DE ALERTA**
Hogar-familiar	• Figuras cuidadoras positivas • Crianza respetuosa y compromiso con la crianza. • Vínculos afectivos seguros y apoyo mutuo entre integrantes del hogar. • Respecto de los derechos de la niñez y adolescencia. • Personas cuidadoras anuentes a recibir la orientación de las personas funcionarias. • Redes apoyo familiares (abuelos, abuelas, tíos, tías, otros) • Ausencia de alcoholismo y drogadicción. • Seguridad económica básica, empleo.	• Familias numerosas, con varios miembros PME y adultas mayores, discapacidad. • Crianza rígida y/o permisiva • Ausencia de vínculos afectivos seguros. • Desinterés por la educación y crianza de la niñez. • Comunicación deficiente • Antecedentes o presencia de maltrato infantil, negligencia o abandono. • Personas cuidadoras poco receptivas a recibir la orientación de las personas funcionarias. • Ausencia de redes apoyo familiar. • Antecedente o presencia de alcoholismo y drogadicción.	• Sobrecarga en la persona cuidadora, poca supervisión de la niña o niño, inasistencia frecuente, necesidades básicas insatisfechas • Crianza sobreprotectora y dependiente, abusiva, falta de límites y permisibilidad • Despreocupación, desinterés por la crianza de la niñez, ausencias reiteradas a servicios de salud y educación, desatención u omisión a recomendaciones, desinterés en los cambios de comportamiento de sus hijas e hijos, escasa participación en el proceso de crianza y atención niña y niño. • Conflictos frecuentes y no resueltos, ambiente familiar tenso, rechazo del núcleo familiar, vínculos familiares rotos • Presencia de gritos, vocabulario inapropiado, golpes, jalón de pelo, pellizcos, u otras manifestaciones de violencia • Consumo de drogas, alcohol, fármacos, entre otros

En revisión

	• Acceso a servicios básicos: vivienda, agua potable, electricidad • Con seguro social. • Entre otros.	• Antecedentes o presencia de Violencia intrafamiliar o conflictos o de pareja. • Hogar en pobreza, Inestabilidad económica o desempleo. • Vivienda con hacinamiento familiar. • Sin seguro social. • Hogar con antecedentes o presencia de embarazos en adolescencia. • Entre otros.	• Vivienda en malas condiciones, falta de acceso a agua, luz, internet, productos básicos, alimentos • Falta de controles médicos y atención a enfermedades • Embarazos a temprana edad • Entre otros
ÁMBITO	• **FACTORES PROTECTORES**	• **FACTORES DE RIESGO**	• **POSIBLES SIGNOS DE ALERTA**
Comunitario	• Entorno comunitario con espacios seguros, inclusivos y libres de violencia. • Disponibilidad y acceso al transporte público. • Presencia de servicios de educación, salud y cuidado. • Acceso a fuentes de empleo • Acceso a vivienda • Disponibilidad de agua potable (Acueducto de A y A, rural, municipal) • Existencia de centros recreativos para actividad física población materno-infantil • Baja presencia de factores de riesgo social. (Drogadicción, alcoholismo, embarazos en adolescentes, exclusión educativa, otros) • Disponibilidad de servicios de salud • Presencia de instituciones sociales y seguridad (PANI, Guardia Rural, IMAS, OIJ, Fiscalía, otros) • Redes de apoyo comunal (organizaciones comunales) • Redes comunitarias y/o programas de promoción de la lactancia y crianza positiva. • Entre otros.	• Entorno comunitario con alta inseguridad ciudadana, violencia y discriminación. • Dificultad de acceso transporte público • Pocos o nulos servicios de educación, salud y cuidado cercanos. • Inexistentes fuentes de empleo • Inexistente acceso a vivienda • Limitado o nulo acceso a servicios básicos: agua potable (Acueducto de A y A, rural, municipal), electricidad, vivienda, eliminación adecuada de excretas. • Pocos o nulos centros recreativos para actividad física población materno-infantil • Presencia de factores de riesgo social • Inexistente o poca presencia de instituciones sociales y seguridad • Ausencia de organizaciones comunales. • Comunidad propensa a afectaciones por fenómenos climáticos o naturales • Entre otros.	• Limitación para movilizarse en la comunidad libremente: jugar, pasear, caminar, normalización de conductas agresivas y exposición a hechos violentos • Falta de dinero para solventar el transporte, servicios de transporte limitados • Pocos o nula presencia de escuelas, colegios, centros de cuido, clínicas • Cambios frecuentes de residencia, necesidades básicas insatisfechas, estrés familiar, • Problemas de higiene, enfermedades recurrentes, malnutrición, condiciones inseguras de habitabilidad • Limitadas oportunidades de recreación y desarrollo, ausencia de parques o espacios para la recreación • Drogadicción, alcoholismo, embarazos en adolescentes, negligencia infantil, exclusión educativa, violencia intrafamiliar, pérdida de materiales frecuentes por robos, entre otros • Limitada acceso a instituciones como PANI, Guardia Rural, IMAS, OIJ, centros de salud Fiscalía, otros • Afectaciones en vivienda, pérdidas de bienes, interrupción de servicios básicos por inundaciones, deslizamientos, terremotos, tornados, torbellinos, ciclones.

En revisión

Con base en el análisis de los factores de riesgo, protectores y signos de alerta, el E.I. realiza la priorización de la situación referida para la A.I., en concordancia con lo siguiente:

Nivel de prioridad	Valoración Situacional y Valoración integrada de factores	Frecuencia de atención y Estrategias sugeridas

1 **Alto**	Se refiere a las situaciones de alta vulnerabilidad biopsicosocial, en las que existen uno o más riesgos y signos de alerta individuales, familiares y comunitarios graves o múltiples que interfieren de forma directa o sostenida en el crecimiento, desarrollo y salud, de la niña, niño o beneficiaria, comprometiendo su bienestar integral y requiriendo una atención inmediata y prioritaria. Pocos o nulos factores protectores reales, sólidos, estables en el tiempo y observables, con alta capacidad de compensar los riesgos identificados, y que resultan insuficientes y poco efectivos para mitigar, contener o reducir la situación de riesgo. *Se incluyen las situaciones tipificadas como urgencia, que requieren atención inmediata. Esta prioridad se puede representar en las siguientes situaciones: • **Riesgo alto- protección baja** • **Riesgo alto- protección moderada** • **Riesgo moderado- protección baja**	La atención se caracteriza por ser inmediata, prioritaria, frecuente, con seguimiento constante y continuo en el tiempo. Las estrategias de atención establecidas para este nivel de prioridad deben ser mediante atención individualizada y acompañamiento al grupo familiar, consejería, visita domiciliar, complementando con estrategias grupales. Cuando se requiera, se hace coordinación y referencia a otras instituciones especializadas (MP, CCSS, PANI, IMAS, MEP, INAMU, entre otras)
2 **Moderado**	Se identifican uno o más riesgos y signos de alerta individuales, familiares o comunitarios de intensidad moderada que se combinan o sostienen en el tiempo afectando parcial o intermitente el bienestar de niña, niño o beneficiaria. Existe al menos un factor protector activo, pero frágil o inconstante para compensar la situación de riesgo identificada. Sin atención oportuna, puede agravarse según las condiciones del entorno. Esta prioridad se puede representar en las siguientes situaciones: • **Riesgo alto- protección alta** • **Riesgo moderado- protección moderada** • **Riesgo moderado- protección alta** • **Riesgo bajo- protección baja**	La atención se caracteriza por ser oportuna y frecuente, donde el E.I. determinará la periodicidad de la atención y seguimiento según los riesgos identificados. Las estrategias de atención establecidas para este nivel de prioridad incluyen visita domiciliar, consejería, atención en contexto, estrategias grupales focalizadas o en pequeños grupos, acciones informativas, actividades educativas, acciones para la promoción y prevención general. Cuando se requiera, se hace coordinación y referencia a otras instituciones especializadas (MP, CCSS, PANI, IMAS, MEP, INAMU, entre otras).
3 **Bajo**	Se identifican condiciones individuales, familiares y comunitarias con bajo riesgo o riesgo controlado. Los factores de riesgo identificados son aislados o focalizados presentando menor afectación o interferencia en el bienestar integral de la niña, niño o beneficiaria, ni el funcionamiento inmediato de su entorno familiar y comunitario. El o los factores protectores identificados, son estables, favorecen la contención de los riesgos identificados, pero requieren de seguimiento periódico. Esta prioridad se puede representar en las siguientes situaciones: • **Riesgo bajo- protección moderada** • **Riesgo bajo- protección alta**	La frecuencia de atención en este nivel de prioridad es menor y se realiza seguimiento periódico. Las estrategias de atención establecidas para este nivel de prioridad contemplan estrategias grupales y comunitarias como acciones informativas, actividades educativas, acciones para la promoción del crecimiento y desarrollo, ferias de la salud, campañas informativas, escuelas para familias, grupos de apoyo, conversatorios, conferencias, huertas comunitarias, espacios recreativos, entre otros. De ser necesario se realiza la coordinación o referencia a redes institucionales.

En revisión

En revisión

Disposición 8: Consideraciones para realizar referencias interinstitucionales y/o denuncias

La realización de referencias a otras instituciones y/o denuncias, considerando las necesidades, situaciones, manifestaciones y/o factores de riesgo identificadas que influyan en el proceso de desarrollo integral y calidad de vida individual de clientes y beneficiarias, durante el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de las modalidades de atención, tanto en las estrategias intra como extramuros en CEN-CINAI. Cuando se requiera activar el sistema de referencias y/o denuncias, se debe proceder tal y como se indica a continuación:

Referencia Interinstitucional.

1. Completando de manera correcta la boleta de referencia a otra institución (Ver anexo 3a y 3b) cuando la niña, niño o beneficiaria requiera de atención específica, de acuerdo con las competencias que le son propias a la institución y los servicios específicos que preste. Para las referencias de niñas y niños menores de 13 años que analiza, prioriza y tramita RISA, se emplea la boleta respectiva de RISA, exclusiva para las instituciones participantes. Para las demás referencias, se emplea esta boleta de Referencia Interinstitucional de CEN-CINAI, como lo son: EBAIS-CCSS, MEP, INA, INAMU, IMAS, PANI u otras. En caso de requerir apoyo de algún profesional de OL para la elaboración de la referencia, se solicita por la vía más oportuna.

2. Enviando la referencia interinstitucional en formato físico de manera pronta y oportuna a la institución correspondiente. Para ello se debe coordinar con la persona ASSC3, profesional de establecimiento, profesionales del E.I. la entrega de la referencia a la institución correspondiente; o bien haciendo entrega física de la referencia a la madre, padre o persona encargada para el trámite respectivo directamente en la institución.

   Nota: en el caso que se requiera entregar de manera física la referencia a la madre, padre o persona encargada para el trámite respectivo directamente en la institución, previamente se debe realizar un análisis de la situación, considerando la viabilidad y tomando en cuenta el compromiso y responsabilidad de la persona encargada de la niña o niño para realizar el trámite y la posterior entrega de la boleta con el recibido en el establecimiento.

3. En caso de que la entrega de la referencia a otra institución sea de forma digital (escaneada o imagen del documento, cuando esta vía esté previamente habilitada o estipulada en la institución que recibe la referencia) se remite por correo electrónico y se copia a la persona profesional enlace de OL, quien remite al E.I. para el seguimiento respectivo. Estas referencias recibidas en OL, se deben descargar tanto el correo (formato EML) como el documento adjunto y custodiarse en el archivo digital del E.I. para su uso y seguimiento. A su vez, se debe imprimir la referencia e incorporar la copia en el expediente físico de A.I. resguardándola y estando disponible para uso del E.I. en el espacio de la Oficina Local debidamente identificado para tal fin.

4. Tomando en cuenta que para las redes o comisiones (RISAS, CONAPDIS, OAPVD, Comité de estudio del niño, niña y adolescente agredido, Instancia local de abordaje integral de comportamiento suicida – ILAIS-IRAIS, Red Costarricense de Actividad Física y Salud-RECAFIS, u otras) las personas profesionales de OL que participan en la red, completan la boleta y realizan el trámite de la referencia según lo establecido.

5. En los casos identificados de adolescentes madres se debe proceder tal y como lo indica la “Estrategia Atención Diferenciada de las Adolescentes Madres” vigente.

6. Cuando se requiera la atención y protección a personas víctimas de delitos, se debe proceder como lo indica el “Lineamiento para la gestión de las referencias en articulación con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD)- Ministerio Público y la Dirección Nacional CEN-CINAI”.

7. Asegurando que se cuente con el recibido por parte de la institución a la que se entregó la referencia para ser archivada en el expediente físico de clientes y beneficiarias en el establecimiento. Es importante recordar que se debe sacar copia a esta referencia tramitada con el recibido y remitir al E.I. para que realice el respectivo seguimiento.

   Nota: se aclara que una misma situación detectada, puede requerir de referencia al E.I. y/o referencia interinstitucional a una o más instituciones y/o denuncia. Estas acciones no son excluyentes ya que depende de cada caso. Además, se debe realizar referencia a otra institución cuando se requiera, ya sea, previo, durante o después de la A.I. de niña, niño o beneficiaria.

En revisión

Contrarreferencia

- La contrarreferencia es la respuesta que realiza una institución (que recibió la referencia) sobre la atención brindada a una persona que fue referida. La persona funcionaria que realiza la contrarreferencia interinstitucional, debe llenar la boleta para cada institución que emitió referencia a CEN-CINAI, con el fin de informar si se atendió o no el caso referido y las principales acciones realizadas desde CEN-CINAI, a fin de asegurar el seguimiento y a la atención integral. Cuando la persona referida a CEN-CINAI, fue incluida en los servicios y recibió A.I., el E.I. es quien completa la contrarreferencia.

- El documento original de contrarreferencia se dirige a la institución que hizo la referencia a CEN-CINAI y se deja copia en expediente de A.I. la niña, niño y beneficiaria.

- En caso de que la persona referida por otra institución a CEN-CINAI no se le otorgue ninguno de los servicios institucionales, la persona encargada de establecimiento debe completar la boleta de contrarreferencia e indicar el motivo del porqué no se le otorgaron los servicios institucionales y remitirla a la institución que envió la referencia. Se procede archivar la copia de la contrarreferencia tramitada en el expediente físico de clientes y beneficiarias ubicado en el establecimiento.

- El equipo interdisciplinario en Oficinal Local brinda acompañamiento técnico cuando se requiere y realiza la coordinación de las acciones y seguimiento del caso referido, según corresponda.

- Toda persona funcionaria es responsable de utilizar la información adquirida, de manera confidencial y privada, única y exclusivamente para los fines de cumplimiento de las actividades, tales como realizar denuncia, referencia y contra referencia. Por tanto, no se revelará, comentará ni divulgará a terceros la información confidencial y privada adquirida en el cumplimiento de funciones.

Denuncias

En las situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tales como:

- Afecciones físicas por violencia: hematomas o excoriaciones en el cuerpo, marcas de posibles golpes, ropa interior rota, sucia o manchada de sangre, lesiones en zona genital y/o anal, sangrado alrededor de la boca, vagina y/o ano, infecciones/ picazón/ hinchazón en genitales, dolor al orinar, revelaciones, entre otros, que indiquen que la niña, niño o beneficiaria se encuentra en situaciones de abuso o violencia.
- Violencia en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, negligencia, abandono, mental, tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes.
- Violencia a través de tecnologías de información y comunicaciones.
- Delitos sexuales: violación, relaciones sexuales con personas menores de edad- relaciones impropias, conductas sexuales abusivas y explotación sexual.
- Uso de arma blanca o de fuego dentro del establecimiento.
- Amenaza de muerte.
- Intento de homicidio.
- Trabajo infantil.
- Otras situaciones de violencia.

Cuando se tenga sospecha razonable de alguna situación que atente contra la integridad de personas menores de edad, como:

- Sospecha de violación sexual.
- Sospecha de relación impropia.
- Sospecha de negligencia y abandono.
- Sospecha de violencia en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, a través de tecnologías de información y comunicaciones.
- Sospecha de trabajo infantil.
- Niñas y niños identificados con la necesidad de recibir la atención médica necesaria, incluyendo la vacunación obligatoria y los controles médicos prescritos.
- Otros que atenten contra la integridad de personas menores de edad.

En revisión

Ante las situaciones mencionadas, con una sospecha razonable y habiendo identificado señales de alerta que den indicios de una violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con apoyo de la persona profesional en psicología de OL y en su ausencia la persona designada por la jefatura de OL, se debe realizar la denuncia correspondiente de manera inmediata. No es necesario tener pruebas contundentes.

El padre, madre o persona encargada son los tutores legales de las PME, pero, cuando se identifica situaciones de negligencia, violencia, abuso u otros, se debe realizar la denuncia ante al Patronato Nacional de la Infancia del lugar donde sucedieron los hechos, en tanto las personas funcionarias o empleadas públicas, tienen la obligación de hacerlo según lo indica:

Obligación de denunciar:
El Código Procesal Penal en el ARTICULO 281 indica: Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Código de la Niñez y Adolescencia, indica

Artículo 49- Denuncia de maltrato o abuso. Quienes dirijan y el personal encargado de los centros de salud, públicos o privados, adonde se lleven personas menores de edad para atenderlas, tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato, agresión, acoso o abuso cometido contra ellas. Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se atiendan o se preste algún servicio a estas personas.

También, estarán obligados a denunciar las autoridades, el personal contratado y toda persona mayor de edad que tenga bajo su cuido y responsabilidad a personas menores de edad que participen dentro de asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales o agrupaciones, de índole público o privado, de carácter cultural, religioso, juvenil, educativo, deportivo, recreativo o denominaciones religiosas.

Artículo 134°- Denuncias penales. Comprobada en sede administrativa la existencia de indicios de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad, la denuncia penal deberá plantearse en forma inmediata. La persona o institución que actúe en protección de los menores no podrá ser demandada, aun en caso de que el denunciado no resulte condenado en esta sede. Si la persona denunciada tuviere alguna relación directa de cuido o representación con el menor de edad ofendido, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante la autoridad judicial de familia.

Por lo anterior, cuando corresponda realizar una denuncia para la protección de las niñas, niños y/o personas beneficiarias de los servicios de CEN-CINAI (incluye acompañamiento a la beneficiaria o miembro de la familia para realizar la denuncia cuando lo requiera), se procede como a continuación se indica:

- Solicitando apoyo a la persona profesional de psicología o en su ausencia, a la persona profesional que la jefatura de OL delegue, quien brindará el apoyo mediante la vía que se considere más oportuna y factible en ese momento.
- Procediendo con el correcto llenado de la boleta de denuncia. (anexo 5a y 5b).
- Entregando la boleta de denuncia de manera física, pronta y oportuna, a la institución correspondiente o digital (escaneada o imagen del documento) mediante correo electrónico siempre y cuando esta vía esté previamente habilitada o estipulada en la institución que recibe la denuncia. La entrega de la boleta de denuncia en la institución correspondiente se puede realizar en coordinación con la ASSC3 o persona encargada del establecimiento y con colaboración de la persona profesional en psicología o en su ausencia, quien la jefatura de OL designe.
- Considerando que la denuncia se presenta directamente a la Fiscalía Local del lugar donde ocurrieron los hechos (Ministerio Público) en un horario de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm. Después de las 4:30 pm, en días feriados denuncie en el Organismo de Investigación Judicial o Delegación de Policía de la comunidad, según sea el caso. De manera paralela, cuando son personas menores de edad, se debe remitir de manera inmediata, la copia de la denuncia a la Oficina Local del PANI, como institución responsable de aplicar medidas de protección a las personas menores de edad.
- Remitiendo de manera pronta y oportuna la copia de la boleta de denuncia tramitada (con la firma y fecha de recibido), en un sobre cerrado con el remitente anotado en la parte externa, a la persona profesional de psicología o persona enlace de A.I., quien procederá a custodiar el documento en el expediente de denuncias en la OL. Cuando la denuncia haya sido tramitada por parte de la persona profesional de psicología o persona designada por la jefatura de OL, la copia de la boleta tramitada debe ser archivada y custodiada en el expediente de denuncias en la OL.

En revisión

- Considerando que en el caso de denuncias NO se deja copia en el expediente físico de clientes y beneficiarias disponible en el establecimiento, dada la confidencialidad de la situación.
- Considerando que para casos identificados de adolescentes madres, se debe proceder tal y como lo indica la "Estrategia Atención Diferenciada de las Adolescentes Madres" vigente.
- Procediendo como lo indica el "Lineamiento para la gestión de las referencias en articulación con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD)- Ministerio Público y la Dirección Nacional CEN-CINAI", cuando se requiera apoyar en la atención y protección a personas víctimas de delitos.
- Manteniendo en todo momento un uso responsable y confidencial de la información a la que se acceda como parte de sus funciones.

Nota: Cuando en las acciones de atención interdisciplinaria se identifica la necesidad de realizar denuncia, se debe proceder de acuerdo con lo anteriormente descrito. Es importante aclarar que una misma situación detectada, puede requerir de referencia al E.I., referencia interinstitucional y/o denuncia. Estas acciones no son excluyentes ya que depende de cada caso.

En revisión

Disposición 9: Acciones generales y específicas que realizan profesionales de E.I. en la A.I.

¿Cuáles son las acciones generales que realizan profesionales de OL y ATE en la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI?

- **Información sobre la Atención Interdisciplinaria:** Comunicar a la madre, padre o personas cuidadoras en qué consiste la atención interdisciplinaria que ofrece CEN-CINAI e informar que su hija, hijo va a recibir esa atención. Cuando la atención se realice con beneficiarias, de igual manera se debe comunicar claramente en qué consiste la atención interdisciplinaria. (Ver disposición 02)

- **Análisis de situaciones referidas a A.I.:** Revisar la documentación que integra el expediente físico de clientes y beneficiarias con el fin de contar con una visión general de cada situación referida y orientar las estrategias de atención a desarrollar por el E.I.

- **Identificación de signos de alerta y factores de riesgo:** Indagar con la madre, padre, personas cuidadoras o beneficiarias, sobre los determinantes sociales de la salud a fin de identificar factores de riesgo o signos de alerta, es decir, identificar aspectos en el contexto familiar o prácticas cotidianas que requieren cambios para promover mejores condiciones en el crecimiento, desarrollo y salud de las niñas y niños o de las beneficiarias, con base en la referencia recibida por el E.I. Por ejemplo, realizando las visitas domiciliares, entrevistas a madre, padre, persona encargada de niña o niño y beneficiarias.

- **Fortalecimiento de factores protectores:** Identificar junto con la madre, padre, personas cuidadoras o beneficiarias conductas, situaciones o aspectos positivos que benefician el crecimiento, desarrollo y salud, a fin de mantenerlos o fortalecerlos porque son factores protectores. Por ejemplo, realizando las visitas domiciliares, entrevistas a madre, padre, persona encargada de niña o niño y beneficiarias.

- **Abordaje Interdisciplinario:** Analizar de manera integral y colaborativa entre profesionales de diferentes disciplinas, las situaciones referidas al E.I o identificadas en la indagación realizada, tales como factores físicos, familiares, sociales, comunales u otros, que influyen o condicionan la situación referida, a fin de que en la atención brindada se realice un abordaje integral con enfoque de Salud Pública. Cada profesional profundizará en aspectos de la historia de crecimiento, desarrollo infantil y salud, según lo requiera para abordar lo referido al E.I.

- **Implementación de estrategias de atención interdisciplinaria:** Realizar acciones para la promoción del crecimiento, desarrollo y salud de clientes y beneficiarias, que mejor favorezcan la comprensión del mensaje a transmitir, ya sea mediante modelaje, ejemplificación, demostración, ilustración o actividades educativas, a partir de la situación referida al E.I. Estas pueden ser grupales o individuales según lo definido por el E.I. con base en el análisis de las necesidades de la familia y el apoyo que requiera, fortaleciendo la activa participación de una o más personas del grupo familiar como agente clave en el mejoramiento de la situación referida. (Ver disposición 10)

- **Fomento de la participación de la familia:** Motivar la corresponsabilidad de los cuidados y participación activa de madres, padres, personas cuidadoras en las acciones recomendadas para su implementación en el hogar, con base en la situación referida el E.I.

- **Recomendaciones técnicas:** Dar orientación y acompañamiento a madres, padres, personas cuidadoras, beneficiarias de los servicios, sobre actividades o acciones específicas y prácticas que estimulan el crecimiento y desarrollo infantil y salud, para su implementación en el hogar, según en la situación referida en al E.I.

- **Empoderamiento familiar**: Promover participación activa de la familia en el marco de la corresponsabilidad de los cuidados y el enfoque centrado en la familia de manera que las personas atendidas tomen control de su salud mediante herramientas viables de implementar y recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la autonomía, para mejorar el estado nutricional, el adecuado desarrollo y salud según cada caso referido.

- **Acompañamiento a las personas de establecimiento:** Orientar a las personas funcionarias acerca de las acciones a realizar en los establecimientos CEN-CINAI, para contribuir en la atención integral de la niña, niño o persona beneficiaria, según los aspectos descritos en la referencia enviada al E.I.

- **Registros y controles:** Registrar y mantener actualizada la información en la herramienta de A.I incorporando los resultados de las valoraciones o tamizajes, atenciones y seguimientos realizados por cada integrante del equipo interdisciplinario con el

En revisión

propósito de analizar el progreso de cada niña o niño, facilitar la toma de decisiones conjuntas, determinar la permanencia en la atención interdisciplinaria o cierre del caso, asegurando la trazabilidad y continuidad del seguimiento.

- **Referencias interinstitucionales:** Realizar referencia, contra-referencia, y/o denuncias cuando se identifique la necesidad de atención especializada por parte de las instituciones de la red de servicios disponible en la comunidad, considerando el marco jurídico y normativa institucional vigente.

- **Articulación interinstitucional:** Participar activamente en las sesiones de trabajo, reuniones de las comisiones, redes interinstitucionales u otras actividades según designación de jefatura, para apoyar y facilitar acciones de referencia y atención especializada de casos en otras instituciones. La realización de diagnósticos especializados, exámenes físicos o médicos, aplicación de tratamientos farmacológicos, tratamientos terapéuticos, procesos psicoterapéuticos, entre otros, **no se realizan en CEN-CINAI**, por lo que se requiere la articulación interinstitucional para realizar las referencias de manera pronta y oportuna a la red de servicios disponible en la comunidad y a la atención clínica de la CCSS conforme al Protocolo de Atención Intersectorial del desarrollo de niñas y niños preescolares y escolares- SAIID 2025 y el Código de niñez y adolescencia.

- **Seguimiento de situaciones referidas a A.I.:** Realizar acciones de seguimiento a los casos referidos E.I. y a las referencias y/o denuncias realizadas a otras instituciones.

- **Resultados obtenidos de la A.I.:** Realizar devolución o informar a la persona atendida sobre los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones relacionadas con el motivo de referencia al E.I. cuando se finalice la A.I. y se cierra el caso.

- **Realización de reportes técnicos:** Elaborar los reportes solicitados o requeridos y que se encuentren relacionados con la atención interdisciplinaria y/o seguimiento dado por el E.I.

La atención interdisciplinaria refiere al abordaje mediante estrategias de atención acorde con el recurso profesional disponible en cada Oficina Local y Regional, en concordancia con un enfoque de Salud Pública. Con el propósito de ejemplificar las **acciones mínimas indispensables** que cada equipo debe ejecutar en el marco de este procedimiento, se detallan a continuación las actividades específicas por cada disciplina profesional relacionadas con la A.I.

Profesionales en nutrición

La persona profesional en Nutrición ejecuta acciones para la atención interdisciplinaria dirigida a niñas, niños y beneficiarias que requieren una intervención especializada en materia de crecimiento, desarrollo, nutrición preventiva y hábitos saludables en su alimentación, contribuyendo a una intervención oportuna y eficaz buscando la mejora continua en su condición alimentario-nutricional.
Entre las acciones específicas a realizar por parte de la persona profesional en nutrición podemos mencionar:

1. Revisar la boleta de referencia al E.I. para el conocimiento de la información relacionada con el estado nutricional, factores protectores y de riesgo en malnutrición, necesidades especiales en el crecimiento y los tamizajes respectivos acorde con la condición de cada niña o niño. Cuando es atinente, el profesional en nutrición asigna la inclusión de la modalidad DAF una vez verificado el estado nutricional de la boleta de detección en el sistema ANTHRO y verifica que los reportes de notificación obligatoria VE-01 se hayan realizado ante la autoridad sanitaria.
2. Acompañar y orientar a las personas que laboran en los establecimientos (Profesional encargada de establecimiento, ASSC3, ASSC2, AII, TAC, CLA) para la ejecución de las actividades específicas y recomendaciones nutricionales, como parte del abordaje de las situaciones referidas al E.I. entre ellas: promoción de estilos de vida saludables y actividad física que favorezcan el estado nutricional, adaptaciones en el menú (alergias, intolerancias, enfermedades u otras condiciones), presentación e introducción gradual de los alimentos, ajuste en los tiempos de comida o cualquier otra acción que se considere necesaria para contribuir a mejorar el ENU o la situación alimentaria-nutricional.
3. Acompañar y orientar al personal de los establecimientos en la elaboración de estrategias para ser integradas en el plan de actividades de atención diaria, con el propósito de fortalecer el material educativo y transversalizar los aspectos relacionados con nutrición en los distintos ambientes del establecimiento. Estas estrategias pueden incluir el uso de alimentos reales, la presentación diferenciada de los alimentos y otras actividades pedagógicas que promuevan hábitos saludables y mejoren la experiencia alimentaria de las niñas, niños y beneficiarias referidos al E.I.
4. Realizar entrevista a la madre, padre, persona encargada o beneficiaria, con el fin de identificar hábitos, disponibilidad y accesibilidad de alimentos, preferencias, costumbres y posibles barreras, contribuyendo así la implementación de acciones realistas y sostenibles en el hogar que promuevan la mejora de la situación alimentaria-nutricional de la niña, niño o beneficiaria.

En revisión

5. Brindar recomendaciones a la madre, padre o persona encargada en el tema alimentario-nutricional, acorde con las necesidades de las niñas, niños y beneficiarias referidos a la A.I., considerando el contexto sociocultural, los recursos disponibles en el hogar, accesibilidad, costumbres y preferencias alimentarias y las recomendaciones técnicas.
6. Orientar a la madre, padre, persona encargada de la niña o niño o beneficiaria, en el uso adecuado y las condiciones de almacenamiento de los alimentos entregados para consumo en el hogar, así como el acceso a agua potable y las condiciones de higiene relacionadas con su preparación y consumo, acorde con la situación referida al E.I., para optimizar el aprovechamiento de los alimentos, prevenir riesgos sanitarios y promover prácticas seguras e higiénicas, en coordinación con el E.I.
7. Brindar recomendaciones prácticas (recursos, materiales o acciones) modelar su uso adecuado y /o disposición en los ambientes de aprendizaje, para favorecer la promoción de hábitos alimentarios saludables en las diferentes actividades que se desarrollan en las modalidades de atención y fortalezcan el aprendizaje de las familias.
8. Realizar el seguimiento de niñas y niños con malnutrición, considerando la evolución del estado nutricional, según los patrones de crecimiento apropiados según la edad y situación referida. Con base en los resultados, ajustar las recomendaciones y estrategias de orientación alimentaria-nutricional, en coordinación con el resto del equipo interdisciplinario, para garantizar un abordaje oportuno y eficaz buscando la mejora continua en su condición nutricional.
9. Realizar acciones para la promoción de la lactancia materna y alimentación saludable en los primeros mil días, mediante estrategias educativas, orientación y acompañamiento a las familias con el fin de favorecer el vínculo afectivo y contribuir al crecimiento y desarrollo integral de las niñas y los niños.
10. Otras acciones que se requieran según priorización, pertinencia técnica, criterio profesional, normativa y legislación vigente.

Profesionales en Psicología

La atención psicológica que se ofrece en CEN-CINAI por parte de profesionales en psicología de los E.I, consiste en orientación y/o acompañamiento psicológico a madres, padres, personas encargadas o beneficiarias en situaciones específicas relacionadas con el crecimiento, desarrollo y salud o puntuales de la tarea de crianza y socialización de sus hijas e hijos, afrontamiento de crisis; apoyando resolver problemas focalizados, dificultades inmediatas o de la cotidianidad. Este abordaje se caracteriza por ser breve y definido en el tiempo e incluso en ocasiones una única atención, optimizando recursos y garantizando una respuesta oportuna por parte de la persona profesional en psicología, y a su vez, cuando sea necesario, activar el sistema de referencia a otras instituciones.

Entre las acciones específicas a realizar por parte del profesional en psicología están:

1. Realizar entrevista a madre, padre o personas del grupo familiar con el propósito de conocer en detalle las necesidades específicas y el contexto de la situación referida u otras que surjan en la conversación con la persona usuaria, a fin de ofrecer apoyo y orientación a corto plazo.
2. Mantener escucha activa que favorezca la identificación de pensamientos, emociones y conductas ante conflictos o situaciones adversas con base en la situación referida al E.I., para favorecer la comprensión, gestión emocional, bienestar y equilibrio de la persona, mediante recomendaciones específicas.
3. Aplicar cuestionarios, listas de cotejo o pruebas según lo normado en la institución, así como otras que forman parte del abordaje intersectorial, avalado por la institución, que permitan comprender y dar recomendaciones sobre la situación referida al E.I.
4. Mantener confidencialidad y secreto profesional de la información que recibe directamente de las personas usuarias, así como la que haya podido observar, interpretar o deducir de la atención brindada, por lo que es responsable de resguardar y custodiar la información (en formato físico o digital) que se derive de la atención que brinda, salvo las excepciones que establece el Código de ética vigente.
5. Orientar y dar recomendaciones o información clara que sea de utilidad para reducir los factores de riesgo y promover factores de protección, fortaleciendo conductas y prácticas diarias que promuevan las habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales, que mejoren la salud mental y el autocuidado, el desarrollo de nuevas competencias o formas de afrontamiento de futuras situaciones adversas y potencien el crecimiento, desarrollo infantil y salud.
6. Acompañar y dar apoyo emocional o herramientas prácticas que permitan guiar hacia la responsabilidad parental, crianza respetuosa, apego seguro, autonomía progresiva, habilidades sociales, gestión emocional, afrontamiento de conflictos, cambios, situaciones difíciles, estresantes u otras según lo consignado en la referencia, que apoyen a mejorar la calidad de vida, acorde con los recursos o fortalezas de la familia.
7. Acompañar y orientar a las personas funcionarias en el establecimiento en las acciones a realizar para apoyar el fortalecimiento de la autonomía progresiva, situaciones de crisis o conflicto, relaciones interpersonales, habilidades sociales, manejo de las emociones de niñas y niños u otras que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños.

En revisión

8. Realizar primeros auxilios psicológicos, contención emocional en situaciones de crisis o de atención inmediata que apoyen en brindar tranquilidad, calma, seguridad y habilidades de afrontamiento para sentirse mejor y más capaz.
9. Realizar actividades educativas con grupos específicos de niñas, niños, beneficiarias o grupo familiar para instruir, orientar y guiar sobre acciones afirmativas, de promoción de la salud que fortalezcan prácticas saludables relacionadas con el crecimiento, desarrollo y salud.
10. Realizar referencia a servicios de atención de la red local u otros especializados siguiendo los lineamientos institucionales.
11. Realizar atención o llamadas de seguimiento de las situaciones referidas al E.I. y de referencias y/o denuncias a otras instituciones.
12. Otras acciones que se requieran según priorización, pertinencia técnica, criterio profesional, normativa y legislación vigente.

La atención psicológica en CEN-CINAI **no incluye** la realización de psicodiagnósticos, tratamientos psicoterapéuticos o psicología clínica ni la aplicación de tratamientos farmacológicos, que son procesos de especialización en Psicología o Psiquiatría. La intervención clínica requiere de preparación específica en la atención procesos mentales, emocionales, cognitivos, conductuales de las personas, cuyo abordaje involucra mayor duración y estructura, acorde con diferentes modelos o enfoques teóricos (Cognitivo-conductual, Psicoanalítica, Humanista, Sistémica, entre otras), para abordar a profundidad mediante tratamiento psicológico de los trastornos mentales o conflictos psicológicos, siendo un proceso más extenso y clínico que no se realiza en CEN-CINAI.

Profesionales en Terapia de Lenguaje

La atención que se brinda en CEN-CINAI por parte de las personas profesionales en Terapia del Lenguaje, consiste en dar acompañamiento, recomendaciones o apoyo a niñas o niños con dificultades en la comunicación, lenguaje, voz, habla, audición o deglución, así como definir acciones a implementar en los hogares como parte del abordaje, haciendo partícipe a la familia en el aprendizaje, práctica y apoyo de la niña o el niño.
La persona profesional en Terapia del Lenguaje, en conjunto con el E.I. busca abordar de manera integral las situaciones identificadas, ya sea mediante la atención individual o grupal de acuerdo con las necesidades, factores protectores y de riesgo identificados, con el fin de fortalecer las habilidades comunicativas de la niña o el niño, o bien coordinar la atención mediante la referenciación a otra institución.
Entre las acciones a realizar por parte de la persona profesional en Terapia del Lenguaje podemos mencionar:

1. Identificar las posibles alteraciones del lenguaje y/o comunicación en niñas o niños de 2 a menos de 7 años que reciben las diferentes modalidades de atención intra y extramuros que se brindan en CEN-CINAI.
2. Realizar entrevistas a padres, madres o personas encargadas, con el fin de recopilar información sobre las necesidades específicas de la niña o el niño, así como del contexto familiar u otros aspectos relevantes, que permitan ampliar la información asociadas al desarrollo del lenguaje.
3. Aplicar cuestionarios, listas de cotejo, test o pruebas según lo normado en la institución, que permitan comprender y dar recomendaciones sobre la situación referida al E.I.
4. Elaborar planes y estrategias para la atención de las necesidades en el lenguaje y/o comunicación de cada niña o niño para su implementación en la atención individualizada, grupal o en el contexto familiar con la participación activa de la madre, padre y/o persona encargada.
5. Acompañar y orientar al personal de establecimiento en la elaboración de estrategias para ser integradas en el plan de actividades de atención integral diaria, con el propósito de fortalecer el material educativo y transversalizar los aspectos relacionados con estimulación del lenguaje oral y la comunicación en los distintos ambientes del establecimiento. Estas estrategias pueden incluir el modelaje y el aprovechamiento de los materiales disponibles en las diferentes áreas y otras actividades pedagógicas que estimulen el lenguaje.
6. Acompañar y orientar a personas funcionarias en los establecimientos (Profesional encargada de establecimiento, ASSC3, ASSC2, AII) en la ejecución de las actividades específicas de implementación efectiva de las estrategias y recomendaciones para la estimulación del lenguaje y/o comunicación, de las situaciones referidas al E.I.
7. Participar y facilitar actividades educativas, tales como talleres dirigidos a personas funcionarias o de contratación, en temas relacionados con el desarrollo y la estimulación del lenguaje en niñas y niños atendidos en los CEN-CINAI, de acuerdo con necesidades identificadas y lineamientos institucionales.
8. Dar recomendaciones a las familias orientando y proporcionando estrategias, juegos, rutinas u otros de carácter lúdico con el propósito de fortalecer y estimular el lenguaje oral y la comunicación en las niñas y niños cuando se requiera.
9. Participar en la elaboración y ejecución de actividades educativas y de orientación, dirigidas a niñas, niños, padres, madres o personas encargadas, mediante la transmisión de conocimientos, técnicas y estrategias que favorezcan el desarrollo y la estimulación del lenguaje, tanto en la modalidad intramuros como extramuros.

En revisión

Profesionales en Educación Preescolar

En su rol como parte del equipo itinerante, profesionales en Educación desarrollan acciones orientadas a la valoración y fortalecimiento de las habilidades y/o destrezas en el proceso de aprendizaje de niñas y niños, mediante experiencias lúdicas y pedagógicas que afiancen las bases para adquirir nuevos conocimientos a lo largo de la vida. Entre las acciones específicas a realizar por parte del profesional en educación están:

1. Observar de manera directa los diferentes espacios del establecimiento para identificar aspectos relacionados con el comportamiento y la interacción de la niña o niño con los materiales educativos y ambientes, con sus pares, y con las encargadas de la atención integral de infantes u otras personas adultas, identificando fortalezas y elementos claves para el abordaje de la situación referida.
2. Dar seguimiento al plan de actividades diarias, los materiales y los ambientes educativos, con el fin de que sean pertinentes, contextualizados, adecuados e integrados a las necesidades específicas de la situación referida.
3. Dialogar con las encargadas de atención integral de infantes, apoyando en la comprensión y la observación del contexto del aula, guiando en las estrategias de mediación pedagógicas empleadas que favorezcan la atención de la situación referida.
4. Acompañar y orientar al personal del establecimiento, tanto verbal como escrita, para optimizar las estrategias de abordaje en los distintos ambientes educativos en los que se desenvuelve la niña o niño referido al E.I.
5. Reorganizar de manera conjunta con el personal del establecimiento, espacios, ambientes y la disposición de los materiales, asegurando que mantengan su intencionalidad pedagógica y favorezcan el enriquecimiento de las experiencias educativas de las niñas y niños referidos a A.I.
6. Entrevistar a la madre, padre, persona encargada legal de niñas y niños referidos al E.I. con el propósito de conocer en detalle las necesidades específicas y el contexto del hogar, identificando factores protectores y/o de riesgo en el aprendizaje, que contribuyan a la comprensión integral de la situación referida.
7. Brindar recomendaciones y sugerencias prácticas a las familias que enriquezcan el proceso de aprendizaje en casa, fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños referidos a A.I.
8. Desarrollar actividades o talleres educativos (grupales e individuales) con el fin de contribuir a superar las dificultades y potenciar las capacidades del proceso de enseñanza y aprendizaje de niñas y niños que han sido referidos a A.I.
9. Aplicar cuestionarios, listas de cotejo, test o pruebas según lo normado en la institución, así como otras que forman parte del abordaje intersectorial, que permitan comprender y dar recomendaciones sobre la situación referida al E.I., tanto en la modalidad intramuros como extramuros.
10. Otras acciones que se requieran según priorización, pertinencia técnica, criterio profesional, normativa y legislación vigente.

Profesionales en Terapia Física

Es un profesional en el área del desarrollo humano que como parte del E.I. desarrolla acciones orientadas a identificar y fortalecer las habilidades y/o destrezas de las niñas, niños y beneficiarias, mediante acciones que promuevan el desarrollo de la funcionalidad y movimiento, estilos de vida activos y saludables, autonomía, destrezas motoras, identificando signos de alerta relacionados con rezago en el desarrollo motor, así como limitaciones funcionales o disfunciones del movimiento.
La persona profesional en Terapia física apoya y orienta en el abordaje individual o grupal de acuerdo con las necesidades y factores de riesgo identificados, con el fin de fortalecer las habilidades motoras de la niña o el niño, o bien coordinar la atención mediante la referenciación a otra institución.
Entre las actividades que realiza la persona profesional en Terapia Física están:

1. Revisar la boleta de referencia al E.I. para el conocimiento de la información relacionada con condiciones físicas y/o alteraciones motoras de niñas y niños de las diferentes modalidades de atención de las estrategias intra como extramuros.
2. Realizar entrevista a madres, padres o personas encargadas, para recopilar datos necesarios de la dinámica y el contexto familiar, factores de riesgo y/o factores protectores relacionados con la condición física que contribuyan a la comprensión de la situación referida.
3. Apoyar y orientar al personal del establecimiento, tanto verbal como escrita, en las actividades cotidianas para la estimulación del desarrollo motor de las niñas y niños, entre ellas lo relacionado con hábitos de actividad física, salud postural, funcionalidad, movimiento, coordinación, estiramientos, ejercicios de relajación muscular, fuerza, flexibilidad, entre otras, de las situaciones referidas al E.I.
4. Brindar recomendaciones prácticas recursos, materiales o acciones, modelar su uso adecuado y/o disposición en los ambientes de aprendizaje, para favorecer el desarrollo físico y motor en las diferentes actividades que se desarrollan en el establecimiento.
5. Sensibilizar al personal en establecimientos, sobre aspectos relacionados con la inclusión, adaptación, educación que favorezcan la participación y atención integral de las niñas o niños que presenten alguna situación de discapacidad.
6. Apoyar al personal de establecimientos en la ejecución de las diferentes actividades y planes relacionados con el desarrollo motor, rutinas de actividad física u otras.

En revisión

7. Participar en la elaboración y ejecución de actividades educativas y de orientación, dirigidas a niñas, niños, madres, padres o personas encargadas, mediante la transmisión de conocimientos, técnicas y estrategias que favorezcan el desarrollo motor, tanto en la modalidad intramuros como extramuros.

Nota: Considerando la diversidad de puestos y clases existentes en las Oficinas Locales y Áreas Técnicas Regionales, lo descrito en esta disposición son las **acciones mínimas indispensables** que cada equipo debe ejecutar en el marco de este procedimiento. Corresponde a las jefaturas revisar la conformación de sus equipos, con base a los puestos y clases de los profesionales disponibles, asignar las responsabilidades según corresponda.

En revisión

Disposición 10. Estrategias para la atención interdisciplinaria

Las estrategias que se emplean en la atención interdisciplinaria están conceptualizadas para ser implementadas desde un Enfoque de Salud Pública desde el cual se contemplan acciones para optimizar el crecimiento, desarrollo y salud de las niñas, niños, beneficiarias, es decir, para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, desde los que se informa, entrega material de apoyo, motiva y ayuda a la población para identificar sus conocimientos y habilidades en torno a su salud, así como ajustar o incorporar nuevos comportamientos y estilos de vida que mantengan y mejoren su salud.

Con esta premisa, las estrategias de abordaje son una oportunidad para la educación en salud, que orientan a las personas usuarias para la adquisición de conocimientos, prácticas, herramientas que promuevan un estilo de vida saludable, favoreciendo el desarrollo de las capacidades y potencialidades en la niñez, del grupo familiar y de las comunidades a las que pertenecen. De esta manera, se contribuye a lograr que niñas, niños, beneficiarias y familias crezcan, se desarrollen e interactúen en ambientes saludables, felices, libres, independientes, creativos, seguros y con buena nutrición.

Considerando el Enfoque de Derechos Humanos, Enfoque Centrado en la Familia, Enfoque de Salud pública, Enfoque Étnico Racial y Enfoque de Corresponsabilidad en el hogar, que guían este procedimiento, el E.I. define la mejor estrategia de atención o intervención que se implementará con la niña, niño y/o beneficiaria, con base en la valoración situacional realizada, por lo que pueden aplicar alguna o una combinación de las estrategias, o bien, cada estrategia puede ser implementada por una persona de cualquier disciplina, aunque existirán casos que requieren abordaje simultáneo de varias disciplinas. Siempre existe la posibilidad de modificar o ajustar las estrategias para la A.I. según se requiera para cada situación.

El E.I. planifica la logística de desplazamiento a establecimientos y/o comunidad para la A.I. considerando los recursos disponibles en cada OL: número de profesionales que integran el equipo, disponibilidad de vehículo institucional, distancia a recorrer, tiempo de traslado, cantidad de niñas y niños a atender y prioridad de la situación referida. Todo ello se organiza tomando en cuenta criterios de eficacia y la eficiencia, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos y la optimizar el uso de los recursos disponibles.

Se debe considerar que según la necesidad de las niñas, niños o beneficiarias referidas a A.I. pueden requerir de la atención de uno o varios profesionales del E.I. Asimismo, para aquellas situaciones que requieran de una atención especializada de otra institución, deben ser referidos a los servicios correspondientes según la normativa vigente institucional, activando la red interinstitucional.

A continuación, se describen las estrategias de atención y las consideraciones de cada una:

Visita domiciliar
Descripción de la estrategia
La visita domiciliar constituye una estrategia de atención primaria en salud que implica el desplazamiento planificado de personas funcionarias hacia el domicilio de la niña, niño, beneficiaria o grupo familiar. Se orienta prioritariamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, que presentan barreras de acceso o tienen necesidades específicas de atención. Su propósito es comprender y analizar el contexto familiar, el entorno físico y los recursos disponibles, a fin de generar información relevante para la priorización de intervenciones y la formulación del plan de abordaje. Esta estrategia posibilita una atención continua, integral y contextualizada, así como acciones de educación, seguimiento y acompañamiento en el entorno habitual de la familia. Además, acilita una mayor comprensión de la realidad y dinámica familiar, siendo una herramienta clave para orientar, informar, educar y establecer alianzas con las familias para su empoderamiento y la promoción de la autonomía en el cuidado de su salud, tanto individual como colectivo, conforme los objetivos establecidos.
Consideraciones para su implementación

Borrador

- Requiere una planificación previa del desplazamiento hacia los hogares, con la definición clara del propósito y objetivos de la visita.
- Es fundamental que las personas funcionarias cuenten con habilidades de entrevista y observación, así como sensibilidad y empatía frente a las necesidades y particularidades de los grupos familiares atendidos.
- Implica una observación integral del contexto físico, social y relacional, con el fin de definir estrategias de abordaje pertinentes y favorecer la participación activa de la familia, promoviendo a su vez el fortalecimiento de sus capacidades.
- Se emplea el formato institucional para el registro de la visita domiciliar realizada, en el cual debe consignarse los principales hallazgos, las acciones ejecutadas, así como las recomendaciones y actividades educativas realizadas en la visita. El instrumento de la visita domiciliar realizada en el marco de la atención a la situación referida a A.I., se archiva en el expediente de A.I. en OL.

Atención en contexto

Descripción de la estrategia

Corresponde a la intervención realizada de manera individual o grupal en un entorno natural y habitual para la niña o el niño. Posibilita la identificación y análisis de las actividades que desarrolla, con o sin el uso de materiales, dentro de sus rutinas diarias y en los espacios donde se desenvuelve habitualmente, como el aula, el comedor, el patio u otros ambientes significativos.

La atención en contexto permite observar de forma sistemática las interacciones de la niña o niño con sus pares, adultos, materiales y entorno físico, así como sus respuestas conductuales ante diversas situaciones. Dichas observaciones amplían los criterios de análisis de los profesionales intervinientes, favoreciendo una comprensión integral de la situación y la formulación de orientaciones o recomendaciones pertinentes.

Consideraciones para su implementación

- Requiere planificar con antelación y defina el objetivo de la atención y las áreas o dimensiones a observar: qué se observará, a quién, cuándo, dónde y cómo.
- Identifique los espacios cotidianos de la niña o el niño (aula, áreas al aire libre, comedor, hogar, comunidad) considerando las rutinas y dinámicas propias del contexto.
- Mantenga una actitud respetuosa, empática y no intrusiva, evitando modificar las actividades naturales del entorno
- Para optimizar la recolección de información, se puede emplear una guía de observación estructurada elaborada por la persona profesional que realiza la atención en contexto, vinculante con la situación referida a A.I., que facilite el registro de indicadores o datos sobre los acontecimientos, comportamientos e interacciones de las niñas y los niños en su ambiente cotidiano. Esta guía se incluye en el expediente de A.I en OL como parte de la atención realizada.
- Asegúrese de registrar de forma objetiva las interacciones con pares, adultos, materiales y entorno, considerando los factores ambientales que influyen en el comportamiento.
- Analice la información recopilada de manera integral e interdisciplinaria.

En revisión

Atención individualizada

Descripción de la estrategia

La atención individualizada comprende las acciones dirigidas directamente con la niña, niño o persona bajo su cuidado, así como con las beneficiarias y su grupo familiar, con el fin de abordar de manera privada y confidencial las situaciones referidas a A.I. Este espacio se caracteriza por ser exploratorio, valorativo y de intervención, es decir, permite realizar entrevista, explorar eventos o circunstancias específicas más detalladamente, recopilar información sobre la situación biopsicosocial.

A través de este proceso se identifican fortalezas, posibles factores desencadenantes y necesidades asociadas, lo cual contribuyen a un análisis más profundo y una mayor comprensión del caso. Esto, a su vez, orienta con mayor precisión la planificación y ejecución de las acciones de abordaje o el plan de acción correspondiente.

Consideraciones para su implementación

- Es necesario planificar adecuadamente las condiciones y la logística de la atención individual, con el objetivo del logro de los objetivos propuestos y para una intervención efectiva. Esto incluye convocar previamente a la persona usuaria, promover su participación activa y recordarle, si corresponde, los documentos o elementos que debe traer a la sesión.
- Desde el inicio es importante aclarar el enfoque y los límites de la atención individual, definiendo claramente qué aspectos serán abordados y cuáles corresponden a otros niveles de atención o a otras instancias institucionales.
- La atención individual se fundamenta en la escucha activa y el respeto por la autonomía de la persona, permitiendo comprender su situación desde una perspectiva integral. A partir de este reconocimiento, se busca identificar apoyos necesarios, fortalecer capacidades y promover una participación activa en el abordaje de su situación.
- Se debe establecer una comunicación clara, abierta y empática, que reconozca y respete la autonomía de la persona respecto a las decisiones y al seguimiento del plan de acción, favoreciendo así su autonomía y adherencia.
- Al ser una estrategia individualizada, resulta especialmente útil para el abordaje de situaciones de mayor riesgo o complejidad, y para aquellas personas que requieren un acompañamiento más personalizado.
- La atención individual permite realizar intervenciones puntuales y efectivas, utilizando técnicas como la demostración, el modelaje, la guía o la ejemplificación para facilitar el cumplimiento del plan de acción y objetivos propuestos.
- Es un espacio propicio para identificar los recursos personales, familiares y del entorno, y a partir de ellos orientar acciones que puedan continuar realizando desde el hogar para mejorar el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de la persona.
- Se pueden utilizar herramientas, técnicas y materiales propios de cada disciplina (escalas, guías de entrevista, materiales educativos, entre otros) como apoyo que permitan ampliar la información, mejorar la comprensión de la situación y orientar la toma de decisiones ante la situación referida.
- Se requiere de habilidades comunicativas específicas, tales como: escucha activa y sin interrupciones, aceptación de lo que la persona piensa y siente, interpretación adecuada de la comunicación no verbal, uso de preguntas abiertas (sin sobrecargar con preguntas), interés genuino por lo que expresa la persona, expresión de empatía, entrega de información clara, pertinente y con lenguaje accesible y reconocimiento de logros y avances.
- Es importante estar atento tanto al lenguaje verbal como no verbal, tanto propio como del consultante, para establecer empatía, detectar elementos sensibles en la conversación y formular hipótesis para el abordaje.
- Las intervenciones deben promover la comprensión y clarificación de la situación abordada, así como el logro de los objetivos definidos para la atención individual, considerando que toda acción debe enmarcarse en el principio de "acción sin daño" y en el enfoque de acciones afirmativas, evitando cualquier intervención que pueda agravar la situación, generar nuevas afectaciones o revictimizar a la persona (Papsivi, 2018).
- Los principales aspectos abordados y acuerdos tomados en la atención individualizada se registran en la Boleta de eventos y situaciones (Anexo 11a y 11b) y se archiva en el expediente de A.I. en OL.

Consejería

Descripción de la estrategia

Es una estrategia de acompañamiento profesional que se realiza de manera individual o grupal, orientada a guiar a las personas en la toma decisiones y en la resolución de problemas concretos y específicos. Este proceso se realiza de manera responsable, informada y consciente, promoviendo el cambio conductual y la acción basada en decisiones reflexivas.

El objetivo fundamental es fomentar la autonomía, la autoafirmación y la capacidad de resolución de problemas. Se enfoca en brindar apoyo, orientación y ayuda a las personas que enfrentan desafíos emocionales, personales, familiares o profesionales. Durante este proceso se proporciona información clara y apoyo oportuno, adaptados a las necesidades de cada persona, con el fin de fortalecer su capacidad para tomar decisiones por sí misma.

Consideraciones para su implementación

- Aunque su nombre puede sugerirlo, la consejería no consiste en dar consejos, recomendaciones o directrices sobre lo que la persona debe hacer. Tampoco implica influir -de manera abierta o sutil en sus creencias o comportamientos mediante la persuasión, advertencias, amenazas, correcciones, disciplina u otros mecanismos como obligar, manipular, corregir o aconsejar.
- La consejería se centra en las necesidades e intereses de cada persona por lo que es fundamental conocerla de manera personal e individualizada. Esto permite generar confianza, afinidad y establecer un vínculo significativo.
- Para que la consejería será efectiva, se requiere un espacio seguro, confiable y confidencial, que promueva la escucha atenta, el respeto y la aceptación. Estas condiciones favorecen la expresión de emociones y sentimientos, y brindan apoyo en el proceso de toma de decisiones.

En revisión

- Se orienta a acompañar a la persona en la identificación y selección de posibles alternativas para resolver sus problemas. No consiste en dar instrucciones, imponer decisiones, regañar, criticar, culpabilizar o interpretar lo que la persona vive o siente.
- Se reconoce que el cambio ocurre con mayor facilidad cuando la persona se involucra activamente en la elección de sus propias soluciones, toma decisiones informadas y define su camino personal.
- Es una estrategia especialmente útil en el trabajo con población adolescente.
- La consejería se desarrolla como un diálogo conjunto, basado en el intercambio de información clara, confiable y veraz, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de manera reflexiva y consciente.
- Para llevarla a cabo se requieren de habilidades específicas que refuercen la confianza y brinden apoyo, tales como: escucha activa, aceptación de lo que la persona piensa y siente, interpretación adecuada de la comunicación no verbal, uso de preguntas abiertas, demostración de interés genuino en lo que expresa la persona, expresión de empatía, provisión de información pertinente con un lenguaje apropiado, reconocimiento de los avances logrados.
- Los principales aspectos abordados y acuerdos tomados en la consejería, se registran en la Boleta de eventos y situaciones y se archiva en el expediente de A.I. en OL.

Atención grupal

Descripción de la estrategia

La estrategia de atención grupal implica planificar procesos participativos con niñas, niños y/o personas adultas con necesidades o situaciones comunes, con el propósito de fortalecer el desarrollo de capacidades, nuevos aprendizajes y la toma de decisiones conscientes y autónomas sobre la salud integral entre las personas integrantes del grupo. Esta atención se realiza con mínimo 3 y máximo 8 participantes y una persona facilitadora del E.I. y cuando sea posible, una persona co-facilitadora. La cantidad de sesiones la determina el E.I. considerando al menos el desarrollo de 3 encuentros grupales al año.

Esta estrategia utiliza técnicas activas y evaluación continua, lo que favorece aprendizajes significativos, corresponsabilidad y cambios sostenibles en las familias, esto desde un Enfoque de la Salud Pública.

Consideraciones para su implementación

- Es un proceso intencional y planificado donde no se improvisa; por lo que requiere previamente de identificar las personas participantes, definir objetivos, las necesidades a abordar, las actividades a desarrollar y la evaluación, la cual puede ser cuantitativa (uso de cuestionarios, listas de cotejo, entre otras) o cualitativa (por observación, y análisis).
- Esta estrategia no es excluyente de otras estrategias, incluso complementa la atención individual desde un abordaje integral, permitiendo trabajar simultáneamente y de manera colaborativa, aspectos de nutrición, psicología, educación preescolar, terapia de lenguaje, entre otros. Cada disciplina aporta desde su perspectiva, pero con objetivos comunes definidos.
- Implica un enfoque participativo, desde el cual se valida la experiencia de las personas participantes y la dinámica del grupo se enriquece con conocimientos y vivencias compartidas, por lo que los contenidos parten de los intereses y necesidades reales del grupo.
- Favorece la eficiencia en el abordaje de las situaciones referidas al E.I., ya que economiza tiempo y recursos, a la vez potencia el aprendizaje por interacción entre pares y es flexible en tanto las técnicas grupales permiten atender la diversidad de necesidades en un mismo espacio, ajustando dinámicamente los contenidos y actividades.
- Permite la implementación de materiales diversos y dinámicas diversas activas y variadas, definidos según las necesidades del grupo.

  Busca favorecer la ayuda mutua, la cohesión de grupo y el trabajo hacia un objetivo común, ya que incentiva que la familia formule con mayor libertad y menor inhibición preguntas sobre el desarrollo de sus hijas e hijos, sus dudas, temores, sentimientos, compartiendo las distintas formas en que han enfrentado las situaciones y se identifiquen con los eventos de otras familias, lo que empodera para la promoción del crecimiento, desarrollo y salud de sus hijas e hijas.
- Para el registro de la atención grupal realizada por profesionales del E.I., se completa la asistencia de las personas participantes en el formulario institucional Registro de Sesiones Educativas, indicando en el encabezado que corresponde a Atención Grupal de A.I., así como la demás información solicitada. Este registro se archiva en un folder destinado para la atención grupal, ubicado en el archivo del E.I en la OL.

Actividades educativas

Descripción de la estrategia

En revisión

Comprenden la realización de talleres, sesiones educativas o encuentros formativos y participativos, en los que se combinan la información, la práctica y el intercambio de experiencias con un grupo de personas.
Estas actividades suelen estar estructuradas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. En estos espacios, la persona funcionaria asume un rol de facilitación y mediación, con el objetivo de brindar información y, al mismo tiempo, favorecer la construcción colectiva de conocimientos, a partir de las experiencias de las personas participantes, promoviendo la reflexión sobre los temas abordados y el fomento de prácticas saludables.
Esta atención puede llevarse a cabo en distintos tamaños de grupo: grupos pequeños (menos de 10 personas), grupos medianos (de 10 a 20 personas) y grupos grandes (de 20 a 30 personas) donde se cuenta con una persona facilitadora del E.I. y cuando sea posible, una persona co-facilitadora.
El número de sesiones se determina según los criterios del E.I. considerando el desarrollo de al menos 5 sesiones grupales al año, con el propósito de promover la exposición a temáticas específicas y cambio en los comportamientos.

Consideraciones para su implementación

- Son parte de un proceso intencional y planificado por lo que requieren preparación cuidadosa. Esto incluye definir los objetivos y contenidos con base en los intereses y necesidades previamente identificadas en las personas participantes, planificar las actividades de mediación y seleccionar los materiales a utilizar. La persona facilitadora debe familiarizarse con estos contenidos para el desarrollo de lo propuesto con claridad, seguridad y confianza.
- Es fundamental realizar una identificación previa de las personas participantes, así como la conformación del grupo, la convocatoria y la divulgación adecuada de la actividad.
- La participación debe ser promovida activa y constantemente, validando experiencias, conocimientos y vivencias de quienes integran el grupo, por ello los contenidos deben construirse a partir de sus necesidades e intereses reales, fomentando un aprendizaje significativo.
- Esta estrategia favorece la eficiencia en el abordaje de las situaciones referidas al E.I., al optimizar el tiempo y recursos mediante la atención grupal, permitiendo abordar diversas necesidades en un mismo espacio.
- Las sesiones deben incluir dinámicas, juegos y actividades con fines educativos que faciliten activa, romper hielo. Se recomienda el empleo de materiales sencillos, prácticos y accesibles que fortalezcan los temas desarrollados.
- Dada la diversidad de personas, preferencias, creencias, conocimientos y prácticas que confluyen en un grupo, es indispensable emplear un lenguaje claro y sencillo evitando el uso de tecnicismos. Además, se debe verificar constantemente la comprensión del contenido o información brindada mediante preguntas abiertas, ejemplos o actividades específicas.
- Es importante incorporar estrategias de evaluación durante el desarrollo de la actividad, tales como observación, preguntas abiertas o ejercicios relacionados con los contenidos desarrollados, para valorar el aprendizaje y/o ajustar la metodología si es necesario.
- Para el registro de las sesiones educativas, estas son planificadas y estructuradas por el E.I y su ejecución cuenta con el apoyo del personal de establecimiento; razón por cual el registro de asistencia se archiva en el folder destinado para las actividades educativas, ubicado en el establecimiento, como parte de las acciones de promoción del crecimiento y desarrollo.

Actividades comunitarias

Descripción de la estrategia

Las actividades comunitarias consisten en la ejecución de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos dirigidas a de grupos familiares, personas responsables de cuido y crianza de las niñas y niños y a la comunidad general. Estas actividades tienen como propósito fortalecer conocimientos, fomentar la colaboración y promover entornos saludables, mediante estrategias tales como ferias de la salud, campañas informativas, escuelas para familias, grupos de apoyo, conversatorios, conferencias, talleres, huertas comunitarias, espacios recreativos entre otros. Asimismo, se orientan a la divulgación y conmemoración de fechas y celebraciones de interés institucional, como Semana de la Nutrición, Semana Mundial de la lactancia Materna, entre otras.

Consideraciones para su implementación

- Es necesario planificar previamente la logística de las actividades, considerando las fechas de celebraciones o eventos de interés institucional y la disponibilidad de recursos humanos y materiales.
- Requiere definir las áreas temáticas, las intervenciones y los objetivos con base en las características del contexto local, los problemas de salud identificados y los estilos de vida de la población objetivo.

En revisión

- Se recomienda realizar un mapeo de líderes y actores comunitarios, así como instancias locales relevantes, con el fin de favorecer la coordinación y la implementación efectiva de las actividades comunales (Se puede utilizar como insumo la información contenida en el DISSEN).
- Se pueden establecer coordinaciones interinstitucionales que permitan la planificación e implementación conjunta de actividades en temáticas específicas, potenciando el logro de los objetivos, así como el impacto y la sostenibilidad de las acciones,
- Se deberá divulgar oportunamente la información sobre las actividades a realizar para promover la participación y el compromiso de la población.
- Se debe garantizar una clara, respetuosa y oportuna durante el desarrollo de las actividades, de manera que las familias participantes se sientan identificadas, valoradas y motivadas a involucrarse en futuras iniciativas comunitarias.
- Para el registro de las actividades comunitarias, estas son planificadas y estructuradas por el E.I y su ejecución cuenta con el apoyo del personal de establecimiento; razón por cual el registro de asistencia se archiva en el folder destinado para actividades educativas, ubicado en el establecimiento, como parte de las acciones de promoción del crecimiento y desarrollo.
- Se recomienda implementar metodologías participativas que fomenten el involucramiento activo y promueva la reflexión, análisis y construcción del conocimiento de manera conjunta con las personas, familias y comunidades. Reconociendo a los participantes como sujetos activos en la generación de saberes.

Sesión de Apoyo

Descripción de la estrategia

En el marco de la atención interdisciplinaria en CEN-CINAI descrita en este procedimiento, es un espacio formal en el que las personas profesionales de Oficina Local o Área Técnica Regional (de una o más disciplinas) brindan recomendaciones, indicaciones y toman acuerdos con las personas que laboran en los establecimientos en busca de coadyuvar y orientar desde sus conocimientos y experiencias, en las actividades específicas a desarrollar con niñas, niños y beneficiarias que fueron referidos a A.I.. Estas acciones se relacionan con la atención en el contexto para implementar ya sea de manera individual o grupal, en las estrategias intra y extramuros, según sea el caso, con el fin de complementar el abordaje integral.

Consideraciones para su implementación

- Requiere de coordinaciones entre el Equipo Interdisciplinario de la Oficina Local y el personal de los establecimientos de CEN-CINAI, para definir un espacio y momento en la que se realizará la sesión de apoyo, preferiblemente en el establecimiento que refiere la situación.
- Se realiza posterior a la valoración situacional o a la implementación de algunas de las estrategias para la A.I. por parte del E.I.
- Participan las personas del establecimiento vinculadas directamente con la situación referida o aquella persona clave identificada para el abordaje que realiza el E.I. (ASSC2, Trabajadora Auxiliar, ASSC3, Profesionales AII y cargos homólogos por contratación).
- Es un espacio de conversación, análisis, consensos, transmisión de conocimientos y apoyo técnico, donde la toma de decisiones y acuerdos se registran en la Boleta de Eventos y Situaciones y se archivan en el Expediente de A.I. en OL.

En virtud de lo anterior a continuación se detallan recomendaciones y consideraciones para desarrollar la A.I.:

Recomendaciones para una atención interdisciplinaria de manera efectiva

Recomendación	Consideraciones
Atender de una manera respetuosa y amable	• Saludar a niñas y niños, a la madre, al padre, a la persona responsable, a la familia o acompañantes de manera respetuosa y amable. • Aplicar los ajustes razonables y apoyos requeridos para lograr la accesibilidad en la atención, esto implica la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso para la plena participación. • Emplear lenguaje claro, respetuoso, expresión corporal para facilitar la comprensión de la información brindada. • Reconocer logros y felicitar a la madre, padre o persona responsable por las prácticas positivas, participación activa y los avances en las acciones que realiza en el hogar con su niña o niño.
Indagar sobre la situación referida, preguntar sobre sus experiencias, sus preocupaciones y prestar atención	• Realizar preguntas abiertas para indagar más información. • Identificar prácticas que realizan y en cuáles necesitan orientación

Recomendación	Consideraciones
	• No asumir que las personas no saben nada y reconocer los conocimientos y prácticas como base para las acciones a realizar.
Comunicar los hallazgos sobre la situación referida y de manera conjunta acordar opciones de afrontamiento, control o manejo de riesgos.	• Enfocarse en las prácticas o temas que se detectaron como prioritarias. • Motivar para que continúen realizando prácticas adecuadas. • Identificar y comunicar las prácticas que son barrera para mejorar la salud. • Utilizar material didáctico y lúdico para comunicar los mensajes claves.
Encaminar hacia la construcción de compromisos para lograr el cumplimiento de las prácticas deseadas orientadas a la solución, control o manejo de situaciones.	• Identificar de manera conjunta con la madre, padre, persona encargada o la familia las prácticas que deben modificarse o mejorarse. • Reconocer que cada práctica mejorada representa un avance hacia la recuperación, control o manejo del riesgo biopsicosocial identificado. • Establecer uno o dos compromisos por cada sesión de atención interdisciplinaria, asegurando que se cumpla. • Evitar imponer los acuerdos, de manera que los compromisos asumidos sean voluntarios y realistas. • En caso de identificar varias prácticas por mejorar, priorizar aquella que tenga el mayor impacto en la recuperación, control o manejo del riesgo biopsicosocial.
Demostrar, modelar cómo realizar la práctica sugerida	• Explicar en detalle cómo se va a llevar a cabo las acciones sugeridas para fortalecer el compromiso y apoyar cuando sea necesario. • Reafirmar la confianza en su capacidad para realizar el compromiso. • En las visitas domiciliarias, realizar una demostración de la práctica recomendada, tomando en cuenta los recursos de la familia.
Cuando se requiera acordar una sesión de seguimiento	• Acordar una fecha de atención interdisciplinaria o de seguimiento. • Cumplir con la fecha acordada para realizar atención interdisciplinaria o de seguimiento. • Dar seguimiento a los compromisos y así promover un ambiente de confianza para el logro de los objetivos.

Fuente: adaptación de USAID, 2015, Téllez et al 2016.

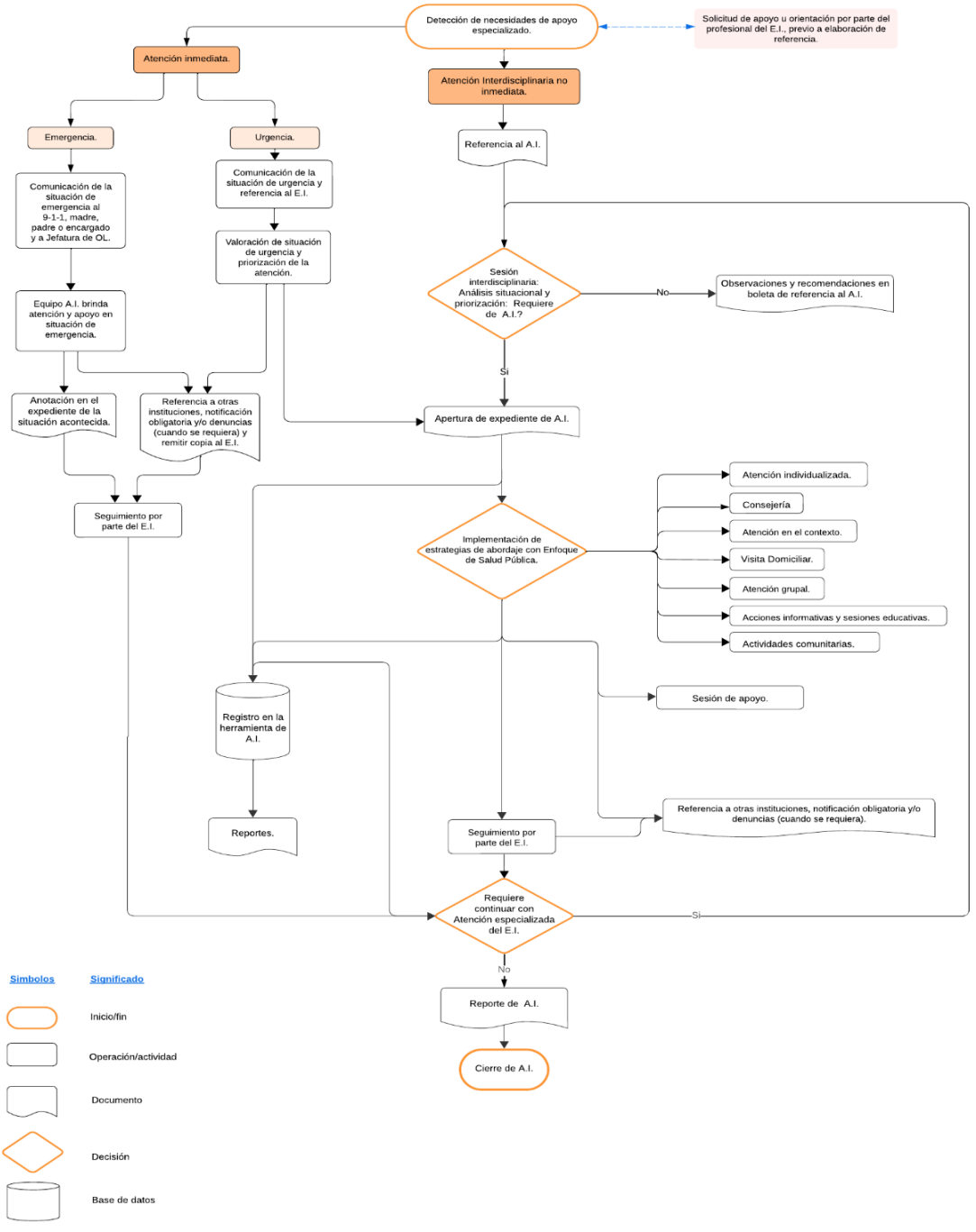
En revisión

IV. ANEXOS

Anexo 1. Flujograma de las acciones en el proceso de atención interdisciplinaria.

Dirección Nacional de CEN-CINAI.

Flujograma de Atención Interdisciplinaria en CEN-CINAI.



Anexo 2a. Boleta de referencia de atención interdisciplinaria.

	Dirección Nacional de CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Código: DNCC-DT-UNAT-F-27	
	BOLETA DE REFERENCIA PARA ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA	Fecha: octubre 2025	Versión: 1

Consecutivo: DNCC-DRXX-(OLXXX)-(código establecimiento)-REF-XXX-20XX			Fecha referencia: _____/_____/_____ Día Mes Año
Establecimiento:		Código del establecimiento:	
Nombre del cliente o beneficiaria:			N° identificación:
Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ Día Mes Año	Edad: _____/_____ Años Meses		Sexo: ( ) Mujer ( ) Hombre
Nombre persona encargada:			N° identificación:
Dirección exacta (provincia, cantón, distrito, otras señas):			Teléfono:
Modalidad atención:	☐ APC diurno ☐ APC nocturno ☐ DHAVI	☐ VAANN ☐ SCS ☐ Leche extramuros	☐ DAF ☐ Hijo-hija Beneficiaria	Fecha ingreso:
Seguridad Social: ☐ No ☐ Sí	Área de Salud adscrito: EBAIS:		☐ Urgencia

Motivo de referencia: anote de manera clara y concreta la razón principal por la cual se realiza la referencia a la A.I. (situación observada, conducta, necesidad o riesgo identificado, fecha o momento en que se identificó la situación).

Acciones realizadas y resultados obtenidos: Anote las acciones realizadas con la niña, niño y/o familiar, previo a la referencia para A.I., así como los resultados, avances o limitaciones identificadas a partir de dichas acciones:

NOTA: Hacer mención y resumir principales resultados cuando existan diagnósticos, epicrisis u referencias de otras instituciones. No adjuntar copias. Cuando se requiera el E.I. consulta el expediente de la niña, niño o beneficiaria.

Ha sido referido (a) por otra institución: ☐ No ☐ Sí Cuál?_____

Se le ha realizado referencia a otras instituciones: ☐ No ☐ Sí Cuál?_____

Situación de discapacidad: ☐ No ☐ Sí Detalle_____

Necesidades específicas para la evaluación del crecimiento y desarrollo ☐ No ☐ Sí Detalle_____

_____

Página 1 de 2

	Dirección Nacional de CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Código: DNCC-DT-UNAT-F-27	
	BOLETA DE REFERENCIA PARA ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA	Fecha: octubre 2025	Versión: 1

Datos contextuales: anote los elementos más relevantes que se relacionan con el motivo de referencia, ya sea observados en la rutina diaria, obtenidos por entrevista o extraídos del expediente.

Individual: Riesgos embarazo Clasificación al nacer-peso al nacer-edad gestacional Vacunación al día Lactancia materna exclusiva y más Estado de salud-Alergias-Enfermedades crónica o congénita-Tratamientos Características del comportamiento individual Características de interacción con otras personas (niños y adultos)
Familiar Cantidad de miembros Descripción de vivienda (espacio habitacional, hacinamiento, acceso a servicios básicos, manejo de desechos y excretas) Características de dinámica familiar (comunicación, vinculación, tipo de crianza, violencia) Redes de apoyo Consumo de alcohol y drogas
Comunidad Descripción de comunidad (espacios recreativos, instituciones presentes, propensa a afectaciones climáticas o naturales) Disponibilidad de transporte público Acceso a servicios de salud

Resultados de últimas evaluaciones del crecimiento, desarrollo y salud (Opción reporte de consolidado-herramienta de vigilancia)

Estado Nutricional					
Menores de 5 a			Mayores de 5 a		Circunferencia abdominal (mayor 6 años)
P/E	P/T	T/E	IMC	T/E	

Necesidades específicas para la evaluación del crecimiento		
Con patrón de crecimiento	Sin patrón de crecimiento	Estado Nutricional

Desarrollo																	
EDIN II						Lista de cotejo de Patrones Hábitos de Salud					EVADE					
MG	MF	LE	CO	SA	GLOBAL	Alimentación	Eliminación	Sueño Descanso	Higiene Vestido	Seguridad	MG	MF	LE	CO	SA	Edad Anterior

Evaluación Cualitativa de API			Tamizajes de Salud				
Dimensiones	Adecuado (+4L)	Riesgo (3L o-)	Agudeza visual		Agudeza auditiva		Salud Oral
Sí mismo			DE	IZ	DE	IZ	
Relación con otras personas y ambiente							
Salud y cuidado personal							

Nombre persona funcionaria que refiere

Firma

VB Profesional establecimiento/ ASSC 3

Página 2 de 2

	Dirección Nacional de CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Código: DNCC-DT-UNAT-F-27
	BOLETA DE REFERENCIA PARA ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA	Fecha: octubre 2025 / Versión: 1

Para uso del Equipo Interdisciplinario

Recibirá atención interdisciplinaria: ☐ Sí ☐ No

Observaciones: espacio donde el E.I emite recomendaciones acerca de la situación referida y la inclusión en A.I

Firma de Equipo Interdisciplinario

Nutrición	Psicología	Docencia	Terapia de Lenguaje	Terapia Física

Página 3 de 2

Anexo 2b. Instructivo Boleta de referencia para A.I.

(Sujeto a revisión de la boleta, anexo 2a)

Anexo 3a. Boleta de referencia interinstitucional

En revisión

	DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo	Código: DNCC-DT-UIVCD-F-02 Fecha: setiembre, 2025
	REFERENCIA INTERINSTITUCIONAL	Versión: 1

DNCC-DR____-OL_____- _____REF-_____-20___ **1. Fecha** _____/_____/_____ (Día/Mes/Año)

2. Institución a la que se envía referencia: ❑CCSS ❑MEP ❑PANI ❑INAMU ❑INA ❑IAFA ❑IMAS ❑ MTSS ❑ OAPVD ❑Otra _____

3. Datos generales de la persona referida:

Nombre y apellidos: _____ No. de identificación: _____

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____/ (Día/Mes/Año) Edad: _____/_____ (años/meses) Sexo: _____

Teléfono: _____Escolaridad: _____Etnia: _____

Persona con Discapacidad: ❑ No ❑ Sí:_____

Dirección exacta del lugar de residencia: Provincia: _____ Cantón: _____

Distrito: _____ Otras señas: _____

_____

Nombre del establecimiento CEN-CINAI en el que se recibe el servicio: _____

Modalidad de atención que recibe:

❑ Atención y Protección Cotidiana ❑ Vínculo Persona Adulta-Adolescente-niña-niño ❑Leche 1,6 k
❑ Desarrollo de Habilidades para la vida ❑Sólo Comidas Servidas ❑Distribución de Alimentos a Familias

Si la persona es menor de edad, indique el nombre y apellidos de la madre, padre o persona responsable:

_____ No. de identificación: _____

Teléfonos: _____ Escolaridad: _____ Etnia: _____

Persona con Discapacidad: ❑ No ❑ Sí:_____

4. Motivo de la referencia: _____

_____

_____

_____

_____

_____

5. Nombre de la persona funcionaria que refiere: _____

N° de identificación: _____Cargo: _____

Teléfono de contacto_____ Correo electrónico: _____

6. Para seguimiento institucional del caso:

Nombre de profesional de Oficina Local: _____N° de identificación: _____

Disciplina: _____Oficina Local: _____

Teléfono de contacto_____ Correo electrónico: _____

7. Este espacio lo completa la institución que recibe la referencia:

Nombre de la persona que recibe la referencia: _____

Fecha: _____ Cargo: _____ sello

"Crecimiento y Desarrollo Integral para las niñas y los niños"
De la esquina suroeste del parque Braulio Carrillo 100 metros al sur, Avenida 4 y 6, Calle 14
2257-5907 / Correo Electrónico: dir.nacional@cen-cinai.go.cr
www.cen-cinai.go.cr

Impresión: Imprenta Nacional

Anexo 3b. Instructivo Boleta de referencia interinstitucional

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA REFERENCIA INTERINSTITUCIONAL

Indicaciones generales:

a) La persona funcionaria que realiza la referencia interinstitucional, debe llenar la boleta para cada institución a la que sea referida la persona que recibe servicios en CEN-CINAI.
b) El equipo interdisciplinario en Oficinal Local, brinda acompañamiento técnico cuando se requiere, realiza coordinación de acciones y seguimiento del caso, según corresponda.
c) Si la situación requiere de atención urgente, se coordina Atención Inmediata con el 911.
d) El documento original se dirige a la institución a la que se refiere y se deja copia en expediente de persona usuaria, así como en Oficina Local para que la persona profesional brinde el seguimiento respectivo.
e) Para las referencias de niñas y niños menores de 13 años que analiza, prioriza y tramita RISA, se emplea la boleta respectiva, exclusiva para las instituciones participantes. Para las demás referencias, se emplea esta boleta.
f) Toda persona funcionaria es responsable de utilizar la información adquirida, de manera confidencial y privada, única y exclusivamente para los fines de cumplimiento de las actividades, tales como realizar denuncia, referencia y contra referencia. Por tanto, no se revelará, comentará ni divulgará a terceros la información confidencial y privada adquirida en el cumplimiento de funciones.

Indicaciones específicas:

0. **Número de consecutivo**: en este espacio se debe anotar la signatura de la unidad que produce el documento. Para ello, anote el número de consecutivo siguiendo el respectivo tipo documental: siglas de la Dirección Regional, Número de la Oficina Local, código del establecimiento, número de referencia y año (Ejemplo: DNCC-DRBR-OL 501-1190108-REF-001-2023). Cada establecimiento, debe llevar un control de los consecutivos de las referencias que se realizan.
1. **Fecha**: Anote la fecha en la cual se elabora la referencia: día, mes y año.
2. **Institución a la que se envía la referencia**: marque la casilla de la institución a la que se envía referencia. En caso que no se encuentre en las opciones, anote en el espacio de otra a cuál institución se refiere.
3. **Datos generales de la persona referida**: anote la información lo más completa posible, de la persona que recibe servicios en CEN-CINAI, según lo requerido en el apartado. Considere anotar:
   - **Nombre** completo y los apellidos.
   - **Número de identificación**.
   - **Fecha de nacimiento, edad, sexo y teléfono**.
   - **Escolaridad**: anote el nivel y año que corresponde al último año o grado aprobado (mayores de 5 años) dentro de la educación formal:

Niveles	
Ninguno	Para universitaria
Preescolar	Bachillerato
Enseñanza especial	Licenciatura
Primaria	Posgrado
Secundaria académica	Incompleta
Secundaria técnica	Desconocida

   - **Etnia**: se debe anotar lo que la persona indique ya que esto corresponde a una autodeterminación: indígena, negra, afrodescendiente o mulata, de origen oriental [asiática], blanca o mestiza u otro.

"Crecimiento y Desarrollo Integral para las niñas y los niños"
De la esquina suroeste del parque Braulio Carrillo 100 metros al sur, Avenida 4 y 6, Calle 14
Tel: 2258-7918 / Correo Electrónico: dir.nacional@cen-cinai.go.cr
www.cen-cinai.go.cr

Página 1 de 2

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA REFERENCIA INTERINSTITUCIONAL

- **Persona con discapacidad**: se debe anotar si o no tiene ninguna discapacidad y especificar el tipo: discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad cognitiva o discapacidad psicosocial. Considere lo siguiente:

Discapacidad	Descripción
Deficiencia auditiva	Las personas presentan pérdida total o parcial permanente de la audición, de uno o ambos oídos. Incluye: hipoacusia (persona que presenta residuos auditivos) y anacusia (sordera total). Excluye: Aquellas deficiencias que puedan ser temporales de la audición o corregidas con audífono.
Deficiencia visual	Consiste en la pérdida total o parcial permanente de la visión y puede ser de uno o ambos ojos. Incluye: Cataratas, glaucomas, retinosis, desprendimiento de retina, entre otras. Excluye aquellas deficiencias que puedan corregirse con lentes de contacto o con anteojos.
Discapacidad Física	Las personas presentan pérdida, carencia o anormalidad en el funcionamiento del sistema músculo esquelético o nervioso, que las limitan permanentemente para las actividades diarias. Incluye: Todo tipo de amputaciones, artrofias musculares, artritis reumatoidea, artrosis, osteomielitis, dificultad para la marcha, pie Bott, genu valgu, quemaduras de 2do., 3er., y 4to. grado, epilepsia, parkinson, miastenia gravis, parálisis cerebral infantil, hemiplejia, paraplejia, diplejía, monoplejia, cuadraplejia o tetraplejía, charcot marie tooth, distrofia muscular progresiva, encefalopatias, poliomelitis, microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia. Excluye: Aquellas que no sean de carácter permanente
Discapacidad cognitiva	Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo, expresadas tanto en las destrezas adaptativas conceptuales, como en las sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años de edad. Incluye: todos los grados de retardo mental (leve, moderado, severo, profundo), síndrome down, podría estar asociado a hidrocefalia o parálisis cerebral, entre otros. Excluye: Problemas de aprendizaje, autismo y déficit atencional
Discapacidad psicosocial	Conjunto de síntomas psicopatológicos identificables, que interfieren en el desarrollo personal, laboral y social de la persona, de manera diferente en intensidad y duración. Incluye: Trastornos mentales orgánicos, autismo, esquizofrenias y trastornos psicóticos, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, adaptativos y somatomorfos, disociativos y de personalidad. Debe tener tratamiento psicológico o medicado. Excluye: las depresiones, estrés u otros estados de ánimo transitorios o los conocidos popularmente como estados nerviosos.

- **Dirección exacta del lugar de** residencia: indicar provincia, cantón, distrito y otras señas.
- **Nombre del establecimiento en el que recibe el servicio**.
- **Modalidad de atención que recibe**: marque la casilla que corresponda.
- **Si la persona es menor de edad**: anote el nombre y apellidos de la madre, padre o persona responsable, el número de identificación, teléfonos, escolaridad, indique si es una persona con discapacidad y etnia. Para estas últimas siga lo indicado anteriormente.

4. **Motivo de la referencia**: puntualice con claridad el motivo por el cual se realiza la referencia acorde con la situación identificada.
5. **Nombre de la persona funcionaria que refiere:** anote los datos solicitados; nombre, número identificación, cargo, teléfono de contacto y correo electrónico institucional.
6. **Para seguimiento institucional del caso**: anote los datos solicitados de la persona profesional en la Oficina Local que brindará seguimiento del caso.
7. **El recuadro debe ser completado por la persona funcionaria de la Institución que recibe la referencia**, con nombre, fecha, cargo, número de denuncia y sello institucional.

DT-Versión - actualizada mayo 2024

Anexo 4a. Boleta de Contra- Referencia interinstitucional

CEN-CINAI	DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo	Código: DNCC-DT-UIVCD-F-03 Fecha: setiembre 2025
	CONTRA-REFERENCIA INTERINSTITUCIONAL	Versión: 01

DNCC-DR____-OL_____- _____CONT_REF-_____-20___ **1. Fecha** _____/_____/_____ (Día / Mes / Año)

2. Institución a la que se dirige la contra- referencia: ❑CCSS ❑MEP ❑PANI ❑INAMU ❑INA ❑IAFA ❑IMAS ❑ MTSS ❑ OAPVD ❑Otra _____

3. Datos generales de la persona que fue referida a CEN-CINAI:

Nombre y apellidos: _____ No. de identificación: _____

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____/ (Día / Mes / año) Edad: _____/_____ (años / meses) Sexo: _____

Teléfono: _____Persona con Discapacidad: ❑ No ❑ Sí: _____Etnia: _____

Dirección exacta del lugar de residencia: Provincia: _____ Cantón: _____

Distrito: _____ Otras señas: _____

_____

Si la persona es menor de edad, indique el nombre y apellidos de la madre, padre o persona responsable: _____ No. de identificación: _____

Teléfono: _____Persona con Discapacidad: ❑ No ❑ Sí: _____Etnia: _____

4. Acciones realizadas en CEN-CINAI y recomendaciones:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5. Nombre de la persona funcionaria que realiza la contra-referencia: _____

N° de identificación: _____Cargo: _____ Teléfono de contacto_____

Correo electrónico: _____ Sello institucional

6. Este espacio lo completa la institución que recibe la contra- referencia:

Nombre de la persona que recibe la contra-referencia: _____

Fecha: _____ Cargo: _____ Sello institucional

DT-Versión actualizada setiembre 2025

"Crecimiento y Desarrollo Integral para las niñas y los niños"
De la esquina suroeste del parque Braulio Carrillo 100 metros al sur, avenida 4 y 6, calle 14
Tel: 2257-5907 / Correo electrónico: dir.nacional@cen-cinai.go.cr
www.cen-cinai.go.cr

Impresión: Imprenta Nacional

Anexo 4b. Instructivo Boleta de Contra- Referencia interinstitucional

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA CONTRA-REFERENCIA INTERINSTITUCIONAL

Indicaciones generales:

a) La contra-referencia se realiza y envía a la institución que refirió personas a los servicios de CEN-CINAI. La persona funcionaria que realiza la contra-referencia interinstitucional, debe llenar la boleta para cada institución que emitió referencia a CEN-CINAI, con el fin de informar si se atendió o no el caso referido y las acciones realizadas. En caso de que no se incluyera la persona referida a los servicios institucionales, debe indicarse en la contra-referencia.

b) El equipo interdisciplinario en Oficinal Local, brinda acompañamiento técnico cuando se requiere, realiza coordinación de acciones y seguimiento del caso, según corresponda.

c) El documento original se dirige a la institución a la que se contra-refiere y se deja copia en expediente de persona usuaria, así como en Oficina Local para que la persona profesional brinde el seguimiento respectivo.

d) Toda persona funcionaria es responsable de utilizar la información adquirida, de manera confidencial y privada, única y exclusivamente para los fines de cumplimiento de las actividades, tales como realizar denuncia, referencia y contra referencia. Por tanto, no se revelará, comentará ni divulgará a terceros la información confidencial y privada adquirida en el cumplimiento de funciones.

Indicaciones específicas:

0. **Número de consecutivo**: en este espacio se debe anotar la signatura de la unidad que produce el documento. Para ello, anote el número de consecutivo siguiendo el respectivo tipo documental: siglas de la Dirección Regional, Número de la Oficina Local, código del establecimiento, número de contra-referencia y año (Ejemplo: DNCC-DRBR-OL 501-1190108-CONT_REF-001-2023). Cada establecimiento, debe llevar un control de los consecutivos de las contra-referencias que se realizan.
1. **Fecha**: Anote la fecha en la cual se elabora la contra-referencia: día, mes y año.
2. **Institución a la que se envía la contra- referencia**: marque la casilla de la institución a la que se envía la contra-referencia. En caso que no se encuentre en las opciones, anote en el espacio de otra a cuál institución se refiere.
3. **Datos generales de la persona que fue referida a CEN-CINAI**: anote la información lo más completa posible, de la persona que fue referida a los servicios en CEN-CINAI, según lo requerido en el apartado.
   - **Nombre** completo y los apellidos.
   - **Número de identificación**.
   - **Fecha de nacimiento, edad, sexo y teléfono.**
   - **Escolaridad**: anote el nivel y año que corresponde al último año o grado aprobado (mayores de 5 años) dentro de la educación formal:

Niveles	
Ninguno	Para universitaria
Preescolar	Bachillerato
Enseñanza especial	Licenciatura
Primaria	Posgrado
Secundaria académica	Incompleta
Secundaria técnica	Desconocida

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA CONTRA-REFERENCIA INTERINSTITUCIONAL

- **Etnia**: se debe anotar lo que la persona indique ya que esto corresponde a una autodeterminación: indígena, negra, afrodescendiente o mulata, de origen oriental [asiática], blanca o mestiza u otro.
- **Persona con discapacidad**: se debe anotar si o no tiene ninguna discapacidad y especificar el tipo: discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad cognitiva o discapacidad psicosocial. Considere lo siguiente:

Discapacidad	Descripción
Deficiencia auditiva	Las personas presentan pérdida total o parcial permanente de la audición, de uno o ambos oídos. Incluye: hipoacusia (persona que presenta residuos auditivos) y anacusia (sordera total). Excluye: Aquellas deficiencias que puedan ser temporales de la audición o corregidas con audífono.
Deficiencia visual	Consiste en la pérdida total o parcial permanente de la visión y puede ser de uno o ambos ojos. Incluye: Cataratas, glaucomas, retinosis, desprendimiento de retina, entre otras. Excluye aquellas deficiencias que puedan corregirse con lentes de contacto o con anteojos.
Discapacidad Física	Las personas presentan pérdida, carencia o anormalidad en el funcionamiento del sistema músculo esquelético o nervioso, que las limitan permanentemente para las actividades diarias. Incluye: Todo tipo de amputaciones, artrofias musculares, artritis reumatoidea, artrosis, osteomielitis, dificultad para la marcha, pie Bott, genu valgu, quemaduras de 2do., 3er., y 4to. grado, epilepsia, parkinson, miastenia gravis, parálisis cerebral infantil, hemiplejía, paraplejía, diplejía, monoplejía, cuadraplejía o tetraplejía, charcot marie tooth, distrofia muscular progresiva, encefalopatías, poliomelitis, microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia. Excluye: Aquellas que no sean de carácter permanente
Discapacidad cognitiva	Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo, expresadas tanto en las destrezas adaptativas conceptuales, como en las sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años de edad. Incluye: todos los grados de retardo mental (leve, moderado, severo, profundo), síndrome down, podría estar asociado a hidrocefalia o parálisis cerebral, entre otros. Excluye: Problemas de aprendizaje, autismo y déficit atencional
Discapacidad psicosocial	Conjunto de síntomas psicopatológicos identificables, que interfieren en el desarrollo personal, laboral y social de la persona, de manera diferente en intensidad y duración. Incluye: Trastornos mentales orgánicos, autismo, esquizofrenias y trastornos psicóticos, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, adaptativos y somatomorfos, disociativos y de personalidad. Debe tener tratamiento psicológico o medicado. Excluye: las depresiones, estrés u otros estados de ánimo transitorios o los conocidos popularmente como estados nerviosos.

- **Dirección exacta del lugar de residencia**: indicar provincia, cantón, distrito y otras señas.
- **Si la persona es menor de edad**: anote el nombre y apellidos de la madre, padre o persona responsable, el número de identificación, teléfonos, escolaridad, indique si es una persona con discapacidad y etnia. Para estas últimas siga lo indicado anteriormente.

4. **Acciones realizadas en CEN-CINAI y recomendaciones**: puntualice las acciones realizadas desde que se recibió la referencia. Detalle si la persona fue incluida en los servicios y las acciones realizadas. En caso de que no se haya incluido en los servicios, detalle las razones.
5. **Nombre de la persona funcionaria que realiza la contra referencia:** anote los datos solicitados.
6. **El recuadro debe ser completado por la persona funcionaria de la Institución que recibe la contra-referencia,** con nombre, fecha, cargo, número de denuncia y sello institucional.

DT-Versión actualizada mayo 2024

Anexo 5a. Boleta de denuncia

CEN-CINAI	DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo	Código: DNCC-DT-UIVCD-F-04 Fecha: setiembre, 2025
	DENUNCIA	Versión: 1

DNCC-DR_____-OL-_____-DEN-_____-20_____ **1. Fecha** ____/____/_____ (Día / Mes / Año)

2. Lugar donde se presenta la denuncia:

❑Fiscalía / Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de: _____

❑Si es menor de edad, con copia al PANI de: _____

3. Datos generales de la persona que recibe servicios en CEN-CINAI (presuntamente vulnerada en sus derechos):

Nombre y apellidos: _____

No. de identificación: _____ Teléfono: _____

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____/ (Día / Mes / año) Edad: _____/_____ (año / meses) Sexo: _____

Escolaridad: _____Etnia: _____
Persona con Discapacidad: ❑ No ❑ Sí: _____
Dirección exacta del lugar de residencia: Provincia: _____
Cantón: _____ Distrito: _____

Otras señas: _____

_____

Nombre del establecimiento CEN-CINAI o comunidad donde recibe servicios:
_____

Modalidad de atención que recibe:

❑ Atención y Protección Cotidiana ❑ Vínculo Persona Adulta-Adolescente-niña-niño ❑Leche 1,6k

❑ Desarrollo de Habilidades para la vida ❑Sólo Comidas Servidas ❑Distribución de Alimentos a Familias

Si la persona es menor de edad, indique el nombre y apellidos de la madre, padre o persona responsable:
_____No. de identificación: _____

Teléfono: _____ Escolaridad: _____
Etnia:_____ Persona con Discapacidad: ❑ No ❑ Sí: _____

CEN-CINAI	DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo	Código: DNCC-DT-UIVCD-F-04 Fecha: setiembre, 2025
	DENUNCIA	Versión: 1

4. **Motivo por el que se presenta la denuncia**:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5. **Cuando se tiene identificada a la persona presunta responsable de los hechos, indicar**:

Nombre (o conocido/a cómo): _____

Edad: _____Sexo: _____ Nacionalidad: _____

Relación con la persona que recibe servicios en CEN-CINAI: _____

Datos para ubicación: _____

6. **Nombre y apellidos de la persona funcionaria que presenta la denuncia**: _____

Cargo que desempeña en CEN-CINAI: _____

Teléfono de contacto: _____Correo electrónico: _____

7. **Para seguimiento institucional del caso**:

Nombre de profesional de Oficina Local: _____

Número de identificación: _____ Disciplina: _____

Oficina Local: _____Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

8. **Este espacio lo completa la institución ante la cual se presenta la denuncia:**

Nombre de la persona que recibe la denuncia: _____

Fecha: _____ Cargo: _____

Número de denuncia: _____ sello

Anexo 5b. Instructivo boleta de denuncia

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA DENUNCIA

Indicaciones generales:

a) Recuerde que, toda persona funcionaria pública y que trabaje en el ámbito de la salud y la educación, tanto pública como privada, están en obligación de denunciar (Art 175 Código Procesal Penal), por lo que, cuando tenga conocimiento de situaciones de alto riesgo, de los que se sospeche o confirme cualquier manifestación de violencia que atente contra el bienestar, la salud o la vida de las personas usuarias, debe proceder con la denuncia respectiva.

b) En caso de identificar situaciones de violencia, agresión, abuso, maltrato u otra manifestación contra los derechos de las personas menores de edad, de acuerdo al art. 49 del código de la niñez y la adolescencia, Ley 7739, Denuncia de maltrato o abuso: "Los directores y el personal encargado de los centros de salud, públicos y privados, adonde se lleven menores de edad para atenderlas, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra ellas. Igual obligación tendrán las autoridades y en personal de centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se atiendan o se preste algún servicio a estas personas".

c) Si la situación requiere de atención urgente, se coordina Atención Inmediata con el 9-1-1

d) Entrega la Boleta de denuncia a la institución correspondiente y deja copia para el expediente en Oficina Local para el seguimiento respectivo.

e) En atención interdisciplinaria en Oficinal Local, se realiza la coordinación de acciones y seguimiento del caso, según corresponda.

f) Toda persona funcionaria es responsable de utilizar la información adquirida, de manera confidencial y privada, única y exclusivamente para los fines de cumplimiento de las actividades, tales como realizar denuncia, referencia y contra referencia. Por tanto, no se revelará, comentará ni divulgará a terceros la información confidencial y privada adquirida en el cumplimiento de funciones.

Indicaciones específicas:

0. **Número de Consecutivo**: en este espacio se debe anotar la signatura de la unidad que produce el documento. Para ello, y dada la particularidad del proceso, solicite a la Oficina Local el número de consecutivo y anótelo en la denuncia, siguiendo el respectivo tipo documental: Siglas de la Dirección Regional, Número de la Oficina Local, número de denuncia y año: DNCC-DR___-OL____-DEN-_____-20_____ (ejemplo: DNCC-DRBR-OL501-DEN-001-2023). La Oficina Local, debe llevar un control de los consecutivos de denuncia que se tramitan.
1. **Fecha**: Anote la fecha en la cual se elabora la boleta de referencia: día, mes y año.
2. **Lugar donde se presenta la denuncia**: corresponde a la Fiscalía Local del lugar donde ocurrieron los hechos, considerando que la Fiscalía recibe denuncias de lunes a viernes, en un horario de 7:30 am a 4:30 pm. Si el hecho sucedió después de las 4:30 pm, en un día feriado, durante Semana Santa o vacaciones navideñas, denuncie en la Oficina más cercana del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que está disponible las 24 horas. Marque e indique el lugar donde interpone denuncia, ejemplo, ☒Fiscalía de Pococí.
   Si la persona es menor de edad, indique además la oficina del PANI a la que se envía copia la denuncia. Si la persona es menor de edad, indique la información solicitada de la madre, padre o persona responsable
3. **Datos generales de la persona que recibe servicios en CEN-CINAI**: anote la información lo más completa posible, de la persona que recibe servicios en CEN-CINAI, presuntamente vulnerada en sus derechos a la que se requiere proteger, a través de la denuncia.
   - **Nombre** completo y los apellidos.
   - **Número de identificación** y teléfono.
   - **Fecha de nacimiento, edad, sexo.**

- **Escolaridad**: anote el nivel y año que corresponde al último año o grado aprobado (mayores de 5 años) dentro de la educación formal:

Niveles	
Ninguno	Para universitaria
Preescolar	Bachillerato
Enseñanza especial	Licenciatura
Primaria	Posgrado
Secundaria académica	Incompleta
Secundaria técnica	Desconocida

- **Etnia**: se debe anotar lo que la persona indique ya que esto corresponde a una autodeterminación: indígena, negra, afrodescendiente o mulata, de origen oriental [asiática], blanca o mestiza u otro.
- **Persona con discapacidad**: se debe anotar si o no tiene ninguna discapacidad y especificar el tipo: discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad cognitiva o discapacidad psicosocial. Considere lo siguiente:

Discapacidad	Descripción
Deficiencia auditiva	Las personas presentan pérdida total o parcial permanente de la audición, de uno o ambos oídos. Incluye: hipoacusia (persona que presenta residuos auditivos) y anacusia (sordera total). Excluye: Aquellas deficiencias que puedan ser temporales de la audición o corregidas con audífono.
Deficiencia visual	Consiste en la pérdida total o parcial permanente de la visión y puede ser de uno o ambos ojos. Incluye: Cataratas, glaucomas, retinosis, desprendimiento de retina, entre otras. Excluye aquellas deficiencias que puedan corregirse con lentes de contacto o con anteojos.
Discapacidad Física	Las personas presentan pérdida, carencia o anormalidad en el funcionamiento del sistema músculo esquelético o nervioso, que las limitan permanentemente para las actividades diarias. Incluye: Todo tipo de amputaciones, artrofias musculares, artritis reumatoidea, artrosis, osteomielitis, dificultad para la marcha, pie Bott, genu valgu, quemaduras de 2do., 3er., y 4to. grado, epilepsia, parkinson, miastenia gravis, parálisis cerebral infantil, hemiplejía, paraplejía, diplejía, monoplejía, cuadraplejía o tetraplejía, charcot marie tooth, distrofia muscular progresiva, encefalopatías, poliomelitis, microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia. Excluye: Aquellas que no sean de carácter permanente
Discapacidad cognitiva	Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo, expresadas tanto en las destrezas adaptativas conceptuales, como en las sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años de edad. Incluye: todos los grados de retardo mental (leve, moderado, severo, profundo), síndrome down, podría estar asociado a hidrocefalia o parálisis cerebral, entre otros. Excluye: Problemas de aprendizaje, autismo y déficit atencional
Discapacidad psicosocial	Conjunto de síntomas psicopatológicos identificables, que interfieren en el desarrollo personal, laboral y social de la persona, de manera diferente en intensidad y duración. Incluye: Trastornos mentales orgánicos, autismo, esquizofrenias y trastornos psicóticos, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, adaptativos y somatomorfos, disociativos y de personalidad. Debe tener tratamiento psicológico o medicado. Excluye: las depresiones, estrés u otros estados de ánimo transitorios o los conocidos popularmente como estados nerviosos.

- **Dirección exacta del lugar de** residencia: indicar provincia, cantón, distrito y otras señas.
- **Nombre del establecimiento o comunidad donde recibe servicios.**
- **Modalidad de atención que recibe**: marque la casilla que corresponda.
- **Si la persona es menor de edad**: anote el nombre y apellidos de la madre, padre o persona responsable, el número de identificación, teléfonos, escolaridad, indique si es una persona con discapacidad y etnia. Para estas últimas siga lo indicado anteriormente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA DENUNCIA

4. **Motivo por el cual se presenta la denuncia**: puntualice con claridad el motivo por el cual se presenta la denuncia. Anote únicamente la información sobre la que sospecha, tiene conocimiento o lo haya sido manifestada la persona presuntamente vulnerada en sus derechos. No se debe profundizar ni realizar investigación, NO realice entrevista, evite revictimizar y obstaculizar la investigación penal.
5. **Cuando se tiene identificada a la persona presunta responsable de los hechos**: indique el nombre y los datos que conoce y faciliten la ubicación. Anote "desconocido" si no se conocen detalles y, de igual manera, procede con la denuncia.
6. **Nombre y apellidos de la persona funcionaria que presenta la denuncia**: anote los datos solicitados.
7. **Para seguimiento institucional del caso**: anote los datos de la persona profesional en psicología o persona designada en la Oficina Local para estos casos.
8. **El recuadro debe ser completado por la persona funcionaria de la Institución que recibe la denuncia**, con nombre, fecha, cargo, número de denuncia y sello institucional.

Versión actualizada mayo 2024.

Anexo 6. Carátula expediente de A.I.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

EXPEDIENTE DE ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA

N° Expediente de Hogar

N° Identificación

Dirección Regional

Oficina Local

Establecimiento

Código

"Crecimiento y Desarrollo Integral para las niñas y los niños"

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

Anexo 7 a. Boleta valoración situacional

	Dirección Nacional de CEN-CINAI Dirección Técnica Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Código: DNCC-DT-UNAT-F-28	
	BOLETA VALORACIÓN SITUACIONAL[1]	Fecha: octubre 2025	Versión: 1

Fecha de sesión interdisciplinaria: _____/_____/_____ (Día / Mes / Año)	
Establecimiento:	**Código del establecimiento:**
Nombre del cliente o beneficiaria:	**N° identificación:**

Valoración Situacional			Nivel de prioridad
Factores de Riesgo	**Factores Protectores**	**Valoración integrada de factores**	☐ **Urgencia**
		☐ Riesgo alto/protección baja	1 Alto
		☐ Riesgo alto /protección moderada	2 Moderado
		☐ Riesgo moderado /protección baja o moderada	
		☐ Riesgo bajo/protección moderada o alta	3 Bajo

Estrategias de Atención Interdisciplinaria

Propósitos de A.I. (intencionalidad del abordaje, aspectos orientadores o líneas de acción)

☐ Visita domiciliar ☐ Atención en contexto ☐ Atención individualizada ☐ Consejería
☐ Atención grupal ☐ Actividades Educativas ☐ Actividades comunitarias ☐ Otras: _____
Referencia interinstitucional: ☐ RISA ☐ Otra institución: _____

Disciplinas para atención y seguimiento de la situación referida

☐ Nutrición ☐ Psicología ☐ Educación Preescolar ☐ Terapia de Lenguaje ☐ Terapia física

Nombre y firma de Equipo Interdisciplinario

Digitado en herramienta: Fecha:_____/_____/_____/ (Día / Mes / Año)

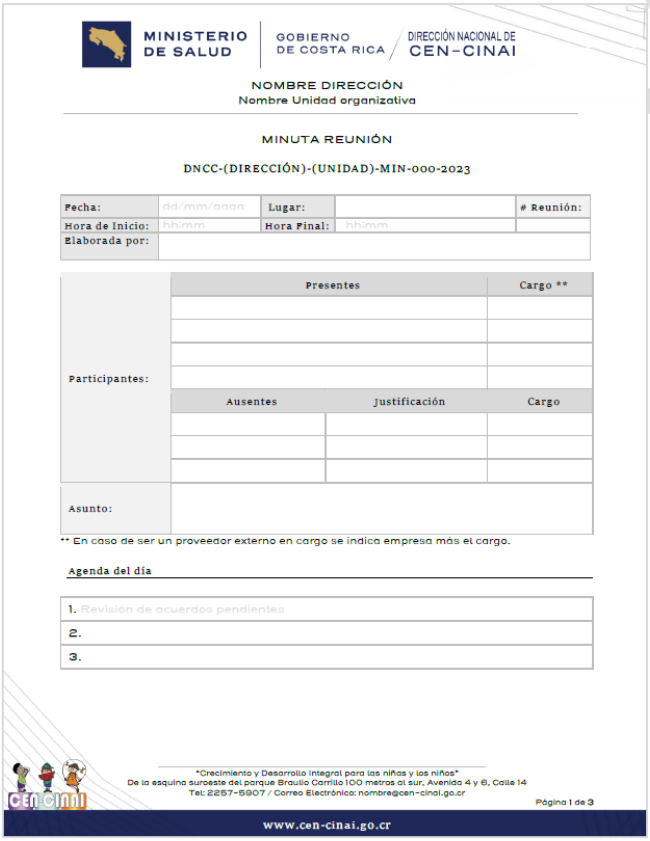
Nombre Nutrición	Nombre Psicología	Nombre Docencia	Nombre Terapia de Lenguaje	Nombre Terapia Física

[1] Instrumento para uso exclusivo de profesionales del E.I

Anexo 7b. Instructivo Boleta valoración situacional

(Sujeto a revisión de boleta, anexo 7a)

Anexo 8. Formato de minuta de la sesión interdisciplinaria



MINISTERIO DE SALUD | GOBIERNO DE COSTA RICA | DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

NOMBRE DIRECCIÓN
Nombre Unidad organizativa

MINUTA REUNIÓN

DNCC-(DIRECCIÓN)-(UNIDAD)-MIN-000-2023

Fecha:	dd/mm/aaaa	Lugar:		# Reunión:
Hora de Inicio:	hh:mm	Hora Final:	hh:mm	
Elaborada por:				

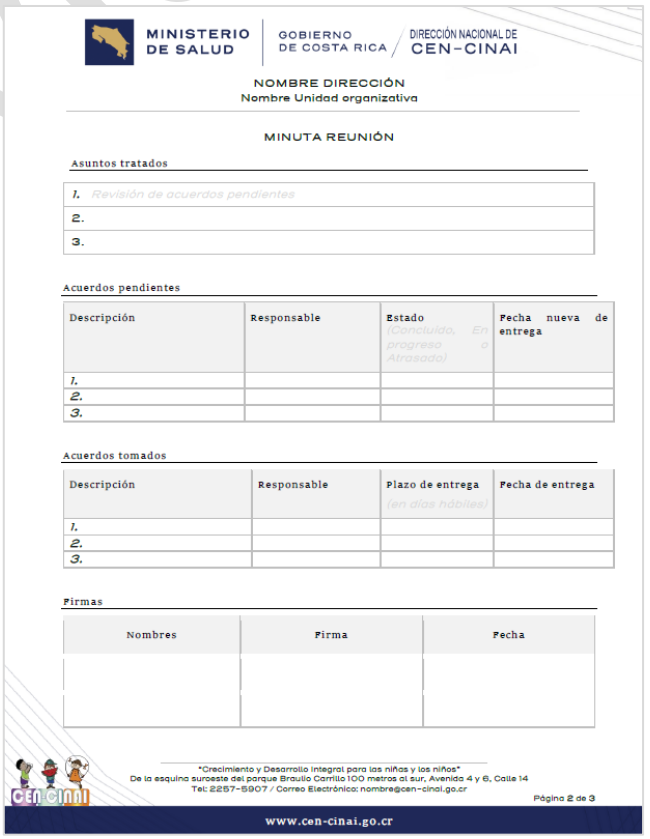
Participantes:	Presentes		Cargo **
	Ausentes	Justificación	Cargo
Asunto:			

** En caso de ser un proveedor externo en cargo se indica empresa más el cargo.

Agenda del día

1. Revisión de acuerdos pendientes
2.
3.

"Crecimiento y Desarrollo Integral para las niñas y los niños"
De la esquina suroeste del parque Braulio Carrillo 100 metros al sur, Avenida 4 y 6, Calle 14
Tel: 2257-5907 / Correo Electrónico: nombre@cen-cinai.go.cr
Página 1 de 3
www.cen-cinai.go.cr



MINISTERIO DE SALUD | GOBIERNO DE COSTA RICA | DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

NOMBRE DIRECCIÓN
Nombre Unidad organizativa

MINUTA REUNIÓN

Asuntos tratados

1. Revisión de acuerdos pendientes
2.
3.

Acuerdos pendientes

Descripción	Responsable	Estado (Concluido, En progreso o Atrasado)	Fecha nueva de entrega
1.			
2.			
3.			

Acuerdos tomados

Descripción	Responsable	Plazo de entrega (en días hábiles)	Fecha de entrega
1.			
2.			
3.			

Firmas

Nombres	Firma	Fecha

"Crecimiento y Desarrollo Integral para las niñas y los niños"
De la esquina suroeste del parque Braulio Carrillo 100 metros al sur, Avenida 4 y 6, Calle 14
Tel: 2257-5907 / Correo Electrónico: nombre@cen-cinai.go.cr
Página 2 de 3
www.cen-cinai.go.cr

Anexo 9. Reporte de atención interdisciplinaria

(Sujeto a Herramienta o Sistema)

Anexo 10. Guía de revisión de la herramienta

(Sujeto a Herramienta o Sistema)

Anexo 11a. Registro de eventos y situaciones

CEN-CINAI	**DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI** Dirección Técnica Unidad de Normalización y Asistencia Técnica	Código: DNCC-DT-UNAT-F-18 Fecha: agosto 2025
	REGISTRO DE EVENTOS Y SITUACIONES	Versión: 01

Fecha ____ ____ ____ Nombre del cliente o beneficiaria: _____
Día Mes Año

Descripción de la situación o evento reportado:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____ _____ _____
Nombre de la persona que realiza la anotación | Cargo | Firma

_____ _____ _____
Nombre de la persona encargada (cuando se requiera) | Parentesco | Firma

Impresión: Imprenta Nacional

Anexo 11b. Instructivo Registro de eventos y situaciones

(pendiente)

En revisión

Anexo 12a. Boleta de notificación obligatoria VE-01

MINISTERIO DE SALUD, COSTA RICA- DVS

BOLETA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA VE-01

Ministerio de Salud

Número de cédula o identificación				
Nombre del paciente				
Diagnóstico de notificación				
Diagnóstico específico				
Fecha inicio del evento / síntomas	Día	Mes	Año	
Fecha de diagnóstico	Día	Mes	Año	
Sexo:	Masculino	Femenino	Etnia	
Fecha Nacimiento	Día	Mes	Año	
Edad Cumplida	Años	Meses	Días	
Nacionalidad:			Ocupación	
Nombre del padre, madre o encargado (solo en caso de menores de < 18 años, o persona con discapacidad				
Residencia	Provincia	Cantón	Distrito	Localidad
Dirección Exacta				
Teléfono Casa / Celular				
Lugar de Trabajo				
Localización lugar Trabajo	Provincia	Cantón	Distrito	Localidad
Lugar de ocurrencia	Provincia	Cantón	Distrito	Localidad
Establecimiento que informa				
Nombre de la persona que informa				
Firma de paciente:				
Para atender notificaciones Correo electrónico o fax:				

Anexo 12b. Instructivo de llenado Boleta de notificación obligatoria VE-01

(Pendiente)

En revisión